

Buku Referensi
**KEPEMIMPINAN DAN
PROFESIONALISME BIDAN**
Dalam Sistem Kesehatan Nasional

Anisah Tifani Maulidyanti • Imelda Diana Marsilia • Yuni Vivi Santri P
Endang Mayasari • Gusti Ayu Martha Winingsih



BUKU REFERENSI

KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALISME

BIDAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Penulis

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Yuni Vivi Santri P, SKM., S.Keb., MKM.

Endang Mayasari, SST., M.Kes.

Dr. Bdn. Gusti Ayu Martha Winingsih, S.ST., MM., M.Kes.

**Buku Referensi : Kepemimpinan Dan Profesionalisme Bidan
Dalam Sistem Kesehatan Nasional**

Penulis:

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Yuni Vivi Santri P, SKM., S.Keb., MKM.
Endang Mayasari, SST., M.Kes.
Dr. Bdn. Gusti Ayu Martha Winingsih, S.ST., MM., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7556-90-5

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul *Kepemimpinan dan Profesionalisme Bidan dalam Sistem Kesehatan Nasional* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya literatur kebidanan, khususnya dalam penguatan kapasitas kepemimpinan, profesionalisme, serta peran strategis bidan dalam sistem kesehatan nasional.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki posisi sentral dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, bidan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga integritas moral, pemahaman regulasi, kemampuan manajerial, serta kepemimpinan yang adaptif terhadap dinamika sistem kesehatan. Oleh karena itu, penguatan aspek kepemimpinan dan profesionalisme menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

Buku ini mengulas berbagai aspek penting yang relevan dengan praktik kebidanan masa kini. Pembahasan mengenai profesionalisme dan etika kebidanan menegaskan pentingnya nilai, norma, dan tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selanjutnya, topik regulasi dan hukum praktik kebidanan memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan hukum, kewenangan, serta perlindungan hukum bagi bidan dalam menjalankan praktik profesionalnya.

Pada aspek manajerial, pembahasan tentang manajemen praktik mandiri bidan diarahkan pada pengelolaan layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk pengelolaan sumber daya, administrasi, dan mutu pelayanan. Sementara itu, kepemimpinan dalam pelayanan maternal menyoroti peran bidan sebagai pemimpin klinis yang mampu mengambil keputusan tepat, membangun tim yang solid, serta mendorong budaya keselamatan dalam pelayanan.

Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi interprofesional sebagai kunci keberhasilan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Dalam sistem kesehatan nasional, sinergi antara bidan dan tenaga kesehatan lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas asuhan dan keberlanjutan pelayanan. Selain itu, isu burnout dan kesejahteraan bidan dibahas sebagai refleksi atas tantangan beban kerja dan tekanan profesional yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan, sehingga diperlukan strategi menjaga kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi berkelanjutan, topik pengembangan karier dan pendidikan berkelanjutan menegaskan pentingnya

pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) bagi bidan untuk tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan kesehatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, praktisi, pengelola layanan kesehatan, serta pemangku kebijakan. Semoga buku ini turut berkontribusi dalam membangun bidan yang profesional, beretika, berjiwa pemimpin, dan mampu berperan aktif dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi selanjutnya.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia.

(Mei, 2026)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB 1 PROFESIONALISME DAN ETIKA KEBIDANAN	 1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Profesionalisme Bidan.....	3
C. Landasan Etika Kebidanan.....	4
D. Nilai Inti Profesionalisme Bidan.....	5
E. Kode Etik, Hukum, dan Standar Profesi Bidan	8
F. Dilema Etik dalam Praktik Kebidanan	9
G. Langkah Pengambilan Keputusan Etik.....	10
H. Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan	11
I. Profesionalisme dalam Komunikasi, Informed Consent, Dokumentasi, dan Kerahasiaan	12
J. Kepemimpinan Profesional Bidan dalam Praktik Kebidanan.....	13
K. Pengembangan Profesional Berkelanjutan, Refleksi, dan Mutu Layanan	15
L. Tantangan Profesionalisme dan Etika Bidan di Era Kontemporer	16
M. Studi Kasus.....	17
N. Penutup.....	19
Referensi	20
Glosarium.....	22
 BAB 2 REGULASI DAN HUKUM PRAKTIK KEBIDANAN.....	 24
A. Pendahuluan.....	24
B. Teori Regulasi Dan Hukum Praktek Kebidanan.....	26
C. Landasan Hukum Praktik Kebidanan Di Indonesia.....	38
D. Kewenangan Bidan.....	43
E. Hak Dan Kewajiban Bidan.....	44
F. Standar Praktik Kebidanan	45
G. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan	46
H. Malpraktik Dalam Kebidanan	47
I. Perlindungan Hukum bagi Bidan.....	48
J. Etika Profesi Kebidanan.....	49
K. Tantangan dalam Implementasi.....	50
Referensi	52

BAB 3 MANAJEMEN PRAKTIK MANDIRI BIDAN	54
A. Pendahuluan.....	54
B. Pengertian dan Peran manajemen praktik Bidan	54
C. Tahap Manajemen praktik mandiri kebidanan	55
D. Aspek-Aspek Utama Manajemen Praktik mandiri Sesuai Permenkes.....	56
E. Persyaratan pendirian praktik mandiri bidan	58
F. Pelayanan yang diberikan bidan praktik mandiri	58
G. aspek-aspek penting dalam pengembangan manajemen praktik mandiri bidan:	59
H. Mutu dan keselamatan pasien.....	59
I. Penutup.....	60
Referensi	61
 BAB 4 KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN MATERNAL: STRATEGI	
MENINGKATKAN KUALITAS ASUHAN IBU DAN BAYI.....	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Definisi dan Konsep Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal	64
C. Gaya Kepemimpinan yang Relevan dalam Pelayanan Maternal	68
D. Fungsi dan Peran Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal.....	75
E. Kepemimpinan dan Keselamatan Ibu dalam Pelayanan Maternal	82
F. Tantangan Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal di Indonesia	87
G. Penutup.....	96
Referensi	98
 BAB 5 PENGEMBANGAN KARIER DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN.....	104
A. Pendahuluan.....	104
B. Profesionalisme Bidan dalam Pelayanan Kesehatan.....	105
C. Implementasi Profesionalisme Bidan	107
D. Fungsi dan Peran Sistem Informasi Kesehatan	109
E. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Kebidanan	110
F. Integrasi Kepemimpinan dan Profesionalisme	121
G. Penutup.....	123
Referensi	125
 PROFIL PENULIS.....	126

BAB 1

PROFESIONALISME DAN ETIKA KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Profesionalisme dan etika kebidanan sebagai landasan praktik bidan yang aman, bermutu, berpusat pada perempuan, dan bertanggung jawab secara ilmiah, moral, legal, dan sosial. Struktur pembahasan dikembangkan agar dapat digunakan sebagai bahan ajar, referensi, dan pengayaan bagi mahasiswa, bidan klinik, bidan praktik mandiri, maupun pendidik kebidanan.

Profesionalisme dan etika merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik kebidanan. Bidan tidak hanya dituntut mampu melakukan tindakan klinik yang benar, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan yang bermartabat, menghormati hak perempuan, melindungi keselamatan ibu dan bayi, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara ilmiah, etik, dan hukum (ICM, 2014). Dalam praktik sehari-hari, profesionalisme tercermin dalam komunikasi yang efektif, dokumentasi asuhan, penghormatan terhadap otonomi perempuan, serta kolaborasi interprofesional (Marshall, 2020). Etika menyediakan kerangka nilai dan prinsip moral yang membimbing bidan dalam menghadapi dilema klinis yang kompleks, termasuk konflik antara keselamatan pasien, nilai budaya, dan keterbatasan sumber daya (RI, 2020).

Secara global, *International Confederation of Midwives* menempatkan perempuan, bayi baru lahir, keluarga, dan komunitas sebagai pusat tanggung jawab profesi bidan. Kode etik ICM menegaskan bahwa bidan harus bekerja berlandaskan rasa hormat, keadilan, hak asasi manusia, kepercayaan, dan martabat manusia, serta memajukan kesehatan perempuan dan bayi baru lahir di seluruh siklus reproduksi perempuan (ICM, 2014). WHO juga menekankan bahwa pendidikan dan praktik kebidanan yang berkualitas merupakan salah satu solusi penting untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan maternal dan neonatal, dan mutu tersebut tidak cukup diukur dari luaran klinis saja, tetapi juga dari pengalaman perempuan menerima asuhan yang aman, menghormati, dan berpusat pada dirinya (WHO, 2025).

Di Indonesia, profesionalisme bidan tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang hingga saat ini masih berlaku sebagai dasar hukum praktik

kebidanan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa praktik kebidanan merupakan pemberian pelayanan dalam bentuk asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab profesinya. Sementara itu, Standar Profesi Bidan menegaskan bahwa lulusan bidan harus mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etik, legal, dan keselamatan klien untuk perwujudan profesionalisme bidan (RI, 2020). Dengan demikian, profesionalisme dan etika kebidanan bukan tambahan di luar praktik, melainkan jantung dari praktik kebidanan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan sistem pelayanan kesehatan global, tuntutan terhadap profesionalisme bidan semakin meningkat. Bidan tidak hanya dituntut memiliki keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan dalam pengambilan keputusan etis, komunikasi interpersonal, serta kepemimpinan dalam praktik pelayanan (WHO, 2025). Kondisi ini menuntut bidan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan serta menjaga integritas profesi dalam berbagai situasi pelayanan (Indah Kurniawati, 2021).

Bab ini disusun sebagai bagian dari buku referensi *Kepemimpinan dan Profesionalisme Bidan dalam Praktik Kebidanan*. Oleh karena itu, pembahasannya tidak hanya menekankan pada pengertian profesionalisme dan kode etik, tetapi juga menjelaskan bagaimana kesadaran nilai-nilai profesional dibentuk, dijaga, diuji, dan dikembangkan dalam praktik kebidanan sehari-hari. Pembahasan mencakup hubungan bidan dengan perempuan dan keluarga, kerja sama dalam tim kesehatan, pengambilan keputusan saat menghadapi dilema klinis, dokumentasi asuhan, penggunaan media digital secara profesional, serta pentingnya supervisi, audit, dan budaya keselamatan. Melalui pembahasan tersebut, pembaca diharapkan tidak hanya memahami konsep profesionalisme dan etika kebidanan secara teoritis, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab profesi bidan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien juga memberikan implikasi terhadap praktik kebidanan. Pasien kini lebih kritis dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan, termasuk aspek etika, penghormatan terhadap martabat, dan profesionalisme tenaga kesehatan (ICM, 2014). Oleh karena itu, bidan dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sikap profesional yang mencerminkan nilai etik, legal, keselamatan klien, komunikasi efektif, dan pengembangan diri dalam setiap tindakan (RI, 2020).

B. Konsep Profesionalisme Bidan

Profesionalisme bidan adalah seperangkat nilai, perilaku, komitmen, dan kompetensi yang menunjukkan bahwa bidan menjalankan praktik berdasarkan standar profesi, bukti ilmiah, kode etik, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat perempuan, bayi, serta keluarga. (ICM, International Code of Ethics for Midwives, 2014). Profesionalisme mencakup lebih dari sekadar keterampilan teknis; ia juga meliputi cara berpikir, integritas moral, kesadaran batas kewenangan, kemampuan refleksi, serta konsistensi dalam menjaga mutu asuhan (Marshall, 2020). Dalam *midwifery* modern, profesionalisme juga sangat terkait dengan kemampuan menyediakan *woman centred care*, menghormati pilihan dan pengalaman perempuan, dan memfasilitasi kehamilan serta persalinan yang aman dan bermakna (Crepinsek, 2023).

Hasil penelitian Crepinsek et al. menunjukkan bahwa *woman-centred care* dalam standar profesional kebidanan merupakan konsep multidimensional yang mencakup penghormatan terhadap otonomi perempuan, hubungan bidan–perempuan yang setara, komunikasi yang bermakna, individualisasi asuhan, serta pengakuan terhadap konteks sosial dan budaya perempuan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa profesionalisme bidan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur klinis, tetapi juga dari kemampuan bidan membangun hubungan asuhan yang menghargai perempuan sebagai subjek aktif dalam proses kehamilan, persalinan, dan nifas. Dengan demikian, profesionalisme bidan harus dipahami sebagai perpaduan antara kompetensi klinis, kesadaran etik, komunikasi terapeutik, dan penghormatan terhadap martabat perempuan (Crepinsek, 2023).

Dalam tinjauan global terhadap standar profesional kebidanan, *woman-centred care* muncul sebagai unsur sentral yang mengikat berbagai dimensi profesionalisme. (Crepinsek, 2023), menunjukkan bahwa makna *woman centred care* dalam standar profesi kebidanan secara global mencakup penghormatan pada otonomi perempuan, hubungan terapeutik yang setara, komunikasi yang bermakna, individualisasi asuhan, dan pengakuan terhadap konteks sosial-budaya perempuan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa profesionalisme bidan tidak cukup diukur dari kepatuhan pada prosedur, tetapi juga dari cara bidan menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam asuhan, bukan objek pelayanan.

Profesionalisme juga berarti kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan praktik yang aman dan manusiawi. Dalam konteks maternitas, bidan perlu membuat keputusan yang cepat namun tetap etis, terutama pada situasi

gawat darurat, ketidakpastian klinis, atau keterbatasan fasilitas. Hal ini menuntut penalaran klinis, kesadaran etik, dan kemampuan membedakan kapan bidan harus bertindak mandiri, kapan harus berkonsultasi, dan kapan harus merujuk. Profesionalisme, karena itu, selalu bersifat dinamis; ia tumbuh melalui pendidikan, pengalaman praktik, supervisi, refleksi, dan evaluasi diri yang berkelanjutan. (Qatrunnada Naqiyyah Khusmitha, 2025)

Profesionalisme bidan juga memiliki dimensi sosial. Bidan bukan hanya penyedia layanan klinik, tetapi juga pendidik, advokat, komunikator, kolaborator, dan agen perubahan dalam kesehatan perempuan serta bayi. Seorang bidan profesional harus peka terhadap kerentanan sosial, ketidakadilan layanan, kekerasan berbasis gender, hambatan akses, dan kebutuhan perempuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, profesionalisme bertemu langsung dengan kepemimpinan klinik: bidan diharapkan dapat memengaruhi kualitas layanan melalui teladan, komunikasi, pengambilan keputusan yang baik, dan komitmen terhadap keselamatan serta mutu. (Proboningdyah, 2024)

C. Landasan Etika Kebidanan

Etika kebidanan adalah cabang etika terapan yang membahas prinsip moral, nilai profesi, dan pertimbangan tindakan benar-salah dalam praktik kebidanan. Etika memberikan arah ketika standar teknis saja tidak cukup, misalnya saat bidan harus memilih antara beberapa alternatif yang sama-sama memiliki konsekuensi, atau ketika keinginan perempuan, penilaian klinis, budaya keluarga, dan keterbatasan sistem saling bertabrakan. Karena itu, etika kebidanan tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi harus diinternalisasi sebagai kebiasaan profesional dalam mengambil keputusan. (Astri Ulina Saragih, 2021)

Empat prinsip etika yang umum digunakan dalam pelayanan Kesehatan *autonomy*, *beneficence*, *non maleficence*, dan *justice* sangat relevan dalam kebidanan. Prinsip *autonomy* menuntut bidan menghormati hak perempuan untuk memperoleh informasi yang benar, memahami pilihan, dan mengambil keputusan tentang tubuh dan asuhannya. *Beneficence* menuntut bidan bertindak demi kebaikan ibu dan bayi. *Non maleficence* menuntut bidan mencegah bahaya, termasuk bahaya akibat tindakan yang tidak perlu, keterlambatan rujukan, pelanggaran privasi, atau komunikasi yang merendahkan. *Justice* menuntut keadilan, yaitu asuhan yang tidak diskriminatif dan akses yang layak bagi semua perempuan. (Astri Ulina Saragih, 2021)

Penelitian Butler et al. mengenai kompetensi *respectful maternity care* menunjukkan bahwa perilaku profesional yang paling penting bagi bidan meliputi

penghormatan terhadap martabat perempuan, pemberian informasi yang jelas, dukungan terhadap pilihan yang diinformasikan, komunikasi empatik, perlindungan privasi, serta pelayanan yang bebas dari diskriminasi dan perlakuan tidak bermartabat. Temuan tersebut menegaskan bahwa etika kebidanan tidak hanya berupa prinsip moral abstrak, tetapi harus tampak dalam perilaku nyata bidan saat memberikan asuhan. Oleh karena itu, penerapan etika dalam praktik kebidanan perlu diarahkan pada pengalaman perempuan yang aman, dihormati, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Butler, 2020)

Selain prinsip-prinsip umum, kebidanan memiliki nuansa etik yang khas karena menyangkut relasi bidan dengan perempuan yang sedang menjalani pengalaman reproduksi, persalinan, nyeri, kerentanan, dan keputusan yang sering melibatkan keluarga. kompetensi *respectful maternity care* yang dipandang paling penting oleh *midwives* dunia mencakup menjaga martabat perempuan, menghormati pilihan yang diinformasikan, memberikan komunikasi yang empatik, menjaga privasi dan kerahasiaan, serta menunjukkan perilaku profesional yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Dengan demikian, etika kebidanan sangat erat dengan penghormatan terhadap pengalaman perempuan selama asuhan. (Butler, 2020)

Kode etik profesi mengubah nilai-nilai etik menjadi pedoman yang lebih operasional. ICM *Code of Ethics for Midwives* memberikan arah terkait kewajiban bidan kepada perempuan, keluarga, masyarakat, kolega, profesi, dan dirinya sendiri. Dalam konteks Indonesia, kode etik profesi bidan yang ditetapkan oleh organisasi profesi juga menjadi pedoman moral dalam hubungan dengan klien, teman sejawat, profesi lain, masyarakat, dan negara. Etika kebidanan, dengan demikian, bekerja pada tiga level sekaligus: level nilai personal, level standar profesi, dan level tanggung jawab sosial profesi. (ICM, 2020)

D. Nilai Inti Profesionalisme Bidan

Ada sejumlah nilai inti yang berulang muncul dalam berbagai standar profesi kebidanan dan literatur etika kebidanan. Nilai-nilai yang perlu dipahami sebagai kompetensi moral sekaligus perilaku nyata dalam praktik: (WHO, 2025) (Kabirian, 2024)

1. Hormat terhadap martabat dan hak perempuan. Ini berarti bidan menghargai setiap perempuan sebagai pribadi utuh dengan hak untuk didengar, dihormati, dilibatkan dalam keputusan, dan dilayani tanpa kekerasan, intimidasi, atau diskriminasi. WHO melalui kompendium *respectful maternal and newborn care* menegaskan bahwa asuhan maternitas harus aman, setara, penuh hormat,

berlandaskan kepercayaan, melindungi privasi, dan responsif terhadap konteks sosial-budaya perempuan

2. Kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan. Profesionalisme tidak bisa dipertahankan tanpa pembaruan pengetahuan dan keterampilan. Bidan wajib bekerja sesuai kompetensi, menggunakan praktik berbasis bukti, serta mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan. Dalam praktik, ini mencakup membaca pedoman mutakhir, ikut pelatihan, melakukan refleksi kasus, dan bersikap terbuka terhadap umpan balik.
3. Akuntabilitas. Bidan profesional harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, dan kelalaiannya. Akuntabilitas tercermin pada dokumentasi yang baik, kejujuran klinis, kesediaan melaporkan insiden, dan keberanian meminta bantuan atau merujuk ketika kasus melebihi kapasitas. Akuntabilitas juga berarti tidak menyalahgunakan kepercayaan pasien, tidak melakukan tindakan di luar kewenangan, dan tidak menutupi kesalahan.
4. Integritas dan kejujuran. Integritas berarti keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Dalam kebidanan, integritas tampak ketika bidan jujur menyampaikan kondisi klinis, tidak memanipulasi informasi, tidak melakukan prosedur tanpa indikasi demi alasan finansial atau kebiasaan, dan tidak memalsukan dokumentasi.
5. Kolaborasi dan respek antarprofesi. Kebidanan modern berlangsung dalam sistem layanan yang melibatkan dokter, perawat, tenaga gizi, apoteker, psikolog, kader, dan tenaga lain. Bidan yang profesional mampu bekerja sama tanpa kehilangan identitas profesinya, menghormati disiplin lain, tetapi juga mampu mengadvokasi perempuan ketika diperlukan.
6. Kerahasiaan dan privasi. Data dan pengalaman reproduksi perempuan sangat sensitif. Profesionalisme menuntut bidan menjaga kerahasiaan informasi, membatasi akses hanya bagi pihak yang berwenang, dan tidak mendiskusikan kasus secara sembarangan, termasuk di media sosial.
7. Refleksi diri dan kerendahan hati profesional. Profesionalisme bukan citra tanpa cela, melainkan kesediaan untuk belajar dari pengalaman, mengakui keterbatasan, memperbaiki diri, dan terus bertumbuh. Literatur tentang pendidikan etik pada mahasiswa kebidanan menunjukkan bahwa pengembangan etika profesional membutuhkan refleksi berulang, diskusi kasus, keteladanan dosen dan preceptor, serta pengalaman klinik yang dibimbing dengan baik.

Lebih lengkapi penerapan contoh nilai profesionalisme terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1 Nilai Inti Profesionalisme Bidan dan Contoh Perilaku

Nilai inti	Makna	Contoh perilaku profesional
Hormat pada martabat perempuan	Mengakui perempuan sebagai subjek aktif yang memiliki hak, preferensi, dan pengalaman unik.	Menjelaskan tindakan sebelum dilakukan, meminta persetujuan, menjaga privasi, tidak merendahkan atau memaksa.
Kompetensi	Bekerja sesuai bukti ilmiah, standar profesi, dan kewenangan.	Melakukan pengkajian komprehensif, menggunakan pedoman mutakhir, merujuk tepat waktu.
Akuntabilitas	Mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan.	Dokumentasi lengkap, pelaporan insiden, jujur pada keterbatasan.
Kerahasiaan	Melindungi informasi sensitif ibu dan bayi.	Tidak membahas kasus sembarangan, mengamankan rekam medis, berhati-hati di media sosial.
Kolaborasi	Bekerja efektif dengan profesi lain demi keselamatan pasien.	Komunikasi SBAR, konsultasi tepat waktu, menghargai kompetensi profesi lain.
Refleksi dan belajar berkelanjutan	Terus memperbarui diri dan belajar dari pengalaman.	Audit kasus, pelatihan, membaca guideline, meminta umpan balik.

Kabirian et al. dalam studi kualitatif tentang pengembangan etika profesional pada mahasiswa kebidanan menemukan bahwa pembentukan etika profesional terjadi melalui proses pembelajaran interaktif, pengalaman klinik, penalaran moral, refleksi, serta keteladanan dari dosen dan pembimbing klinik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme bidan tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang melalui proses pendidikan, internalisasi nilai, pembiasaan perilaku etis, dan pengalaman langsung di lingkungan praktik. Temuan tersebut relevan untuk menegaskan bahwa pendidikan kebidanan perlu memberikan ruang bagi diskusi kasus, refleksi etik, supervisi, dan role model profesional agar mahasiswa mampu membangun identitas profesi yang kuat (Kabirian, 2024).

E. Kode Etik, Hukum, dan Standar Profesi Bidan

Hubungan antara kode etik, hukum, dan standar profesi perlu dipahami dengan jernih karena ketiganya sering disebut bersama, tetapi sesungguhnya memiliki fungsi yang berbeda. Kode etik berisi nilai dan pedoman moral profesi. Standar profesi menjelaskan kompetensi, standar perilaku, dan standar praktik yang harus dicapai dan dijaga. Hukum memberi kerangka kewenangan, hak, kewajiban, serta konsekuensi bila terjadi pelanggaran tertentu. Bidan profesional harus mampu bekerja pada irisan ketiga ranah ini.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengatur pendidikan, registrasi, izin praktik, kewenangan, hak, kewajiban, pembinaan, dan pengawasan bidan. Kehadiran undang-undang ini penting karena memperjelas identitas dan ruang lingkup profesi bidan di Indonesia. Dari perspektif profesionalisme, aturan ini menegaskan bahwa praktik bidan harus dilakukan oleh tenaga yang memenuhi kualifikasi, memiliki STR dan izin praktik sesuai ketentuan, serta menjalankan pelayanan sesuai kompetensi dan standar. (Indonesia., 2019)

Standar Profesi Bidan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan bersama konsil dan organisasi profesi juga menekankan etik, legal, dan keselamatan klien sebagai kompetensi inti. Artinya, seorang bidan tidak dianggap profesional hanya karena mampu melakukan tindakan teknis. Ia juga harus mampu bekerja sesuai standar, memprioritaskan keselamatan, dan menempatkan pertimbangan etik dalam seluruh proses asuhan. (RI, 2020)

Pada level etik global, ICM *Code of Ethics for Midwives* menjadi rujukan penting. Kode ini menempatkan tanggung jawab bidan pada beberapa ranah, yaitu kepada perempuan dan keluarga, kepada praktik profesi, kepada masyarakat, kepada sesama profesi dan profesi lain, serta kepada pengembangan diri dan profesi. Pendekatan seperti ini menegaskan bahwa profesionalisme bidan tidak hanya diuji pada hubungan satu lawan satu dengan klien, tetapi juga pada kontribusinya terhadap sistem kesehatan, advokasi, dan pembangunan profesi. (ICM, 2020)

Dalam praktik sehari-hari, relasi antara hukum, standar profesi, dan kode etik dapat dijelaskan sederhana seperti ini: hukum memberi batas minimum yang harus dipatuhi; standar profesi menjelaskan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan dengan benar; dan etika menuntun bidan memilih sikap yang bermartabat dan adil, termasuk pada situasi yang belum diatur secara rinci oleh hukum. Seorang bidan yang taat hukum belum tentu etis secara penuh; sebaliknya, niat baik etik tanpa kepatuhan hukum juga dapat membahayakan pasien dan profesi. Karena itu, profesionalisme mensyaratkan integrasi ketiganya. Penerapan kode etik dalam praktik kebidanan sangat penting untuk menjaga integritas profesi dan

meningkatkan kualitas pelayanan. Bidan yang mematuhi kode etik akan mampu memberikan pelayanan yang lebih aman dan bermutu. (Ahmad, 2019)

F. Dilema Etik dalam Praktik Kebidanan

Dilema etik adalah situasi ketika dua atau lebih nilai, prinsip, atau kewajiban tampak sama-sama penting, tetapi tidak semuanya dapat dipenuhi sekaligus. Praktik kebidanan kaya dengan situasi seperti ini. Misalnya, perempuan menolak rujukan pada kondisi berisiko keluarga meminta informasi klinis tetapi perempuan meminta kerahasiaan ibu memilih tindakan tertentu yang secara klinis menimbulkan kekhawatiran, fasilitas sangat terbatas sehingga bidan harus memilih prioritas Tindakan atau norma budaya bertentangan dengan keselamatan klinis. Pada situasi seperti ini, bidan membutuhkan kerangka berpikir etik yang sistematis.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dilema etik masih sering dialami bidan, penelitian Getu menemukan bahwa dilema etik bidan muncul dari antarmuka antara nilai personal, tuntutan budaya, keterbatasan organisasi, dan tanggung jawab profesional terhadap keselamatan ibu bayi, Penelitian Getu et al. mengenai dilema etik yang dialami bidan menemukan bahwa bidan sering menghadapi konflik antara nilai pribadi, norma budaya, keterbatasan organisasi, keterbatasan sumber daya, serta tanggung jawab profesional untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Dilema tersebut muncul, misalnya, ketika bidan mengetahui tindakan klinis yang paling aman tetapi menghadapi penolakan keluarga, hambatan fasilitas, atau tekanan dari sistem pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dilema etik dalam kebidanan tidak hanya berasal dari keputusan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, organisasi, dan sistem kesehatan. Oleh karena itu, bidan memerlukan kemampuan berpikir etik, komunikasi persuasif, dokumentasi yang baik, dan dukungan sistem untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.. (Getu, 2025)

Di banyak situasi, bidan mengalami tekanan moral ketika mengetahui tindakan yang paling aman, tetapi terhambat oleh keluarga, senioritas, fasilitas, atau kebijakan yang tidak mendukung. Kajian tentang moral distress pada midwives juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan bertindak sesuai nilai profesional dapat memicu kelelahan emosional, rasa bersalah, dan penurunan kualitas kerja.

Beberapa dilema etik yang sering muncul dalam kebidanan antara lain:

1. Konflik antara otonomi perempuan dan penilaian klinis bidan.
2. Konflik antara kerahasiaan pasien dan permintaan keluarga.
3. Tindakan kebidanan pada remaja atau perempuan yang rentan secara sosial.
4. Keputusan rujukan saat keluarga menolak biaya atau transportasi.

5. Penggunaan intervensi medis ketika evidence tidak kuat atau indikasi tidak jelas.
6. Bekerja dalam keterbatasan sumber daya, misalnya alat kurang, staf minim, atau fasilitas penuh.
7. Konflik antarprofesi, terutama bila terdapat perbedaan pendapat terkait penanganan.

Dilema etik tidak selalu dapat diselesaikan dengan hasil yang sepenuhnya ideal. Namun, profesionalisme menuntut bahwa keputusan tetap dibuat secara rasional, transparan, terdokumentasi, dan berorientasi pada keselamatan serta penghormatan terhadap hak perempuan. Dalam konteks pendidikan, penting melatih mahasiswa menghadapi dilema nyata melalui diskusi kasus, simulasi, refleksi, dan supervisi.

G. Langkah Pengambilan Keputusan Etik

Pengambilan keputusan etik membantu bidan agar tidak hanya mengandalkan intuisi sesaat. Model langkah-langkah berikut dapat digunakan secara praktis dalam situasi klinik:

1. Identifikasi masalah etik. Tanyakan: apa konflik utamanya? Apakah ini konflik antara keselamatan dan pilihan pasien, antara kerahasiaan dan kebutuhan informasi keluarga, atau antara standar klinik dan keterbatasan sistem?
2. Kumpulkan fakta yang relevan. Bidan harus memahami kondisi klinis ibu dan bayi, kapasitas perempuan untuk mengambil keputusan, konteks keluarga, kebijakan fasilitas, pilihan yang tersedia, serta risiko dari setiap alternatif.
3. Identifikasi pihak yang terdampak. Keputusan bidan sering memengaruhi bukan hanya perempuan, tetapi juga bayi, keluarga, rekan kerja, dan sistem layanan.
4. Telaah prinsip etik yang relevan. Autonomy, beneficence, nonmaleficence, justice, menjaga martabat, kerahasiaan, dan akuntabilitas perlu dipertimbangkan secara seimbang.
5. Identifikasi pilihan tindakan yang realistis. Kadang pilihan terbaik idealnya tidak tersedia; maka bidan harus memilih opsi paling aman dan paling etis yang dapat dikerjakan.
6. Konsultasi dan kolaborasi. Bila ada waktu dan memungkinkan, bidan perlu berdiskusi dengan senior, dokter, tim, atau komite etik klinik bila tersedia. Konsultasi bukan tanda lemah, tetapi bagian dari profesionalisme.
7. Putuskan dan lakukan tindakan. Keputusan harus berorientasi pada keselamatan, menghormati hak pasien, dan tetap dalam batas kompetensi serta kewenangan.

8. Dokumentasikan dan refleksikan. Dokumentasi melindungi pasien sekaligus tenaga kesehatan. Refleksi setelah kejadian membantu pembelajaran dan perbaikan sistem.

Model ini tampak sederhana, tetapi sangat penting untuk dipraktikkan berulang. Tanpa model yang jelas, bidan mudah terjebak pada keputusan reaktif, tekanan lingkungan, atau kebiasaan yang tidak kritis. Dalam konteks profesionalisme, pengambilan keputusan etik harus menjadi keterampilan inti, sama pentingnya dengan keterampilan klinik.

H. Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan

Penerapan prinsip etika merupakan landasan utama dalam praktik kebidanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam setiap tindakan pelayanan, bidan tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai etik sebagai dasar pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip seperti *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice* menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga menghormati hak pasien, menjamin keselamatan, serta menjunjung tinggi keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dalam praktik sehari-hari, penerapan prinsip etika seringkali dihadapkan pada berbagai situasi klinis yang kompleks, sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dan reflektif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip etik serta implementasinya dalam konteks nyata sangat penting bagi bidan untuk menjaga kualitas asuhan dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 1.1 berikut menyajikan ringkasan mengenai penerapan prinsip etika dalam praktik kebidanan, meliputi definisi masing-masing prinsip, contoh kasus yang relevan, serta tindakan profesional yang dapat dilakukan oleh bidan dalam menghadapi situasi tersebut.

Tabel 1. 2 Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan

Prinsip Etika	Definisi	Contoh Kasus	Tindakan Bidan
Beneficence	Memberikan manfaat terbaik	Ibu hamil risiko tinggi	Memberikan rujukan cepat
Non-maleficence	Tidak membahayakan pasien	Tindakan berisiko tinggi	Menghindari tindakan tanpa indikasi
Autonomy	Menghargai keputusan pasien	Penolakan tindakan	Edukasi & informed consent

Justice	Keadilan pelayanan	Pasien ekonomi rendah	Memberikan pelayanan setara
---------	--------------------	-----------------------	-----------------------------

I. Profesionalisme dalam Komunikasi, Informed Consent, Dokumentasi, dan Kerahasiaan

Komunikasi adalah wajah profesionalisme yang paling cepat dirasakan perempuan dan keluarga. Bidan yang kompeten secara teknis tetapi berkomunikasi kasar, merendahkan, mengabaikan pertanyaan, atau tidak menjelaskan tindakan dengan baik akan dinilai tidak profesional. Sebaliknya, komunikasi yang empatik, jujur, dan menghormati dapat memperkuat kepercayaan, kepatuhan, dan pengalaman asuhan yang positif. Perspektif midwives tentang respectful maternity care menunjukkan bahwa komunikasi yang menghargai perempuan, memberi ruang bagi pertanyaan, dan membangun rasa aman merupakan fondasi mutu layanan maternitas (Lunda, 2024). Penelitian tentang *respectful maternity care* menekankan bahwa komunikasi yang menghargai perempuan merupakan salah satu kompetensi utama dalam pelayanan kebidanan. Komunikasi yang empatik, jelas, dan tidak menghakimi dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, komunikasi yang kasar, merendahkan, atau tidak memberikan informasi yang cukup dapat menurunkan kualitas pengalaman bersalin dan berpotensi melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat pasien. Dengan demikian, komunikasi profesional bukan hanya keterampilan interpersonal, tetapi juga bagian dari kewajiban etik bidan dalam memberikan asuhan yang aman dan bermartabat (Butler, 2020).

Informed consent adalah wujud konkret penghormatan terhadap autonomy perempuan. Persetujuan yang sah bukan sekadar tanda tangan formulir, melainkan proses ketika perempuan menerima informasi yang cukup, memahami pilihan, manfaat, risiko, alternatif, dan konsekuensinya, lalu membuat keputusan secara sukarela. Dalam kebidanan, informed consent penting pada tindakan seperti pemeriksaan internal, pemasangan alat, induksi, episiotomi, tindakan operatif, rujukan, kontrasepsi, dan tindakan lain yang memengaruhi tubuh serta pengalaman reproduksi perempuan. (Annisa Fitira, 2025)

Dokumentasi adalah bentuk akuntabilitas profesional. Rekam asuhan yang lengkap, jelas, objektif, tepat waktu, dan dapat ditelusuri penting untuk kesinambungan layanan, evaluasi mutu, pembuktian hukum, dan keselamatan pasien. Dokumentasi yang terlambat, tidak terbaca, atau tidak sesuai fakta merupakan masalah profesional serius. Bidan perlu menulis apa yang dinilai,

dipikirkan, dilakukan, dan direncanakan, termasuk respons perempuan, edukasi yang diberikan, dan alasan klinis bila mengambil keputusan tertentu. (Risa Pitriani, 2021)

Kerahasiaan dan privasi juga bagian esensial profesionalisme. Informasi mengenai kehamilan, komplikasi, status HIV, kekerasan, kesehatan reproduksi, dan pengalaman persalinan sangat sensitif. Bidan wajib menjaga kerahasiaan, membatasi pembicaraan kasus hanya untuk kepentingan pelayanan, dan melindungi data dalam dokumen fisik maupun digital. Privasi harus dijaga selama pemeriksaan, persalinan, konseling, dan pendidikan kesehatan. (Risa Pitriani, 2021)

Pada era digital, profesionalisme juga mencakup digital professionalism. Bidan harus berhati-hati terhadap penggunaan media sosial, pesan instan, foto klinis, dan penyimpanan data elektronik. Tidak ada alasan profesional untuk membagikan foto pasien, detail kasus, atau informasi sensitif tanpa dasar etik dan legal yang kuat. Etika digital menuntut penghormatan yang sama seperti etika tatap muka. (Tea Vukušić Rukavina, 2021)

J. Kepemimpinan Profesional Bidan dalam Praktik Kebidanan

Kepemimpinan bidan bukan hanya soal jabatan formal sebagai kepala ruang, koordinator, atau pengelola klinik. Kepemimpinan profesional adalah kemampuan memengaruhi mutu asuhan melalui teladan, komunikasi, advokasi, pengambilan keputusan, dan pembentukan budaya kerja yang aman serta beretika. Profesionalisme dalam kebidanan mencerminkan kombinasi antara kompetensi teknis, sikap etis, dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh bidan. Profesionalisme tidak hanya terbatas pada kemampuan melakukan tindakan klinis, tetapi juga mencakup komitmen terhadap standar praktik, akuntabilitas, serta kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan lainnya (ICM, 2020)

Penelitian tentang *respectful maternity care* dan *woman-centred care* memperkuat bahwa kepemimpinan bidan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan pelayanan, tetapi juga dengan kemampuan mengadvokasi hak perempuan, memperjuangkan asuhan yang aman, serta membangun budaya pelayanan yang menghormati martabat pasien. Bidan yang memiliki kepemimpinan profesional mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan klinik maupun komunitas melalui komunikasi, teladan, penguatan standar, dan keberanian mengambil keputusan demi keselamatan ibu dan bayi. Dengan demikian, kepemimpinan profesional bidan merupakan bagian integral dari profesionalisme

karena berhubungan langsung dengan mutu asuhan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat (Butler, 2020)

Kepemimpinan bidan tercermin dalam keberanian untuk memperjuangkan hak perempuan memperoleh informasi yang jujur, jelas, dan mudah dipahami. Kepemimpinan tersebut juga tampak ketika bidan mendorong tim untuk bekerja sesuai standar pelayanan, memperbaiki alur praktik yang berpotensi tidak aman, membimbing tenaga kesehatan yang lebih junior, serta mengadvokasi rujukan tepat waktu meskipun menghadapi tekanan dari keluarga, masyarakat, maupun sistem pelayanan. Dalam praktik komunitas, kepemimpinan bidan diwujudkan melalui kemampuan membangun kepercayaan masyarakat, menjalin kerja sama dengan kader kesehatan, menggerakkan kegiatan edukasi, serta berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesehatan perempuan. Bidan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang membantu masyarakat memahami pentingnya kesehatan ibu dan anak. Kepemimpinan profesional juga terlihat dari kemampuan bidan dalam mengelola konflik secara tegas, jelas, dan adil. Dalam kerja interprofesional, bidan perlu mampu menyampaikan penilaian klinis secara tepat, menghormati kompetensi profesi lain, serta tetap mengutamakan keselamatan ibu dan bayi ketika terdapat potensi risiko. Sikap pasif dalam menghadapi kondisi yang membahayakan tidak mencerminkan profesionalisme, karena bidan memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai standar dan kepentingan terbaik pasien. Dengan demikian, profesionalisme bidan tidak hanya mencakup kompetensi teknis, tetapi juga mencakup dimensi etika sebagai dasar dalam setiap tindakan pelayanan. Bidan yang profesional mampu mempertimbangkan aspek moral, keselamatan, hak pasien, dan tanggung jawab profesi dalam setiap keputusan klinis, sehingga asuhan yang diberikan tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga bermartabat, adil, dan etis (Reni Sulung Utami, 2020)

Aspek penting lain adalah kepemimpinan dalam pembelajaran. Bidan senior memiliki peran besar sebagai role model bagi mahasiswa dan bidan baru. Mahasiswa sering belajar profesionalisme bukan hanya dari kuliah, tetapi dari perilaku yang mereka saksikan di lahan praktik: bagaimana preceptor menyapa pasien, menulis dokumentasi, menanggapi keluhan, menerima kritik, atau mengakui kesalahan. Karena itu, kepemimpinan profesional selalu memiliki dimensi keteladanan. (Yanti, 2017)

K. Pengembangan Profesional Berkelanjutan, Refleksi, dan Mutu Layanan

Profesionalisme tidak bersifat statis namun harus dipelihara melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Perubahan evidence, teknologi, kebutuhan layanan, sistem pembiayaan, dan ekspektasi masyarakat menuntut bidan untuk terus memperbarui kompetensi. Pengembangan profesional dapat dilakukan melalui pendidikan formal lanjut, pelatihan, seminar, audit kasus, pembelajaran mandiri, pembacaan guideline, mentoring, dan refleksi praktik.

Refleksi adalah alat penting untuk pertumbuhan profesional. Melalui refleksi, bidan menelaah pengalaman praktik: apa yang berjalan baik, apa yang gagal, apa yang dirasakan pasien, nilai apa yang dipertaruhkan, dan apa yang dapat diperbaiki. Refleksi berbeda dari menyalahkan diri, refleksi bertujuan membangun pembelajaran. Penelitian tentang pengembangan etika profesional pada mahasiswa kebidanan menunjukkan bahwa refleksi, dialog, pengalaman klinik, dan peran model sangat penting untuk membangun sensitivitas etik dan identitas profesional (Kabirian, 2024).

Temuan Kabirian et al. juga memperlihatkan bahwa refleksi dan penalaran moral merupakan proses penting dalam membentuk kepekaan etik mahasiswa kebidanan. Melalui refleksi, bidan dan mahasiswa kebidanan dapat menilai kembali tindakan yang dilakukan, mengidentifikasi nilai yang terlibat, memahami konsekuensi keputusan klinis, serta merumuskan perbaikan praktik. Refleksi profesional menjadi penting karena praktik kebidanan sering berlangsung dalam situasi yang kompleks, menuntut keputusan cepat, dan melibatkan aspek klinis, emosional, sosial, budaya, serta etik secara bersamaan. Oleh karena itu, refleksi perlu diintegrasikan dalam pendidikan, supervisi klinik, audit kasus, dan pengembangan profesional berkelanjutan (Kabirian, 2024).

Profesionalisme juga harus terhubung dengan mutu layanan. Asuhan yang profesional seharusnya tercermin pada indikator mutu seperti kepatuhan dokumentasi, kepatuhan handover, kepuasan perempuan, kejadian insiden keselamatan, kepatuhan *informed consent*, audit penggunaan intervensi, dan ketepatan rujukan. Dengan kata lain, mutu layanan bukan semata hasil sistem manajemen ia juga merupakan cermin dari profesionalisme individu dan tim.

Supervisi yang terstruktur dan berkesinambungan berperan penting dalam menjaga serta mengembangkan profesionalisme bidan. Dalam praktik kebidanan, supervisi tidak hanya dimaknai sebagai upaya menemukan kesalahan, tetapi sebagai proses pembinaan profesional yang bertujuan menjamin kesesuaian praktik dengan standar pelayanan, mendorong pembelajaran reflektif, serta memperkuat akuntabilitas dalam pemberian asuhan. Melalui supervisi yang terarah, bidan

memperoleh umpan balik yang jelas, konsisten, objektif, dan konstruktif sehingga nilai-nilai profesional dapat lebih mudah diinternalisasi dalam praktik sehari-hari. Pada praktik mandiri, bentuk supervisi dapat dilaksanakan melalui *peer review*, audit rekam medis, diskusi kasus klinis, serta jejaring pembinaan profesional yang dilakukan secara berkelanjutan. (ICM, 2020) (Marshall, 2020)

L. Tantangan Profesionalisme dan Etika Bidan di Era Kontemporer

Profesionalisme dan etika kebidanan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks antara lain : (Indah Kurniawati, 2021)

1. Meningkatnya *medicalization* pada beberapa setting maternitas dapat menggeser identitas kebidanan yang berfokus pada fisiologi, hubungan terapeutik, dan pemberdayaan perempuan. Bidan perlu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan penghormatan terhadap proses fisiologis serta pilihan perempuan.
2. Perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan baru dalam privasi, komunikasi, dan batas profesional. Konsultasi daring, penyimpanan data elektronik, grup percakapan, dan media sosial memudahkan akses tetapi juga membuka risiko pelanggaran kerahasiaan, penyebaran informasi yang tidak valid, serta kaburnya batas hubungan profesional.
3. Tekanan beban kerja, kekurangan staf, dan tuntutan administratif dapat mengikis perilaku profesional. Dalam situasi kelelahan, tenaga kesehatan lebih mudah bersikap tidak sabar, tergesa, atau mengabaikan komunikasi yang empatik. Tantangan organisasi seperti ini tidak boleh diabaikan, karena profesionalisme bukan hanya kualitas personal, tetapi juga hasil interaksi dengan sistem kerja.
4. Keberagaman nilai budaya dan agama menuntut sensitivitas etik yang lebih tinggi. Bidan perlu menghormati budaya tanpa mengorbankan keselamatan dan hak perempuan. Ini menuntut komunikasi yang bijak, negosiasi, dan kemampuan menjelaskan alasan klinis secara dapat dipahami keluarga.
5. Meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas membuat profesi kebidanan harus semakin terbuka terhadap audit, evaluasi, dan keterlibatan pengguna layanan. Tantangan ini sesungguhnya dapat menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan masyarakat bila dikelola dengan profesional.

M. Studi Kasus

1. Kasus 1: Penolakan Tindakan Medis oleh Pasien

a. Deskripsi Kasus

Seorang ibu hamil dengan diagnosis preeklamsia berat menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dengan alasan keterbatasan biaya serta kepercayaan terhadap pengobatan tradisional. Bidan menghadapi dilema antara menghormati keputusan pasien dan kewajiban profesional untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin.

Isu Etik

- 1) Autonomy (otonomi pasien)
- 2) Beneficence (berbuat baik untuk pasien)
- 3) Non-maleficence (tidak membahayakan)

Analisis

Kasus ini menunjukkan konflik antara prinsip otonomi pasien dan kewajiban bidan untuk memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan pasien. Penolakan rujukan meningkatkan risiko komplikasi serius, sehingga bidan tidak dapat bersikap pasif.

Tindakan Profesional

- 1) Melakukan komunikasi terapeutik secara empatik dan persuasif
- 2) Memberikan edukasi berbasis risiko secara jelas dan jujur
- 3) Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan
- 4) Mendokumentasikan penolakan tindakan (informed refusal)

2. Kasus 2: Kerahasiaan Pasien (Confidentiality)

b. Deskripsi Kasus

Seorang remaja datang untuk pemeriksaan kehamilan tanpa sepengetahuan orang tuanya dan meminta agar informasi tersebut dirahasiakan.

Isu Etik

- 1) Confidentiality (kerahasiaan pasien)
- 2) Autonomy (hak pasien)
- 3) Beneficence (kepentingan terbaik pasien)

Analisis

Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban profesional, namun dalam kasus ini perlu dipertimbangkan aspek keselamatan dan dukungan sosial bagi pasien.

Tindakan Profesional

- 1) Menjaga kerahasiaan informasi pasien
- 2) Memberikan konseling yang komprehensif
- 3) Mendorong pasien untuk melibatkan keluarga secara sukarela
- 4) Menilai risiko yang dapat membahayakan pasien

3. Kasus 3: Keterbatasan Fasilitas Pelayanan

a. Deskripsi Kasus

Seorang pasien mengalami komplikasi persalinan di fasilitas kesehatan dengan sarana terbatas. Bidan harus memutuskan apakah akan menangani sendiri atau merujuk pasien.

Isu Etik

- 1) Non-maleficence (tidak membahayakan)
- 2) Beneficence (kepentingan terbaik pasien)
- 3) Professional responsibility (tanggung jawab profesi)

Analisis

Penanganan di fasilitas yang tidak memadai berpotensi meningkatkan risiko bagi pasien, sehingga keputusan klinis harus mengutamakan keselamatan.

Tindakan Profesional

- 1) Melakukan stabilisasi awal pasien
- 2) Segera melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap
- 3) Berkoordinasi dengan tim kesehatan lain

Latihan Soal

4. Kasus 4 – Foto di Media Sosial

Seorang tenaga kesehatan mengunggah foto persalinan ke media sosial dengan alasan edukasi, tetapi wajah pasien hanya diburamkan sebagian. Bidan lain merasa tindakan itu tidak pantas.

- a. Prinsip profesionalisme apa yang berpotensi dilanggar?
- b. Apa risiko etik dan legal dari praktik tersebut?
- c. Bagaimana kebijakan fasilitas dan edukasi digital professionalism sebaiknya dibangun?

N. Penutup

Profesionalisme dan etika kebidanan adalah fondasi identitas bidan dan mutu praktik kebidanan. Profesionalisme menuntut kompetensi, akuntabilitas, integritas, komunikasi yang menghormati, kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, dan kesadaran batas kewenangan. Etika menuntun bidan untuk menjaga martabat perempuan, menghormati pilihan yang diinformasikan, bertindak demi kebaikan, mencegah bahaya, menegakkan keadilan, dan mengelola dilema secara bertanggung jawab.

Dalam praktik nyata, profesionalisme dan etika kebidanan diuji setiap hari: saat bidan menjelaskan tindakan, menolak melakukan prosedur tanpa indikasi, menjaga privasi perempuan, memutuskan rujukan, menghadapi tekanan keluarga, menulis dokumentasi, menggunakan media digital, atau menanggapi insiden keselamatan. Karena itu, profesionalisme tidak boleh diajarkan hanya sebagai teori. Ia harus dibentuk melalui pembelajaran, keteladanan, budaya kerja yang sehat, supervisi, refleksi, dan komitmen personal yang terus diperbarui.

Penguatan profesionalisme bidan dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan etika, serta pembinaan dari organisasi profesi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bidan mampu menghadapi tantangan praktik modern. Pada akhirnya, bidan yang profesional dan beretika adalah bidan yang mampu menggabungkan hati nurani, ilmu, keterampilan, dan tanggung jawab publik dalam satu praktik yang aman, bermutu, dan menghormati perempuan. Inilah bentuk kepemimpinan profesional yang sesungguhnya dalam kebidanan.

Referensi

- ICM. (2014). *International Code of Ethics for Midwives*. Den Haag, Belanda.: International Confederation of Midwives.
- Marshall, J. a. (2020). *Myles Textbook for Midwives*. 17th Edition. *Elsevier*.
- Crepinsek, M. B.–e. (2023). A global review of the inferred meaning of woman centred care within midwifery professional standards. *Women and Birth*, 99-105.
- Qatrunnada Naqiyyah Khusmitha, S. B. (2025). *KONSEP PELAYANAN DAN PROFESIONALISME KEBIDANAN*. Purbalingga: Eureka media aksara.
- Proboningdyah, A. A. (2024). *Peran Bidan dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Implementasi Asuhan Kebidanan yang Sensitif Gender*. Jakarta: Women's Reproductive Health Center.
- ICM. (2020). *International Code of Ethics for Midwives*. Netherlands: International Confederation of Midwives.
- Lunda, P. T. (2024). Perspectives of midwives on respectful maternity care. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Annisa Fitira, R. S. (2025). Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Langkah Antisipasi Potensi Terjadinya Sengketa Medis di Rumah Sakit . *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* (pp. 128-142). Indonesia: Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia.
- Risa Pitriani, R. A. (2021). Penerapan Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Dengan Metode S-O-A-P Pada Praktik Bidan Mandiri. *Jurnal Kebidanan malahayati*, 554-557.
- Tea Vukušić Rukavina, J. V. (2021). Dangers and Benefits of Social Media on E-Professionalism of Health Care Professionals: Scoping Review. *J Med Internet Res*.
- Reni Sulung Utami, A. P. (2020). Critical Care Nurses' Experiences of End-of-Life Care: A Qualitative Study. *Nurse Media Journal of Nursing*, 260-274.
- Yanti. (2017). Meningkatkan Kompetensi Klinik Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Klinik Coc Dalam Pendidikan Kebidanan. *Jurnal Kebidanan Estu Utomo*, 181-191.
- Kabirian, M. Z. (2024). The process of professional ethics development in midwifery students: A qualitative study. *BMC Medical Education*.
- Astri Ulina Saragih, E. T. (2021). Dilema Etik dalam Praktik Kebidanan: Studi Kasus dan Penyelesaiannya. *Seminar Nasional Bukit Pengharapan 2021*. Karanganyar: Muara Multidisiplin Paradigma Journal.

- WHO. (2025). *Compendium on respectful maternal and newborn care*. Geneva: World Health Organization.
- Indonesia., R. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- RI, K. K. (2020). *Buku Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Ahmad, S. N. (2019). Pelindungan Hukum Bagi Bidan Memberikan Pelayanan Obat Kepada Pasien Dalam Praktik Kebidanan Di Daerah Terpencil. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 82-92.
- Getu, T. M. (2025). Ethical dilemmas experienced by midwives in their professional practice in northwestern Ethiopia. *BMC Medical Ethics*.
- Indah Kurniawati, S. M. (2021). *Pengantar Profesionalisme Kebidanan*. Makasar: Ayra Mandiri.
- Butler, M. M. (2020). Competencies for respectful maternity care: Identifying those most important to midwives worldwide. *Birth*, 346–356. .

Glosarium

A

Akuntabilitas

Kemampuan dan kesediaan tenaga profesional untuk mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, dan hasil praktiknya.

Autonomy

Hak pasien untuk memperoleh informasi yang cukup dan membuat keputusan secara sukarela mengenai asuhannya.

B

Beneficence

Kewajiban moral untuk bertindak demi kebaikan pasien.

Digital professionalism

Penerapan nilai profesional dan etika dalam penggunaan teknologi digital, media sosial, dan data elektronik

I

Informed consent

Proses persetujuan setelah pasien menerima informasi memadai, memahami pilihan, dan memutuskan secara sukarela.

J

Justice

Prinsip keadilan dalam pemberian layanan yang tidak diskriminatif dan proporsional

N

Nonmaleficence

Kewajiban untuk tidak menyebabkan bahaya atau meminimalkan bahaya yang dapat diperkirakan.

P

Professionalisme

Perpaduan nilai, perilaku, kompetensi, dan tanggung jawab yang menunjukkan praktik sesuai standar profesi dan etika.

R

Reflective practice

Proses menelaah pengalaman praktik untuk belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan mutu pelayanan

W

Woman centred care

Asuhan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat keputusan, pengalaman, dan hubungan terapeutik

BAB 2

REGULASI DAN HUKUM PRAKTIK KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Pelayanan kebidanan merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem kesehatan nasional yang berperan penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di berbagai wilayah masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam konteks ini, bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan, mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan.

Sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa manusia, praktik kebidanan tidak hanya menuntut kompetensi klinis yang tinggi, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi praktik kebidanan merupakan instrumen penting yang berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan praktik bidan agar sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta norma hukum yang berlaku. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain pendidikan dan kompetensi bidan, registrasi, perizinan praktik, kewenangan klinis, serta pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kebidanan.

Di sisi lain, hukum praktik kebidanan memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kebidanan, baik tenaga kesehatan maupun pasien. Hukum praktik kebidanan mencakup berbagai cabang hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam perspektif hukum administrasi, bidan diwajibkan memiliki legalitas praktik berupa registrasi dan izin praktik yang sah. Dalam hukum perdata, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan. Sedangkan dalam hukum pidana, bidan dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran hukum yang merugikan keselamatan pasien.

Di Indonesia, pengaturan mengenai regulasi dan hukum praktik kebidanan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019

tentang Kebidanan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek penting dalam praktik kebidanan, termasuk kewenangan bidan, hak dan kewajiban, standar kompetensi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan. Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi bidan dalam menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku.

Lebih lanjut, keberadaan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung implementasi regulasi dan hukum praktik kebidanan. Organisasi profesi berfungsi dalam menetapkan kode etik, standar praktik, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kompetensi bidan melalui pendidikan berkelanjutan. Dengan demikian, profesionalisme bidan dapat terus terjaga dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Dalam perspektif sistem kesehatan, regulasi dan hukum praktik kebidanan juga tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Menurut World Health Organization, sistem kesehatan yang kuat harus didukung oleh tata kelola (governance) yang baik, termasuk regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa pelayanan kebidanan diberikan secara aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, regulasi juga berperan dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktik kebidanan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman bidan terhadap aspek hukum, ketidaksesuaian praktik dengan standar yang telah ditetapkan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan risiko terjadinya kesalahan medis (malpraktik), konflik hukum, serta menurunkan kualitas pelayanan kebidanan.

Selain itu, perkembangan sistem kesehatan di era modern, seperti implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), digitalisasi pelayanan kesehatan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, juga menuntut adanya penyesuaian regulasi dan hukum praktik kebidanan. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman menjadi sangat penting agar praktik kebidanan tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Regulasi dan hukum praktik kebidanan adalah seluruh aturan perundang-undangan yang mengatur:

- a. Kewenangan bidan
- b. Standar praktik kebidanan
- c. Hak dan kewajiban bidan
- d. Perlindungan hukum bagi bidan dan pasien

Tujuannya adalah menjamin keselamatan ibu dan bayi, serta mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan hukum praktik kebidanan menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar dapat menjalankan praktik secara profesional, sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan pasien. Kajian mengenai regulasi dan hukum praktik kebidanan juga menjadi penting dalam rangka mendukung terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

B. Teori Regulasi Dan Hukum Praktek Kebidanan

Berikut adalah teori tentang regulasi dan hukum praktik kebidanan yang disusun secara sistematis, akademik

1. Teori Sistem Kesehatan (Health System Theory)

Menurut World Health Organization, sistem kesehatan adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Semua organisasi, institusi, sumber daya, dan manusia yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan.

Artinya, sistem kesehatan tidak hanya mencakup rumah sakit atau puskesmas, tetapi juga mencakup enam komponen utama (*building blocks*), yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan (*Service Delivery*)
- b. Tenaga Kesehatan (*Health Workforce*)
- c. Sistem Informasi Kesehatan
- d. Akses Terhadap Obat
- e. Pembiayaan Kesehatan
- f. Tata Kelola (*Governance*)

Teori sistem kesehatan menjelaskan bahwa pelayanan kebidanan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem yang saling terintegrasi. Keberhasilan praktik kebidanan sangat bergantung pada:

- a. Regulasi Yang Baik
- b. Tenaga Kesehatan Yang Kompeten
- c. Sistem Pembiayaan Yang Mendukung
- d. Serta Tata Kelola Yang Efektif

Teori sistem kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Menurut World Health Organization, sistem kesehatan adalah seluruh organisasi, institusi, sumber daya, dan manusia yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup kebijakan, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan peran masyarakat.

Sistem kesehatan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan finansial agar masyarakat tidak terbebani biaya kesehatan. Dalam konteks nasional, sistem kesehatan juga berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.

Menurut World Health Organization, sistem kesehatan terdiri dari enam komponen utama (building blocks), yaitu pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap obat dan teknologi, pembiayaan kesehatan, serta kepemimpinan dan tata kelola. Keenam komponen ini harus berjalan secara terpadu agar sistem kesehatan dapat berfungsi secara optimal.

Dalam praktik kebidanan, teori sistem kesehatan sangat relevan karena bidan merupakan bagian dari komponen tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan. Bidan berperan dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi, serta berkontribusi dalam sistem rujukan dan pencatatan data kesehatan. Selain itu, praktik kebidanan juga dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang merupakan bagian dari tata kelola sistem kesehatan.

Dengan demikian, teori sistem kesehatan menekankan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan, termasuk kebidanan, sangat bergantung pada keterpaduan seluruh komponen sistem. Sistem yang kuat dan terorganisir dengan baik akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjamin keselamatan pasien, serta mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

2. Teori Regulasi (Regulatory Theory)

Menurut Robert Baldwin, regulasi adalah intervensi negara untuk mengatur perilaku individu atau kelompok demi kepentingan publik. Jenis regulasi:

- a. Command and Control → aturan hukum formal
- b. Self-Regulation → oleh organisasi profesi
- c. Responsive Regulation → kombinasi fleksibel

Teori regulasi kesehatan menegaskan bahwa keberadaan aturan dan kebijakan sangat penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan. Dalam praktik kebidanan, regulasi kesehatan menjadi dasar dalam menentukan kewenangan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi bidan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan sesuai standar dan mendukung sistem kesehatan nasional.

Teori sistem kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Menurut World Health Organization, sistem kesehatan adalah seluruh organisasi, institusi, sumber daya, dan manusia yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup kebijakan, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan peran masyarakat.

Sistem kesehatan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan finansial agar masyarakat tidak terbebani biaya kesehatan. Dalam konteks nasional, sistem kesehatan juga berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.

Menurut World Health Organization, sistem kesehatan terdiri dari enam komponen utama (building blocks), yaitu pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap obat dan teknologi, pembiayaan kesehatan, serta kepemimpinan dan tata kelola. Keenam komponen ini harus berjalan secara terpadu agar sistem kesehatan dapat berfungsi secara optimal.

Dalam praktik kebidanan, teori sistem kesehatan sangat relevan karena bidan merupakan bagian dari komponen tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan. Bidan berperan dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi, serta berkontribusi dalam sistem rujukan dan pencatatan data kesehatan. Selain itu,

praktik kebidanan juga dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang merupakan bagian dari tata kelola sistem kesehatan.

Dengan demikian, teori sistem kesehatan menekankan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan, termasuk kebidanan, sangat bergantung pada keterpaduan seluruh komponen sistem. Sistem yang kuat dan terorganisir dengan baik akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjamin keselamatan pasien, serta mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

3. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik individu maupun kelompok, agar tercipta rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah: "Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum."

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi:

- a. Preventif → melalui regulasi dan standar
- b. Represif → melalui sanksi hukum

Teori perlindungan hukum dalam kesehatan menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk:

- a. Melindungi Pasien
- b. Melindungi Tenaga Kesehatan
- c. Menjamin Pelayanan Yang Aman Dan Berkualitas

Dalam praktik kebidanan, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori perlindungan hukum dalam kesehatan menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan manusia, baik tenaga kesehatan maupun pasien, agar tercipta rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta menjamin hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks kesehatan, perlindungan ini menjadi sangat penting karena pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia.

Perlindungan hukum dalam kesehatan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi, standar pelayanan, dan kode etik profesi. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi

pelanggaran, seperti melalui sanksi administratif, gugatan perdata, atau proses pidana. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam menjaga tertib hukum dalam pelayanan kesehatan.

Tujuan utama perlindungan hukum dalam kesehatan adalah untuk menjamin keselamatan pasien, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga pelayanan dapat berlangsung secara profesional dan beretika. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum meliputi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keselamatan pasien.

Dalam praktik kebidanan, perlindungan hukum sangat penting karena bidan memberikan pelayanan langsung kepada ibu dan bayi yang berisiko tinggi. Perlindungan hukum bagi bidan diberikan apabila mereka bekerja sesuai dengan standar profesi, kewenangan, dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Di sisi lain, pasien juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, informasi yang jelas, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam kesehatan menegaskan bahwa hukum berperan sebagai alat untuk menjamin keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum akan membantu tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam menjalankan praktik secara profesional serta meminimalkan risiko terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan.

4. Teori Kewenangan (Authority Theory)

Menurut Bagir Manan, kewenangan adalah kekuasaan yang sah berdasarkan hukum.

Jenis kewenangan:

- a. Atributif
- b. Delegatif
- c. Mandat

Teori kewenangan merupakan konsep dalam hukum administrasi yang menjelaskan tentang hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan tidak muncul secara bebas, tetapi harus diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau institusi untuk bertindak dalam bidang tertentu.

Dalam teori kewenangan, terdapat tiga sumber utama kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu pejabat kepada pejabat lain disertai dengan tanggung jawab. Sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Ketiga bentuk ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dalam sistem pemerintahan, termasuk di bidang kesehatan.

Tujuan utama dari pengaturan kewenangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya batasan kewenangan yang jelas, maka setiap tenaga kesehatan dapat memahami ruang lingkup tugasnya sehingga pelayanan yang diberikan tetap aman, profesional, dan sesuai standar.

Dalam praktik kebidanan, teori kewenangan sangat penting karena bidan hanya dapat melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Kewenangan bidan diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yang menjelaskan tentang ruang lingkup praktik, kompetensi, serta tanggung jawab bidan. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi bidan dalam menjalankan praktiknya.

Dengan demikian, teori kewenangan menegaskan bahwa setiap tindakan dalam pelayanan kesehatan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemahaman terhadap kewenangan sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar tidak melampaui batas wewenang yang dapat menimbulkan risiko hukum. Selain itu, kewenangan yang jelas juga mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan bertanggung jawab.

5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa setiap tindakan profesional memiliki konsekuensi hukum.

Jenis tanggung jawab:

- a. Administratif → izin praktik
- b. Perdata → ganti rugi
- c. Pidana → sanksi hukum

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa setiap individu atau profesi yang melakukan tindakan hukum harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum berarti tenaga kesehatan wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang

dilakukan kepada pasien sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya apabila melanggar norma hukum.

Dalam hukum, tanggung jawab dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang dialami pasien dan dapat diselesaikan melalui ganti rugi. Tanggung jawab pidana muncul apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian serius atau kematian. Sedangkan tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan profesi atau perizinan yang dapat berujung pada sanksi seperti teguran atau pencabutan izin praktik.

Tujuan dari adanya tanggung jawab hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan. Dengan adanya tanggung jawab hukum, tenaga kesehatan dituntut untuk bekerja secara hati-hati, sesuai standar operasional prosedur, dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya malpraktik dalam pelayanan kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, tanggung jawab hukum sangat penting karena tindakan yang dilakukan bidan berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan bayi. Bidan harus bekerja sesuai dengan kewenangan dan standar profesi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, bidan dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa setiap tindakan dalam pelayanan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemahaman terhadap tanggung jawab ini penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar dapat memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meminimalkan risiko terjadinya sengketa hukum.

6. Teori Bioetika (Bioethics Theory)

Dikembangkan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress dengan 4 prinsip utama:

- a. Autonomy
- b. Beneficence
- c. Non-maleficence
- d. Justice

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa setiap individu atau profesi yang melakukan tindakan hukum harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum berarti tenaga kesehatan wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan kepada pasien sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya apabila melanggar norma hukum.

Dalam hukum, tanggung jawab dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang dialami pasien dan dapat diselesaikan melalui ganti rugi. Tanggung jawab pidana muncul apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian serius atau kematian. Sedangkan tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan profesi atau perizinan yang dapat berujung pada sanksi seperti teguran atau pencabutan izin praktik.

Tujuan dari adanya tanggung jawab hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan. Dengan adanya tanggung jawab hukum, tenaga kesehatan dituntut untuk bekerja secara hati-hati, sesuai standar operasional prosedur, dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya malpraktik dalam pelayanan kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, tanggung jawab hukum sangat penting karena tindakan yang dilakukan bidan berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan bayi. Bidan harus bekerja sesuai dengan kewenangan dan standar profesi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa setiap tindakan dalam pelayanan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemahaman terhadap tanggung jawab ini penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar dapat memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meminimalkan risiko terjadinya sengketa hukum.

7. Teori Mutu Pelayanan Kesehatan

Dikemukakan oleh Avedis Donabedian dengan tiga komponen:

- a. Struktur
- b. Proses
- c. Outcome

Teori mutu pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pasien sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku. Mutu pelayanan tidak hanya dilihat dari hasil klinis, tetapi juga dari kepuasan pasien, keamanan, serta efisiensi pelayanan. Salah satu tokoh penting dalam teori mutu adalah Avedis Donabedian yang mengemukakan bahwa mutu pelayanan kesehatan dapat dinilai melalui pendekatan tertentu.

Menurut Avedis Donabedian, mutu pelayanan kesehatan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan hasil (outcome). Struktur mencakup sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Proses meliputi bagaimana pelayanan diberikan sesuai standar operasional. Sedangkan outcome adalah hasil pelayanan yang dirasakan pasien, seperti kesembuhan, kepuasan, dan keselamatan pasien.

Tujuan dari mutu pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjamin keselamatan pasien, serta memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien. Mutu yang baik juga mencerminkan profesionalisme tenaga kesehatan serta kepatuhan terhadap standar dan etika profesi. Oleh karena itu, peningkatan mutu menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, mutu pelayanan sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayi. Bidan harus memberikan pelayanan sesuai standar, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga pelayanan nifas dan bayi baru lahir. Selain itu, aspek komunikasi, empati, dan responsivitas juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan.

Dengan demikian, teori mutu pelayanan kesehatan menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas harus memenuhi standar, aman, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Penerapan teori ini dalam praktik kebidanan akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi risiko komplikasi, serta mendukung tercapainya derajat kesehatan ibu dan anak yang optimal.

8. Teori Good Governance

Menurut United Nations Development Programme, prinsip tata kelola yang baik meliputi:

- a. transparansi
- b. akuntabilitas
- c. partisipasi
- d. efektivitas

Teori *Good Governance* menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Konsep ini berkembang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Menurut World Bank, *Good Governance* merupakan cara bagaimana kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan.

Prinsip utama dalam *Good Governance* meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum (*rule of law*), dan responsivitas. Partisipasi berarti masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi. Akuntabilitas berarti setiap kebijakan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan dari penerapan *Good Governance* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal. Dalam sektor kesehatan, *Good Governance* sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan kesehatan dilaksanakan secara adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem kesehatan, penerapan *Good Governance* terlihat pada penyusunan regulasi, pengelolaan sumber daya kesehatan, serta pengawasan pelayanan kesehatan. Hal ini mencakup pengelolaan tenaga kesehatan, pembiayaan, serta distribusi fasilitas kesehatan yang merata. Dalam praktik kebidanan, prinsip *Good Governance* membantu memastikan bahwa pelayanan kepada ibu dan bayi dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai standar yang berlaku.

Dengan demikian, teori *Good Governance* menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* akan mendukung terciptanya sistem kesehatan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan

masyarakat, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan.

9. Teori Hak Asasi Manusia dalam Kesehatan

Menurut United Nations, kesehatan adalah hak dasar manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kesehatan merupakan hak dasar setiap individu untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Menurut World Health Organization, kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia yang harus dilindungi oleh negara melalui kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan yang adil.

HAM dalam kesehatan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini meliputi hak atas informasi kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, hak atas persetujuan tindakan medis (*informed consent*), serta hak atas kerahasiaan data medis. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat sebagai bagian dari determinan kesehatan.

Prinsip utama HAM dalam kesehatan meliputi non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas. Non-diskriminasi berarti pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Kesetaraan menekankan bahwa semua orang memiliki hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Partisipasi berarti masyarakat berhak terlibat dalam kebijakan kesehatan, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, penerapan HAM sangat penting karena pelayanan berkaitan langsung dengan ibu dan bayi sebagai kelompok rentan. Bidan harus menghormati hak pasien, memberikan informasi yang jelas, menjaga kerahasiaan, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang menekankan pentingnya perlindungan hak pasien dan tenaga kesehatan.

Dengan demikian, HAM dalam kesehatan merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat. Penerapan prinsip HAM akan meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi pasien, serta mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

10. Teori Profesionalisme Tenaga Kesehatan

Menekankan:

- a. kompetensi
- b. etika
- c. tanggung jawab
- d. akuntabilitas

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kesehatan merupakan hak dasar setiap individu untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Menurut World Health Organization, kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia yang harus dilindungi oleh negara melalui kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan yang adil.

HAM dalam kesehatan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini meliputi hak atas informasi kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, hak atas persetujuan tindakan medis (*informed consent*), serta hak atas kerahasiaan data medis. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat sebagai bagian dari determinan kesehatan.

Prinsip utama HAM dalam kesehatan meliputi non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas. Non-diskriminasi berarti pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Kesetaraan menekankan bahwa semua orang memiliki hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Partisipasi berarti masyarakat berhak terlibat dalam kebijakan kesehatan, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, penerapan HAM sangat penting karena pelayanan berkaitan langsung dengan ibu dan bayi sebagai kelompok rentan. Bidan harus menghormati hak pasien, memberikan informasi yang jelas, menjaga kerahasiaan, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang menekankan pentingnya perlindungan hak pasien dan tenaga kesehatan.

Dengan demikian, HAM dalam kesehatan merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat. Penerapan prinsip HAM akan meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi pasien, serta mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.



Gambar 2. 1 Tantangan Pelaksanaan Regulasi dan Hukum Praktik Kebidanan

C. Landasan Hukum Praktik Kebidanan Di Indonesia

1. Undang-Undang

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

- 1) Mengatur secara khusus profesi bidan
- 2) Mengatur pendidikan, registrasi, praktik, dan perlindungan hukum bidan
- 3) Mengatur secara komprehensif tentang profesi bidan mulai dari pendidikan hingga praktik.
- 4) Menetapkan bahwa bidan harus menempuh pendidikan formal kebidanan sesuai standar nasional.
- 5) Mengatur kewajiban memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) sebelum memberikan pelayanan.
- 6) Menjelaskan ruang lingkup praktik bidan, seperti pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana.

- 7) Memberikan perlindungan hukum bagi bidan selama bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan kode etik.
 - 8) Mengatur hak dan kewajiban bidan, termasuk peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 1) Mengatur hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan
 - 2) Menjadi dasar semua tenaga kesehatan termasuk bidan
 - 3) Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
 - 4) Menjadi dasar bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan kesehatan, termasuk praktik kebidanan.
 - 5) Mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan.
 - 6) Menekankan pentingnya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan.
 - 7) Mengatur perlindungan pasien dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan.
- c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 1) Mengatur tenaga kesehatan secara umum (termasuk bidan)
 - 2) Mengelompokkan bidan sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional.
 - 3) Mengatur standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan.
 - 4) Menetapkan kewajiban memiliki registrasi (STR) sebagai bukti legal untuk praktik.
 - 5) Mengatur izin praktik serta kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.
 - 6) Menekankan pentingnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
 - 7) Mengatur sanksi bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran.
 - 8) Mengatur kompetensi, registrasi, dan praktik
2. Peraturan Pemerintah (PP)
- a. PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat tenaga kesehatan, termasuk bidan, memberikan pelayanan. Isi pokok yang berkaitan dengan praktik kebidanan:
- b. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1) Meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit, praktik mandiri, dan fasilitas lainnya.
 - 2) Bidan dapat bekerja atau praktik di fasilitas tersebut sesuai kewenangannya.

- c. Tempat Praktik Bidan
 - 1) Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta
 - 2) Praktik mandiri bidan (PMB) sesuai izin
 - 3) Harus memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
 - d. Standar Fasilitas

Fasilitas kesehatan wajib memenuhi:

 - 1) Standar bangunan
 - 2) Standar alat kesehatan
 - 3) Standar pelayanan
 - 4) Bertujuan menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan
 - e. Perizinan Fasilitas
 - 1) Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki izin operasional resmi
 - 2) Praktik bidan hanya boleh dilakukan di tempat yang legal dan terdaftar
 - f. Pembinaan dan Pengawasan
 - 1) Pemerintah pusat dan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
 - 2) Untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar
3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
- Beberapa yang penting:
- a. Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Permenkes ini secara khusus mengatur bagaimana bidan dapat menjalankan praktik secara legal. Isi pokok dalam peraturan ini :

 - 1) Perizinan praktik bidan
 - a) Bidan wajib memiliki:
 - i. STR (Surat Tanda Registrasi)
 - ii. SIPB (Surat Izin Praktik Bidan)
 - 2) Tempat praktik
 - b) Bidan dapat praktik di:
 - i. Fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, RS)
 - ii. Praktik Mandiri Bidan (PMB)
 - 3) Batasan praktik
 - a) Maksimal praktik di 3 tempat
 - 4) Kewenangan bidan
 - a) Pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas
 - b) Bayi baru lahir, balita
 - c) Kesehatan reproduksi dan KB
 - 5) Kewajiban bidan
 - a) Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan kode etik

b. Permenkes tentang Standar Pelayanan Kebidanan

Permenkes ini mengatur standar yang harus diikuti bidan dalam memberikan pelayanan. Isi pokok dalam peraturan ini :

1) Standar asuhan kebidanan

Pelayanan harus sesuai tahapan:

- a) Pengkajian
- b) Diagnosa
- c) Perencanaan
- d) Pelaksanaan
- e) Evaluasi

2) Standar mutu pelayanan

Pelayanan harus:

- a) Aman
- b) Bermutu
- c) Berorientasi pada pasien

3) Keselamatan pasien

- a) Mencegah kesalahan tindakan
- b) Mengutamakan prosedur yang benar

4) Standar operasional prosedur (SOP)

- a) Setiap tindakan harus berdasarkan SOP

c. Permenkes tentang Rekam Medis

Permenkes ini mengatur kewajiban pencatatan semua tindakan pelayanan kesehatan, termasuk kebidanan. Isi pokok dalam peraturan ini :

Kewajiban membuat rekam medis

- 1) Setiap pelayanan harus dicatat secara lengkap
- 2) Isi rekam medis
- 3) Identitas pasien
- 4) Hasil pemeriksaan
- 5) Diagnosa
- 6) Tindakan/pengobatan
- 7) Kerahasiaan data
- 8) Rekam medis bersifat rahasia
- 9) Hanya boleh dibuka untuk kepentingan tertentu
- 10) Fungsi rekam medis
- 11) Bukti hukum
- 12) Alat komunikasi antar tenaga kesehatan
- 13) Evaluasi pelayanan
- 14) Penyimpanan dokumen

15) Harus disimpan sesuai ketentuan waktu yang berlaku

4. Organisasi Profesi

a. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

- Menetapkan kode etik bidan
- Mengawasi praktik profesional

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah organisasi profesi resmi yang menaungi seluruh bidan di Indonesia. IBI berperan penting dalam menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peran dan Fungsi IBI:

b. Menetapkan Kode Etik Bidan

- 1) IBI menyusun dan menetapkan kode etik profesi bidan
- 2) Kode etik menjadi pedoman sikap dan perilaku bidan dalam praktik
- 3) Mengatur hubungan bidan dengan:
 - Pasien
 - Sesama tenaga kesehatan
 - Masyarakat

c. Mengawasi Praktik Profesional

- 1) IBI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan
- 2) Memastikan bidan bekerja sesuai:
 - Standar profesi
 - Standar pelayanan
 - Kode etik
- 3) Memberikan rekomendasi dalam proses perizinan praktik (SIPB)

d. Peningkatan Kompetensi

- 1) Menyelenggarakan:
 - Pelatihan
 - Seminar
 - Workshop
- 2) Mendukung Continuing Professional Development (CPD)

e. Perlindungan Profesi

- 1) Memberikan advokasi jika bidan menghadapi masalah hukum
- 2) Melindungi hak dan kepentingan bidan

D. Kewenangan Bidan

Menurut UU No. 4 Tahun 2019, bidan berwenang dalam:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu

Bidan berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga setelah melahirkan.

a. Antenatal care (ANC)

- 1) Pemeriksaan kehamilan secara berkala
- 2) Deteksi dini risiko/komplikasi
- 3) Pemberian edukasi kesehatan ibu hamil

b. Persalinan normal

- 1) Menolong persalinan normal secara mandiri
- 2) Memastikan keselamatan ibu dan bayi
- 3) Melakukan rujukan jika terjadi komplikasi

c. Postpartum

- 1) Pemantauan kondisi ibu setelah melahirkan
- 2) Pencegahan komplikasi (perdarahan, infeksi)
- 3) Konseling menyusui dan perawatan diri

2. Pelayanan Bayi Baru Lahir dan Anak

Bidan juga berwenang memberikan pelayanan pada bayi dan anak untuk menjamin tumbuh kembang optimal.

a. Perawatan neonates

- 1) Perawatan bayi baru lahir (0–28 hari)
- 2) Pencegahan hipotermia, infeksi, dll

b. Imunisasi

- 1) Pemberian imunisasi dasar sesuai program pemerintah
- 2) Edukasi kepada orang tua

c. Pemantauan tumbuh kembang

- 1) Pemantauan berat badan, tinggi badan
- 2) Deteksi dini gangguan tumbuh kembang

3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Bidan berperan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat

a. KB

- 1) Konseling dan pelayanan kontrasepsi
- 2) Membantu pasangan merencanakan kehamilan

b. Edukasi kesehatan reproduksi

- 1) Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi
- 2) Pencegahan penyakit menular seksual

- 3) Kesehatan remaja dan wanita usia subur
- 4. Tugas Tambahan (dengan pelatihan khusus)
 - Bidan dapat menjalankan tugas tambahan setelah mendapatkan pelatihan dan kewenangan khusus.
 - a. Pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
 - b. Stabilitas pasien sebelum dirujuk

E. Hak Dan Kewajiban Bidan

1. Hak Bidan

Hak bidan adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh bidan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan.

a. Mendapat perlindungan hukum

Bidan berhak mendapat perlindungan selama bekerja sesuai:

- 1) Standar profesi
- 2) Standar pelayanan
- 3) Kode etik

Melindungi dari tuntutan hukum yang tidak sesuai prosedur

b. Mendapat imbalan jasa

- 1) Bidan berhak memperoleh honorarium atau penghasilan atas pelayanan yang diberikan
- 2) Imbalan harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku

c. Mendapat kesempatan pengembangan profesi

- 1) Mengikuti Pelatihan, Seminar, Pendidikan berkelanjutan
- 2) Bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan

2. Kewajiban Bidan

Kewajiban bidan adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Memberikan pelayanan sesuai standar

- 1) Harus mengikuti Standar profesi , Standar pelayanan dan SOP
- 2) Menjamin pelayanan yang aman dan bermutu

b. Menghormati hak pasien

Menghargai Privasi pasien, Persetujuan tindakan (informed consent) dan Nilai dan budaya pasien

c. Menjaga kerahasiaan pasien

- 1) Informasi kesehatan pasien tidak boleh disebarluaskan
- 2) Kecuali untuk kepentingan medis atau hukum sesuai aturan

- d. Membuat rekam medis
 - 1) Wajib mencatat setiap tindakan pelayanan
 - 2) Rekam medis harus Lengkap , Akurat dan Dapat dipertanggungjawabkan

F. Standar Praktik Kebidanan

1. Bidan wajib mengikuti:

a. Standar profesi

Standar profesi adalah pedoman mengenai kompetensi minimal yang harus dimiliki bidan. Mencakup Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill) dan Sikap profesional (attitude). Digunakan sebagai acuan dalam Pendidikan, Praktik dan Evaluasi kinerja bidan

b. Standar pelayanan

- 1) Mengatur cara bidan memberikan pelayanan kepada pasien.
- 2) Pelayanan harus Aman, Bermutu, Efektif dan Berfokus pada pasien
- 3) Mengikuti alur asuhan kebidanan Pengkajian, Diagnosis, Perencanaan, Tindakan dan Evaluasi

c. Standar prosedur operasional (SPO)

- 1) SPO adalah langkah-langkah kerja yang terstruktur dan sistematis dalam melakukan tindakan.
- 2) Setiap tindakan kebidanan harus Sesuai prosedur, Konsisten dan Dapat dipertanggungjawabkan

Contoh:

- 1) SOP pemeriksaan kehamilan
- 2) SOP persalinan normal
- 3) SOP penanganan kegawatdaruratan

d. Kode etik profesi

- 1) Kode etik adalah aturan tentang perilaku dan moral bidan dalam menjalankan praktik.
- 2) Ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- 3) Mengatur hubungan bidan dengan Pasien, Teman sejawat, Profesi lain dan Masyarakat
- 4) Menekankan sikap Profesional, Bertanggung jawab dan Menghormati hak pasien

G. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan

Dalam menjalankan praktik, bidan harus memahami aspek hukum agar terhindar dari pelanggaran dan mampu memberikan pelayanan yang aman serta sesuai aturan. Aspek hukum ini mencakup hukum administrasi, perdata, dan pidana.

2. Hukum Administrasi

Hukum administrasi berkaitan dengan legalitas dan perizinan dalam praktik kebidanan.

a. STR (Surat Tanda Registrasi)

- 1) Bukti bahwa bidan telah terdaftar secara resmi dan memiliki kompetensi
- 2) Diperoleh setelah lulus pendidikan dan uji kompetensi

b. SIPB (Surat Izin Praktik Bidan)

- 1) Izin untuk melakukan praktik kebidanan di tempat tertentu
- 2) Dikeluarkan oleh pemerintah daerah

3. Hukum Perdata

Hukum perdata berkaitan dengan hubungan antara bidan dan pasien, terutama jika terjadi kerugian.

- a. Berkaitan dengan gugatan pasien (malpraktik). Terjadi jika ada Kelalaian (negligence) dan Pelayanan tidak sesuai standar
- b. Fokus pada ganti rugi (kompensasi)

Contoh:

- 1) Kesalahan dalam penanganan persalinan yang menyebabkan komplikasi
- 2) Tidak melakukan deteksi dini sehingga pasien mengalami kerugian. Kelalaian menyebabkan kerugian pasien

4. Hukum Pidana

Hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

- a. Jika terjadi tindakan yang melanggar hukum
- b. Kelalaian berat yang membahayakan nyawa pasien
- c. Sanksi dapat berupa denda dan kurungan/penjara

Contoh: praktik tanpa izin, tindakan di luar kewenangan

- a. Praktik tanpa STR atau SIPB
- b. Melakukan tindakan di luar kewenangan (misalnya tindakan medis yang bukan kompetensi bidan)
- c. Kelalaian yang menyebabkan kematian pasien

H. Malpraktik Dalam Kebidanan

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan yang menyebabkan kerugian pasien. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan, termasuk bidan, dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai standar profesi, standar pelayanan, atau prosedur, sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien.

Dalam konteks kebidanan, malpraktik biasanya terjadi karena:

- a. Tidak mengikuti standar praktik
- b. Kurangnya keterampilan atau kehati-hatian
- c. Mengabaikan kondisi pasien
- d. Tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan

Ciri-Ciri Terjadinya Malpraktik

- a. Ada tindakan atau kelalaian (negligence)
- b. Tidak sesuai dengan standar profesi/SOP
- c. Menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian

Contoh Malpraktik dalam Kebidanan

- a. Tidak melakukan rujukan saat terjadi komplikasi
 - 1) Misalnya: ibu mengalami preeklamsia atau perdarahan, tetapi tidak segera dirujuk
 - 2) Dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi
- b. Salah prosedur persalinan
 - 1) Tidak mengikuti langkah-langkah standar dalam menolong persalinan
 - 2) Dapat menyebabkan cedera pada ibu atau bayi
- c. Pelayanan tidak sesuai standar
 - 1) Tidak melakukan pemeriksaan lengkap saat ANC
 - 2) Tidak melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin dengan baik

Dampak Malpraktik

- a. Bagi pasien:
 - 1) Cedera, komplikasi, bahkan kematian
- b. Bagi bidan:
 - 1) Sanksi administratif
 - 2) Gugatan perdata
 - 3) Sanksi pidana
 - 4) Kehilangan kepercayaan masyarakat

Pencegahan Malpraktik

- a. Bekerja sesuai:
 - 1) Standar profesi
 - 2) Standar pelayanan
 - 3) SOP
- b. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan
- c. Melakukan rujukan tepat waktu
- d. Mendokumentasikan tindakan dalam rekam medis
- e. Mematuhi kode etik profesi

I. Perlindungan Hukum bagi Bidan

Bidan dilindungi hukum jika:

- a. Bekerja sesuai standar
- b. Memiliki izin praktik
- c. Melakukan informed consent
- d. Mendokumentasikan tindakan dengan baik

Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya, terutama jika telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini penting agar bidan dapat memberikan pelayanan dengan aman tanpa rasa takut selama sudah mengikuti aturan. Dasar perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan serta peraturan terkait lainnya.

Syarat Bidan Mendapat Perlindungan Hukum

1. Bekerja Sesuai Standar
 - a. Bidan harus mengikuti:
 - 1) Standar profesi
 - 2) Standar pelayanan
 - 3) SOP
 - b. Jika terjadi masalah tetapi bidan sudah bekerja sesuai standar, maka bidan dapat dilindungi secara hukum
2. Memiliki Izin Praktik
 - a. Wajib memiliki:
 - 1) STR (Surat Tanda Registrasi)
 - 2) SIPB (Surat Izin Praktik Bidan)
 - b. Tanpa izin, praktik dianggap ilegal dan tidak mendapat perlindungan hukum

3. Melakukan Informed Consent

a. Bidan harus:

- 1) Memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan
- 2) Meminta persetujuan pasien/keluarga

b. Meliputi:

- 1) Risiko
- 2) Manfaat
- 3) Alternatif tindakan

4. Mendokumentasikan Tindakan dengan Baik

a. Semua tindakan harus dicatat dalam rekam medis

b. Dokumentasi harus:

- 1) Lengkap
- 2) Jelas
- 3) Akurat

J. Etika Profesi Kebidanan

Etika profesi kebidanan adalah pedoman moral dan perilaku yang harus dipatuhi oleh bidan dalam menjalankan praktiknya. Etika ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, profesionalisme, dan kualitas pelayanan. Kode etik bidan ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi Kebidanan

1. Mengutamakan Keselamatan Ibu dan Bayi

- a. Keselamatan pasien adalah prioritas utama
- b. Setiap tindakan harus mempertimbangkan risiko dan manfaat
- c. Menghindari tindakan yang dapat membahayakan

2. Menghormati Martabat Pasien

a. Menghargai:

- 1) Privasi pasien
- 2) Nilai budaya dan kepercayaan
- 3) Hak pasien dalam mengambil keputusan

b. Memberikan pelayanan dengan sikap empati dan sopan

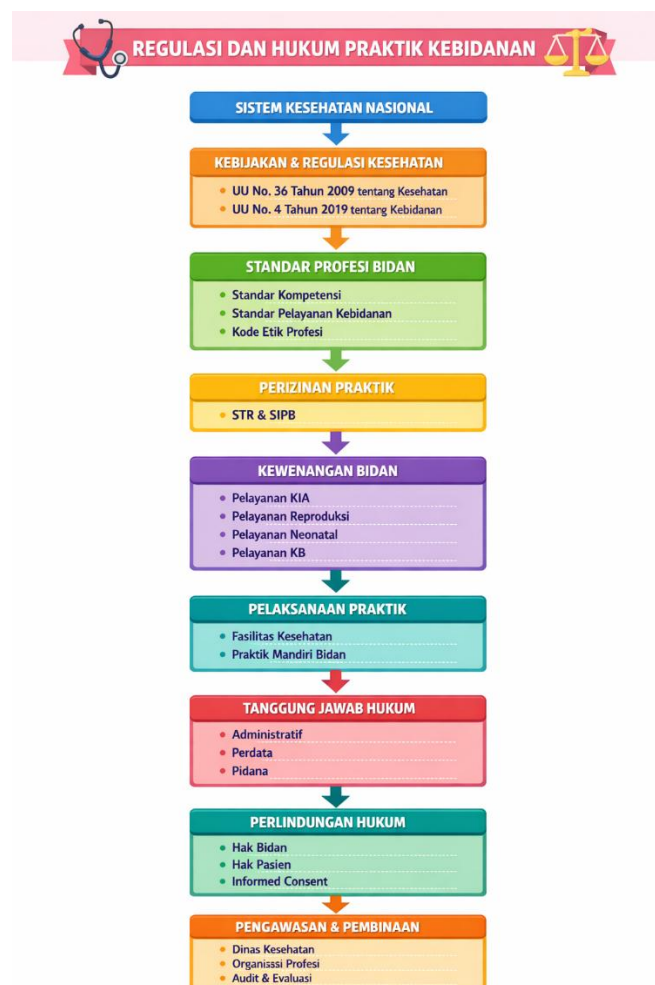
3. Tidak Diskriminatif
 - a. Memberikan pelayanan tanpa membedakan:
 - 1) Status sosial
 - 2) Ekonomi
 - 3) Agama
 - 4) Suku
 - b. Semua pasien berhak mendapat pelayanan yang sama
4. Profesional dan Bertanggung Jawab
 - a. Bekerja sesuai:
 - 1) Standar profesi
 - 2) Standar pelayanan
 - 3) SOP
 - b. Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan
 - 1) Terus meningkatkan kompetensi diri

K. Tantangan dalam Implementasi

Dalam praktik kebidanan, penerapan aspek hukum, standar pelayanan, dan etika tidak selalu berjalan optimal. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi bidan di lapangan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

1. Kurangnya Pemahaman Hukum oleh Bidan
 - a. Tidak semua bidan memahami secara mendalam:
 - 1) Peraturan perundang-undangan
 - 2) Kewenangan praktik
 - 3) Risiko hukum
 - b. Hal ini dapat menyebabkan:
 - 1) Pelanggaran tanpa disadari
 - 2) Risiko terkena sanksi hukum
2. Keterbatasan Fasilitas di Daerah
 - a. Banyak daerah (terutama terpencil) mengalami:
 - 1) Kekurangan alat kesehatan
 - 2) Sarana prasarana yang tidak memadai
 - b. Dampaknya:
 - 1) Pelayanan tidak optimal
 - 2) Kesulitan menangani kasus komplikasi

3. Beban Kerja Tinggi
 - a. Bidan sering menangani banyak pasien sekaligus
 - b. Tugas tidak hanya klinis, tetapi juga:
 - 1) Administrasi
 - 2) Program kesehatan masyarakat
 - c. Dampaknya:
 - 1) Kelelahan
 - 2) Risiko kesalahan meningkat
4. Risiko Tuntutan Hukum Meningkat
 - a. Kesadaran masyarakat terhadap hak kesehatan semakin tinggi
 - b. Pasien lebih berani melakukan:
 - 1) Pengaduan
 - 2) Gugatan hukum
 - c. Jika pelayanan tidak sesuai standar → berisiko tuntutan



Gambar 2. 2 Regulasi dan Hukum Praktik Kebidanan

Referensi

- A. Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia)
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
 6. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis
 7. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kebidanan
- B. Sumber Organisasi Internasional
1. World Health Organization. (2007). *Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes*.
 2. World Health Organization. (2010). *Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage*.
 3. United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
 4. United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
 5. World Bank. (1992). *Governance and Development*.
- C. Organisasi Profesi
1. Ikatan Bidan Indonesia. (2020). *Kode Etik Bidan Indonesia*.
 2. Ikatan Bidan Indonesia. *Standar Profesi Bidan Indonesia*.
- D. Buku dan Literatur Hukum & Kesehatan
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Avedis Donabedian. (1988). *The Quality of Care: How Can It Be Assessed?* JAMA.
- Azwar, A. (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Donabedian, A. (2003). *An Introduction to Quality Assurance in Health Care*. Oxford University Press.
- Effendi, F., & Makhfudli. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*. Bandung: Nusa Media.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia*.

- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robert Baldwin, Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford University Press.
- Tom L. Beauchamp & James F. Childress. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- WHO. (2016). *Standards for Improving Quality of Maternal and Newborn Care in Health Facilities*.

BAB 3

MANAJEMEN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

A. Pendahuluan

Manajemen praktik bidan mandiri Adalah pengelolaan komprehensif atas pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh bidan secara perorangan meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sesuai standar. Aspek utama mencakup pemenuhan izin (SIPB) standar fasilitas, peralatan serta dokumentasi asuhan. Kemampuan seorang dalam mengelola sebuah organisasi bidang kesehatan seperti manajemen daruma sakit ibu dan anak, puskesmas dan Praktik mandiri Bidan(Elok Novembriany Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan & Selatan, 2021)

Mamajerial yang spesifik yang dianggap penting oleh para profesional kesehatan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan praktik. Manajemen sumber daya manusia yang sesuai. Kompetensi utama dalam sebuah organisasi kesehatan adalah evaluasi mutu berdasarkan out come dengan peningkatan kompetensi profesional. Praktik mandiri bidan merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan nasional yang tidak hanya berfokus pada pelayanan klinis, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencegahan penyakit. Dengan peran yang komprehensif ini, bidan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Elok Novembriany Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan & Selatan, 2021).

B. Pengertian dan Peran manajemen praktik Bidan

Manajemen praktik mandiri bidan adalan suatu proses yang pengelolaan secara menyeluruh kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan secara mandiri oleh seorang bidan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi layanan agar pelayanan yang diberikan kepada ibu dan anak berjalan efektif, aman dansesuai standar profesional.

Manajemen praktik mandiri bidan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan, menjamin keselamatan ibu dan bayi serta memenuhi standar profesi dan regulasi kesehatan. Manajemen praktik mandiri bidan merupakan suatu proses sistematis yang dimiliki suatu organisasi pelayanan kebidanan yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi degantujuan menjamin pelayanan yang efektif, aman dan bermutu bagi ibu dan anak. Pelaksanaan manajemen ini tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku di Indonesia seperti peraturan menteri kesehatan no 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan secara mandiri. Serta undang – undang no 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menegaskan kewajibab tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai stndar profesi dan kompetensi, sehingga setiap tahap dalam manajemen praktik bidan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

Praktik mandiri bidan memiliki posisi penting dalam mendukung sistem kesehatan nasional, terutama pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. Di Indonesia, bidan tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Peran ini sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan penguatan layanan promotif dan preventif sebagai dasar pembangunan kesehatan.(Zakiah et al., 2022a)

1. Penyedia layanan kesehatan primer
2. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
3. Pelaksana Upaya promotif dan preventif
4. Mitra fasilitas kesehatan lainnya.
5. Penggerak kesehatan Masyarakat.
6. Pendukung program jaminan kesehatan nasional.

(PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

C. Tahap Manajemen praktik mandiri kebidanan

Pada tahap manajemen praktik mandiri bidan harus mengikuti prinsip manajemen yang disesuaikan dengan pelayanan kebidanan. Berikut yahap -tahap nya:

1. PERENCANAAN

Tahap perencanaan untuk menentukan :

- a. Jenis layanan yang akan dilakukan (ANC, Persalinan, Nifas, KB, Imunisasi, Terapi Komplementer kebidanan)
- b. Kebutuhan Alat, Obat dan sarana.
- c. Target pasien
- d. Standar Operasional prosedur (SOP)

2. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)

Mengatur semua sumber daya yang ada, seperti :

- a. Pembagian tugas (jika ada tenaga tambahan)
- b. Penataan ruang praktik
- c. Pengelolaan administrasi dan rekam medis
- d. Pengaturan alur pelayanan pasien

3. PELAKSANAAN (ACTUATING/ IMPLEMENTING)

Tahap menjalankan rencana, Meliputi :

- a. Memberikan asuhan kebidanan (Ibu hamil, bersalinan, nifas, bayi barfu lahir)
- b. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- c. Edukasi kesehatan kepada pasien

4. PENGAWASAN (CONTROLLING)

Hal yang perlu dipantau :

- a. Kualitas Pelayanan
- b. Kepatuhan terhadap SOP
- c. Kebersihan dan keamanan alat.
- d. Kepuasan Pasien

5. EVALUASI

Hasil evaluasi keseluruhan kegiatan :

- a. Apakah pelayanan sudah efektif dan efisien
- b. Apa saja kendala yang dihadapi
- c. Upaya peningkatan mutu pelanan kedepan

D. Aspek-Aspek Utama Manajemen Praktik mandiri Sesuai Permenkes

1. Perizinan dan legalitas

Bidan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). SIPB berlaku 5 tahun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah.

2. Standar Tempat praktik

a. Lokasi dan ruaangan

Standar tempat praktik (Peraturan menteri Kesehatan No 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik Bidan)

1) Bangunan (Permenkes no 28 Tahun 2017 pasal 33)

- a) Harus bersifat permanen dan tidak bergabung dengan bangunan lainnya. tidak termasuk rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan yang sejenis.

- b) Dalam hal praktika mandiri berada dirumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal.
 - c) Bangunan harus memiliki fungsi keamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta keselamatan dan kesehatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan orang usia lanjut.
- 2) Ruang pelayanan (Permenkes no 28 Tahun 2017 pasal 32)
 - a) Ruang tunggu
 - b) Ruang pemeriksaan
 - c) Ruang bersalin
 - d) Ruang nifas
 - e) WC / Kamar mandi
 - f) Ruang lain sesuai kebutuhan
- 3) Papan nama (Permenkes no 28 Tahun 2017 pasal 39)

Wajib memasang papan nama praktik dengan ukuran 60 cmx 60 cm berwarna putih dan tulisannya hitam yang memuat nama, Alamat, nomor SIPB dan waktu praktik
- 4) Prasarana dan peralatan wajib sesuai dengan ketentuan perundang - undangan (Permenkes no 28 Tahun 2017 pasal 34)
 - a) Air bersih
 - b) Sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup.
 - c) Ventilasi / Sirkulasi udara yang baik
 - d) Prasarana lain sesuai kebutuhan
- b. Standar tempat tidur

Menyediakan tempat tidur minimal 1 (satu) dan maksimal 5 (lima) tempat tidur.
- 3. Peralatan dan Obat-obatan

Bidan wajib memiliki peralatan dan obat-obatan minimal sesuai standar peraturan perundang-undangan (Kepmenkes/Permenkes) untuk pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir (Permenkes no 28 Tahun 2017 pasal 36)(PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

 - a. Pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana dan penanganan awal kasus kegawatdaruratan dan bayi baru lahir.
 - b. Obat hanya diperoleh diapotik melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
 - c. Bidan yang melakukan praktik mandiri bidan harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai serta melakukan pengelolaan obat sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pelolahan Limbah Medis
 - a. praktik mandiri bidan harus melaksanakan pengelolaan limbah medis
 - b. Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi yang memiliki instalasi pengolahan limbah.
5. Dokumentasi

Bidan pelaksanaan pelayanan nya harus wajib melakukan dokumentasi asuhan kebidanan sesuai dengan ranah asuhannya

E. Persyaratan pendirian praktik mandiri bidan

1. Menjadi anggota IBI
2. Permohonana surat ijin praktik bidan selaku swasta perorangan
3. Surat keterangan kepala puskesmas setempat
4. Tidak dalam sanksi profesi atau hukum.
5. Surat keterangan ketua ranting IBI wilayah.
6. Persiapan peralatan medis usaha Praktik bidan secara perorangan dengan pelayanan pemeriksaan pertolongan persalinan dan perawatan.
7. Membuat surat perjanjian sanggup mematuhi perjanjian yang tertulis.
8. Harus memiliki standar tempat praktik
9. Bidan yang menjalankan praktiknya harus mencantumkan izin praktik bidannya atau foto copy pratiknya diruangan praktik atau tempat yang mudah dilihat.
10. Jika dalam melakukan pelayanan nya biodan memperkerjakan tenaga bidan yang lain yang memilkik SIPB.
11. Harus memiliki peratatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tersedia ditempat praktik.
12. Dalam menjalankan tugas bidan harus serta mempertahankan dan meningkatkan keterampilan profesinya.

F. Pelayanan yang diberikan bidan praktik mandiri

1. Penyuluhan kesehatan.
2. Konseling KB
3. Antenatal care
4. Asuhan persalinan
5. Perawatan nifas
6. Perawatan bayi
7. Pelayanan KB (IUD, AKBK, Suntik, PIL)
8. Imunisasi (Ibu dan Bayi).
9. Kesehatan reproduksi remaja

G. aspek-aspek penting dalam pengembangan manajemen praktik mandiri bidan:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan (Role Model): Pengembangan PMB bertujuan menghasilkan pelayanan yang bermutu, profesional, dan mampu memberikan kontribusi kesehatan masyarakat, contohnya melalui program Bidan Delima.
2. Adaptasi Teknologi & Sistem Informasi: Penggunaan software khusus (misal: *Midwifery Manager* atau sistem informasi berbasis web) untuk mengelola data pasien, administrasi, dan inventaris obat, meningkatkan efisiensi dan keakuratan
3. Pendokumentasian Asuhan (Dokumentasi Kebidanan): Pendampingan dalam pencatatan asuhan kebidanan yang sistematis, praktis, dan terdokumentasi dengan baik (soap) untuk mempermudah pemantauan riwayat pasien
4. Peningkatan Kompetensi (Pendidikan Berkelanjutan): Bidan secara aktif meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, workshop, dan pertukaran informasi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Adaptasi Fasilitas dan Alur Pelayanan: Penyesuaian sarana, prasarana, dan alur pelayanan, terutama dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk melindungi pasien, bidan, dan staf dari risiko penularan infeksi.
6. Pemenuhan Legalitas dan Sarana: Bidan praktik mandiri diwajibkan memenuhi syarat perizinan yang berlaku (STRB dan SIPB) dan menjaga standar peralatan medis.

H. Mutu dan keselamatan pasien

Mutu dan keselamatan pasien dalam Manajemen Praktik Mandiri Bidan (MPMB) difokuskan pada pelayanan ibu dan anak yang aman, efektif, dan berkualitas melalui penerapan standar operasional prosedur, pemantauan indikator klinik, dan pemenuhan hak pasien. Ini melibatkan manajemen risiko, peningkatan kompetensi bidan, dokumentasi asuhan yang baik, serta penerapan enam sasaran keselamatan pasien untuk mencegah insiden.

Berikut adalah komponen kunci manajemen mutu dan keselamatan di Praktik Mandiri Bidan (PMB):

1. Peningkatan Mutu Pelayanan
 - a. Penerapan SOP pada setiap pelayanan untuk menjamin kualitas
 - b. Mengukur mutu (pengukuran bisa dilakukan secara berkala dengan menilai kepuasan pasien dan hasil klinis (Elok Novembriany Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan & Selatan, 2021)
 - c. Pelatihan mandiri

2. Keselamatan Pasien (Patient Safety)

- a. Identifikasi pasien
- b. Komunikasi efektif
- c. Keamanan obat
- d. Pencegahan infeksi
- e. Manajemen risiko.

3. Manajemen Praktik:

- a. pembinaan : Adanya pembinaan dari Dinas kesehatan terkait standar pelayanan,
- b. Legalitas : Bidan wajib mematuhi peraturan menteri dan memiliki izin praktik yang sah.

I. Penutup

Manajemen praktik bidan mandiri merupakan kunci dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan bidan mampu menjalankan praktik secara profesional serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Referensi

- Elok Novembriany Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan, Y., & Selatan, K. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL KUNJUNGAN MASA NIFAS PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN HJ. NORHIDAYATI BANJARMASIN. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 6(2).
- (Brydges et al., 2009; Elok Novembriany Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan & Selatan, 2021; Masoumy et al., 2024; Watanabe et al., 2018; Zakiah et al., 2022b)
- Astin, N. H., Jayanti, V., Putri, K. M., et al. (2025). Pengembangan praktik bidan mandiri. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Azhar, Z. (2023). Making applications for midwives' independent practice using the waterfall method. *Journal of Health Science and Medical Therapy*, 1(1), 30–37.
- Dartiwen, & Nurhayati. (2019). Asuhan kebidanan pada kehamilan. Yogyakarta: Andi.
- Fitriahadi, E. (2017). Buku ajar asuhan kehamilan disertai daftar tilik. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Hayati, L., & Tarigan, R. A. (2026). Asuhan kebidanan berkesinambungan pada praktik mandiri bidan. *Medic Nutricia: Journal Ilmu Kesehatan*, 22(3), 181–190.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
- Manuaba, I. B. G. F. (2019). Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan KB. Jakarta: EGC.
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Wicaksono, A. P., et al. (2022). Pembuatan aplikasi pada praktik mandiri bidan. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*
- Zakiah, Z., Herliawati, P. A., Nyoman, N., Witari, D., & Chania, M. P. (2022a). Analisis Kasus Continuity of Care (COC) dengan Metode Gentle Birth dan Persalinan Maryam di Tempat Praktek Mandiri Bidan Siti Zakiah Tabanan Tahun 2022 : Studi Kasus Case Analysis of Continuity of Care (COC) at the Private Midwife Practice Siti Zakiah Tabanan in 2022: Case Study. 12(1). <http://ejournal.politeknikkesehatankartinibali.ac.id/index.php/JGK>
- Zakiah, Z., Herliawati, P. A., Nyoman, N., Witari, D., & Chania, M. P. (2022b). Analisis Kasus Continuity of Care (COC) dengan Metode Gentle Birth dan Persalinan Maryam di Tempat Praktek Mandiri Bidan Siti Zakiah Tabanan

Tahun 2022 : Studi Kasus Case Analysis of Continuity of Care (COC) at the Private Midwife Practice Siti Zakiah Tabanan in 2022: Case Study. 12(1). <http://ejournal.politeknikkesehatankartinibali.ac.id/index.php/JGK>

BAB 4

KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN MATERNAL: STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS ASUHAN IBU DAN BAYI

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan suatu bangsa. Di Indonesia, Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, AKI di Indonesia tercatat sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Angka ini belum mengalami penurunan yang signifikan, karena data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 masih mencatat AKI berada di kisaran 305 per 100.000 KH, jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 183 per 100.000 KH pada tahun 2024 dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebesar 70 per 100.000 KH pada tahun 2030 (Kemenkes RI, 2023; Kemenkes RI, 2015). Sementara itu, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat jumlah kematian ibu sebanyak 4.005 kasus, dengan penyebab utama hipertensi dalam kehamilan, perdarahan obstetrik, dan berbagai komplikasi lainnya (Kemenkes RI, 2023). Tingginya angka ini menegaskan bahwa pelayanan maternal di Indonesia masih memerlukan penguatan yang menyeluruh dan sistematis.

Data cakupan pelayanan kesehatan ibu di Indonesia mencerminkan kondisi yang belum merata. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan cakupan kunjungan antenatal keempat (K4) sebesar 68,1% dan kunjungan keenam (K6) hanya 17,6% — jauh di bawah target (Kemenkes RI, 2023). Meski secara nasional cakupan K4 pada tahun 2022 sempat mencapai 86,2% mendekati target RPJM 90%, angka ini masih sangat bervariasi antarprovinsi (Kemenkes RI, 2022). Pertolongan persalinan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan berdasarkan SKI 2023 telah mencapai 96,1%, namun kesenjangan kualitas layanan antarwilayah masih nyata. Ketidakmerataan cakupan ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan saja tidak cukup — diperlukan kepemimpinan yang kuat di tingkat fasilitas layanan primer untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi secara konsisten di setiap wilayah kerja (Mahayani, 2020).

Kualitas pelayanan maternal tidak semata-mata ditentukan oleh kompetensi klinis tenaga kesehatan secara individual, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dijalankan di setiap lini pelayanan. Pemimpin dalam pelayanan maternal — baik bidan koordinator, kepala ruang bersalin, maupun kepala puskesmas — berperan menentukan iklim kerja tim, standar asuhan yang diterapkan, kecepatan respons terhadap kegawatdaruratan, serta mutu pengalaman yang dirasakan oleh ibu dan keluarga. Penelitian di Kabupaten Pidie, Aceh, membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan desa dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dengan nilai $p < 0,001$ (Mahayani, 2020). Arahan yang jelas dari pemimpin terbukti mengurangi kesalahan pelayanan dan meningkatkan kinerja bidan secara keseluruhan.

Dalam konteks global, *State of the World's Midwifery* 2021 yang diterbitkan UNFPA, WHO, UNICEF, dan ICM menegaskan bahwa investasi dalam bidan berpotensi mencegah dua pertiga kematian ibu dan bayi baru lahir di seluruh dunia. Namun, laporan yang sama mengidentifikasi kesenjangan serius dalam kepemimpinan formal bagi profesi bidan di banyak negara. Banyak bidan masih bekerja sebatas mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pihak lain, bukan sebagai penggerak perubahan kebijakan itu sendiri (Sattar et al., 2023). Kondisi serupa terjadi di Indonesia, di mana penguatan kepemimpinan bidan di tingkat puskesmas dan fasilitas layanan primer menjadi kebutuhan mendesak guna mempercepat penurunan AKI dan angka kematian bayi (AKB).

Berdasarkan latar belakang di atas, bab ini ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepemimpinan dalam pelayanan maternal mencakup konsep dan definisi, gaya kepemimpinan yang relevan, fungsi dan peran pemimpin, hubungannya dengan keselamatan ibu, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta strategi pengembangan kepemimpinan yang dapat diterapkan. Pembahasan ini ditujukan bagi bidan, tenaga kesehatan maternal, manajer fasilitas layanan kesehatan, serta akademisi dan pemangku kepentingan yang berkomitmen pada peningkatan kualitas pelayanan ibu dan bayi di Indonesia.

B. Definisi dan Konsep Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal

1. Definisi Kepemimpinan secara Umum

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan proses mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja secara sukarela menuju tujuan organisasi. Igbaekemen (2014) merumuskan kepemimpinan sebagai *"the art of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of goals"* — seni mempengaruhi orang lain agar berjuang dengan sepenuh hati mencapai tujuan yang ditetapkan.

Definisi ini menekankan dua unsur inti: unsur pengaruh (*influence*) dan unsur kesediaan sukarela (*willingness*), yang membedakan kepemimpinan sejati dari sekadar penugasan atau paksaan.

Dalam perspektif yang saling melengkapi, Ainur (2017) mendefinisikan kepemimpinan sebagai keterampilan yang dimiliki seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi agar mampu mencapai tujuan bersama secara optimal. Dimensi motivasi dan inspirasi dalam definisi ini penting karena kepemimpinan yang baik tidak berhenti pada pemberian perintah, melainkan mendorong setiap anggota tim untuk tumbuh, berkontribusi, dan merasa memiliki tanggung jawab atas hasil yang dicapai (Ainur, 2017, dikutip dalam Saptabakti, 2021).

Secara lebih luas, para ahli manajemen sepakat bahwa kepemimpinan mencakup empat elemen yang tidak terpisahkan: (1) kepemimpinan adalah *proses*, bukan sekadar posisi; (2) kepemimpinan melibatkan *pengaruh* terhadap orang lain; (3) kepemimpinan berlangsung dalam *konteks kelompok*; dan (4) kepemimpinan diarahkan untuk *mencapai tujuan* bersama (Northouse, 2004, dikutip dalam berbagai literatur). Keempat elemen ini berlaku pula dalam konteks pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan maternal.

2. Definisi Kepemimpinan dalam Konteks Pelayanan Kebidanan

Dalam lingkup pelayanan kebidanan, kepemimpinan memiliki makna yang lebih khas dan spesifik. Desiyanti (2025) menegaskan bahwa bidan bukan sekadar tenaga kesehatan, tetapi juga pemimpin dalam lingkup pekerjaannya. Profesi kebidanan menuntut keterampilan teknis sekaligus kemampuan manajerial yang baik. Kepemimpinan yang efektif dalam pelayanan kebidanan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan komitmen dalam tim, serta menjamin mutu layanan kesehatan ibu dan anak (Desiyanti, 2025).

Noviari dan Hasanah (2025) dalam kajian naratif mereka yang diterbitkan di *Ezra Science Bulletin* menegaskan bahwa kepemimpinan bidan mencakup kemampuan menggerakkan tim, membuat keputusan klinis, dan menjamin mutu layanan kesehatan ibu dan anak. Lebih jauh, kajian tersebut menyatakan bahwa definisi kepemimpinan dalam kebidanan telah bergeser dari yang semata-mata bersifat hierarkis menuju pengakuan bahwa pemimpin dapat lahir dari berbagai level — bukan hanya dari kalangan pejabat atau manajer, melainkan dari setiap bidan yang berhadapan langsung dengan pasien dan tim. Pergeseran ini mendekati konsep kepemimpinan partisipatif dan relasional yang menekankan hubungan, kepercayaan, dan pemberdayaan (Noviari & Hasanah, 2025).

Medway dan Rehayem (2024, dikutip dalam Noviari & Hasanah, 2025) menambahkan bahwa kepemimpinan dalam kebidanan adalah kunci bagi

transformasi pelayanan maternitas. Peran pemimpin bidan tidak hanya diemban oleh manajer atau administrator, tetapi juga oleh pendidik, pembuat kebijakan, dan bidan klinis yang terlibat langsung dalam perawatan ibu. Pemahaman ini memperluas cakupan kepemimpinan kebidanan melampaui batas-batas jabatan struktural dan menempatkannya sebagai tanggung jawab setiap profesional kebidanan.

3. Perbedaan Pemimpin dan Manajer dalam Pelayanan Maternal

Dalam praktik pelayanan maternal, sering kali terjadi kerancuan antara peran pemimpin (*leader*) dan manajer (*manager*). Keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Wilson College (2024, dikutip dalam Noviori & Hasanah, 2025) membedakan keduanya secara tegas: seorang manajer berfokus pada sistem, prosedur, dan administrasi — memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Sementara seorang pemimpin berfokus pada visi, pengembangan individu, dan inspirasi tim untuk melampaui target minimal. Dalam konteks ruang bersalin, manajer memastikan SOP persalinan normal dijalankan, sedangkan pemimpin membangun budaya tim yang cepat, responsif, dan saling mendukung saat menghadapi kegawatdaruratan.

Perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer ini dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Manajer: mengelola sumber daya, menetapkan jadwal, memantau kepatuhan prosedur, dan berfokus pada *stabilitas sistem*.
- b. Pemimpin: menginspirasi, memotivasi, mengembangkan kompetensi individu, dan berfokus pada *transformasi dan peningkatan*.
- c. Manajer tanpa jiwa pemimpin: efisien dalam rutinitas, tetapi lambat beradaptasi dan lemah dalam krisis.
- d. Pemimpin tanpa kompetensi manajerial: visioner tetapi tidak efektif secara operasional.

Lebih penting lagi, kepemimpinan dalam pelayanan maternal tidak harus datang dari mereka yang memiliki jabatan struktural. Seorang bidan pelaksana di ruang bersalin yang mengambil inisiatif mendeteksi tanda bahaya, mengkoordinasikan tim secara tenang di tengah kegawatdaruratan, dan memastikan pasien mendapat pertolongan tepat waktu — ia adalah pemimpin, terlepas dari posisinya dalam hierarki organisasi (Medway & Rehayem, 2024, dikutip dalam Noviori & Hasanah, 2025).

4. Empat Dimensi Konsep Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal

Berdasarkan sintesis berbagai definisi di atas, kepemimpinan dalam pelayanan maternal dapat dipahami melalui empat dimensi utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan:

- a. Kepemimpinan Klinis, yaitu kemampuan pengambilan keputusan klinis yang cepat, tepat, dan berbasis bukti — terutama dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri seperti perdarahan pascapersalinan, preeklamsia berat, dan sepsis. Dalam dimensi ini, pemimpin klinis mengambil alih koordinasi tim secara tenang, mengarahkan tindakan di ruang bersalin, dan memastikan ibu serta bayi selamat (Noviari & Hasanah, 2025).
- b. Kepemimpinan Manajerial, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan sistem pelayanan agar berjalan efektif dan efisien sesuai standar yang berlaku. Kepemimpinan manajerial yang baik memastikan tim memiliki kompetensi, fasilitas terpenuhi, dan prosedur dipatuhi secara konsisten.
- c. Kepemimpinan Transformasional, yaitu kemampuan menginspirasi dan memotivasi tim untuk melampaui target minimal dan bersama-sama mencapai mutu pelayanan terbaik. Bass (1985) menegaskan bahwa pemimpin transformasional menciptakan visi bersama, membangun kepercayaan, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan ini terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja tim kesehatan (Abisatyo et al., 2025).
- d. Kepemimpinan Partisipatif/Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama lintas profesi dalam tim interprofesi untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Kepemimpinan kolaboratif memungkinkan bidan bekerja sama secara setara dengan dokter, nutrisisionis, psikolog, dan tenaga kesehatan masyarakat dalam penanganan ibu hamil risiko tinggi — meningkatkan mutu layanan sekaligus memperkuat fondasi good governance di fasilitas kesehatan (Noviari & Hasanah, 2025).

Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Dalam praktik sehari-hari pelayanan maternal, seorang bidan yang efektif sebagai pemimpin akan mengintegrasikan keempatnya secara dinamis sesuai konteks dan kebutuhan tim. Kemampuan beralih dari kepemimpinan klinis di tengah kegawatdaruratan menuju kepemimpinan kolaboratif dalam rapat tim, dan dari kepemimpinan manajerial dalam perencanaan program KIA menuju kepemimpinan transformasional dalam mentoring bidan junior — itulah hakikat kepemimpinan yang matang dan efektif dalam pelayanan maternal (Desiyanti, 2025; Noviari & Hasanah, 2025).

C. Gaya Kepemimpinan yang Relevan dalam Pelayanan Maternal

Pemahaman tentang gaya kepemimpinan merupakan fondasi penting bagi setiap bidan yang mengemban tanggung jawab memimpin dalam pelayanan maternal. Gaya kepemimpinan merujuk pada pola konsisten perilaku yang ditunjukkan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan tim dan dalam mengambil keputusan organisasi. Dalam literatur manajemen dan kepemimpinan, dikenal sejumlah gaya kepemimpinan utama — mulai dari otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, servant, hingga kepemimpinan berbasis kompetensi. Masing-masing gaya memiliki kekuatan dan keterbatasan yang bergantung pada konteks situasi yang dihadapi.

1. Tidak Ada Satu Gaya yang Paling Efektif: Landasan Kepemimpinan Situasional

Salah satu kesimpulan paling konsisten dalam penelitian kepemimpinan modern adalah bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang secara universal paling efektif dalam semua situasi. Hersey dan Blanchard (1969) meletakkan landasan teoritis yang penting melalui konsep kepemimpinan situasional (*situational leadership*), yang menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dengan kematangan dan kesiapan pengikutnya. Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membaca situasi dengan tepat dan menyesuaikan pendekatannya secara dinamis.

Dalam konteks pelayanan maternal, prinsip kepemimpinan situasional ini sangat relevan. Seorang bidan koordinator yang memimpin penanganan kegawatdaruratan perdarahan pascapersalinan membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda dari ketika ia memimpin rapat perencanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bulanan. Penelitian internasional yang dilakukan Pezaro et al. (2024) dengan melibatkan 429 bidan dari 76 negara mengonfirmasi bahwa karakteristik pemimpin bidan yang kuat tidak sepenuhnya sejajar dengan satu gaya kepemimpinan tunggal — melainkan mencakup elemen dari berbagai gaya kepemimpinan secara komplementer. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemimpin bidan perlu menguasai berbagai repertoire kepemimpinan dan mengaplikasikannya secara kontekstual.

2. Gaya Kepemimpinan Otoriter (Autokratis)

Gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis ditandai dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada pemimpin, dengan sedikit atau tanpa pelibatan anggota tim. Pemimpin autokratis menetapkan tujuan, menentukan prosedur, memberikan perintah yang jelas, dan mengharapkan kepatuhan penuh dari bawahannya. Dalam gaya ini, alur komunikasi umumnya berjalan satu arah —

dari atas ke bawah — dan pemimpin bertindak sebagai hakim utama atas pencapaian anggota tim.

Dalam pelayanan maternal, gaya kepemimpinan otoriter dapat menjadi pilihan yang tepat dan bahkan niscaya dalam situasi-situasi tertentu, terutama kondisi kegawatdaruratan obstetri. Ketika menghadapi kasus perdarahan pascapersalinan masif, eklampsia, atau sepsis neonatorum, respons tim yang cepat, terkoordinasi, dan tanpa ambiguitas sangat menentukan keselamatan jiwa. Dalam momen kritis tersebut, kejelasan komando dari pemimpin klinis — siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana — dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Gaya kepemimpinan direktif ini meminimalkan kebingungan dan memastikan protokol kegawatdaruratan dijalankan dengan tepat dan efisien.

Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan gaya otoriter secara dominan dalam rutinitas pelayanan sehari-hari berdampak negatif terhadap kinerja bidan. Kebede et al. (2023) dalam studi *cross-sectional* yang melibatkan 121 bidan di fasilitas kesehatan publik Kota Jimma, Ethiopia Barat Daya, menemukan bahwa gaya kepemimpinan autokratis merupakan gaya yang paling dominan dipraktikkan oleh pimpinan bidan. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara gaya kepemimpinan autokratis dengan kinerja bidan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang lebih luas: kepemimpinan otoriter yang berlebihan cenderung menekan inisiatif, mengurangi kepuasan kerja, dan melemahkan komitmen tim dalam jangka panjang (Kebede et al., 2023). Dengan demikian, gaya otoriter paling tepat digunakan sebagai respons situasional pada kondisi darurat, bukan sebagai pola kepemimpinan dominan sehari-hari.

3. Gaya Kepemimpinan Demokratis (Partisipatif)

Gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif menempatkan anggota tim sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis mendengarkan masukan, mengajukan pertanyaan kepada tim, memfasilitasi diskusi, dan mengintegrasikan perspektif berbagai pihak sebelum keputusan diambil. Hubungan antara pemimpin dan anggota tim bersifat dua arah, kolaboratif, dan saling menghargai. Gaya ini mencerminkan keyakinan bahwa kebijaksanaan kolektif tim seringkali lebih kaya daripada keputusan seorang pemimpin semata.

Dalam pelayanan maternal, gaya demokratis sangat relevan untuk konteks perencanaan program KIA, penyusunan jadwal pelayanan antenatal, evaluasi capaian kinerja bulanan, serta pemecahan masalah operasional yang tidak bersifat darurat. Ketika bidan koordinator melibatkan tim dalam merancang strategi peningkatan cakupan kunjungan antenatal keempat (K4) atau menyusun

protokol baru untuk skrining preeklamsia, keputusan yang dihasilkan akan lebih kontekstual, lebih mudah diimplementasikan, dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari seluruh anggota tim.

Kebede et al. (2023) menemukan korelasi positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kinerja bidan, dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan pengaruh signifikan pada nilai. Gaya kepemimpinan demokratis mendorong kerja sama, kepercayaan, dan dukungan emosional yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat — kondisi yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan kepada ibu dan bayi (Kebede et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan perspektif kepemimpinan partisipatif yang menekankan bahwa bidan yang merasa suaranya didengar dan dipertimbangkan akan memiliki motivasi dan komitmen yang lebih tinggi dalam memberikan asuhan berkualitas.

4. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang paling banyak diteliti dan diterapkan dalam konteks pelayanan kesehatan modern. Bass (1985) mendeskripsikan pemimpin transformasional sebagai seseorang yang mampu menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi kepentingan bersama yang lebih tinggi, melalui pembangkitan kesadaran akan tujuan mulia, penguatan motivasi intrinsik, dan stimulasi intelektual yang mendorong kreativitas serta inovasi. Pemimpin transformasional tidak sekadar mengelola — mereka mengubah, memotivasi, dan mengangkat kapasitas seluruh tim menuju standar yang lebih tinggi.

Ada empat pilar utama kepemimpinan transformasional menurut Bass (1985), yang sering dikenal dengan singkatan *The Four I's*. (1) *Idealized Influence* — pemimpin menjadi teladan yang dikagumi dan dipercaya; (2) *Inspirational Motivation* — pemimpin mengomunikasikan visi yang menginspirasi dan membangkitkan antusias tim; (3) *Intellectual Stimulation* — pemimpin mendorong tim untuk berpikir kritis dan mencari solusi inovatif; dan (4) *Individualized Consideration* — pemimpin memperhatikan kebutuhan pengembangan setiap anggota tim secara personal. Keempat pilar ini menjadikan kepemimpinan transformasional sangat relevan dalam konteks reformasi sistem pelayanan maternal.

Abisaty et al. (2025) dalam tinjauan literatur yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Perawat Profesional mengonfirmasi bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan motivasi kerja tenaga kesehatan di rumah sakit. Pemimpin dengan gaya transformasional terbukti mampu meningkatkan kinerja tim melalui penciptaan visi bersama,

penguatan kepercayaan, dan dorongan inovasi yang berkelanjutan (Abisatyo et al., 2025). Dalam konteks penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan untuk mendorong reformasi sistem pelayanan dari sekadar memenuhi prosedur administratif menuju budaya asuhan yang benar-benar berpusat pada keselamatan ibu dan bayi. Pezaro et al. (2024) pun mengonfirmasi bahwa karakteristik pemimpin bidan yang kuat — seperti visioner, inovatif, dan inspiratif — memetakan langsung pada gaya kepemimpinan transformasional.

5. Servant Leadership (Kepemimpinan Melayani)

Konsep *servant leadership* atau kepemimpinan yang melayani menempatkan pemimpin bukan sebagai figur yang berkuasa, melainkan sebagai pelayan bagi tim dan bagi mereka yang dilayaninya. Pemimpin dengan gaya ini memprioritaskan kebutuhan, pertumbuhan, dan kesejahteraan anggota tim di atas kepentingan pribadi. Mereka membangun kepercayaan melalui empati, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan secara aktif menghilangkan hambatan yang menghalangi anggota tim untuk bekerja secara optimal. Dalam pelayanan maternal, filosofi ini beresonansi kuat dengan nilai-nilai inti profesi kebidanan yang menempatkan ibu dan keluarga sebagai pusat dari seluruh proses asuhan.

Adcock et al. (2022) dalam studi kualitatif deskriptif yang melibatkan 13 pemimpin bidan dari seluruh wilayah Australia mengidentifikasi sejumlah kebutuhan esensial pemimpin bidan yang mencerminkan elemen-elemen *servant leadership*. Pemimpin bidan yang efektif menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan anggota tim, membangun hubungan strategis yang dilandasi saling menghormati, serta secara aktif mengadvokasi kebutuhan bidan yang mereka pimpin kepada manajemen eksekutif. Salah satu temuan penting studi tersebut adalah bahwa pemimpin bidan perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya tim yang positif — menjaga kohesivitas antara bidan yang bekerja dalam model asuhan berkelanjutan dan bidan yang bekerja dalam sistem giliran, serta memastikan setiap bidan merasa didukung dan diperhatikan (Adcock et al., 2022). Kualitas relasional yang tinggi ini merupakan inti dari *servant leadership* dan terbukti meningkatkan kepuasan kerja, komitmen tim, serta kualitas asuhan yang diberikan kepada ibu.

Lebih jauh, Adcock et al. (2022) menegaskan bahwa pemimpin bidan dengan orientasi melayani juga berfungsi sebagai penghubung antara tim klinis dengan manajemen organisasi — memperjuangkan dukungan institusional, sumber daya yang memadai, dan lingkungan kerja yang kondusif bagi praktik kebidanan yang optimal. Kemampuan "berbicara dalam bahasa eksekutif" — mengomunikasikan

manfaat kualitas layanan dalam kerangka bisnis dan efisiensi — merupakan keterampilan khas pemimpin bidan yang mampu menjembatani nilai-nilai profesional kebidanan dengan kepentingan organisasi.

6. Kepemimpinan Berbasis Kompetensi

Kepemimpinan berbasis kompetensi dibangun di atas otoritas yang lahir dari keahlian klinis dan penguasaan mendalam atas bidang praktik. Dalam konteks pelayanan maternal, seorang bidan yang memiliki kompetensi klinis tinggi — mahir dalam pertolongan persalinan normal maupun dengan penyulit, terampil dalam manajemen kegawatdaruratan, dan konsisten menerapkan asuhan berbasis bukti — akan secara natural menjadi panutan bagi rekan-rekan sejawatnya. Kepemimpinan ini tidak memerlukan jabatan formal; ia lahir dari rasa hormat dan kepercayaan yang diperoleh melalui demonstrasi kompetensi yang konsisten dalam praktik sehari-hari.

Pezaro et al. (2024) mengidentifikasi bahwa pemimpin bidan yang kuat dipandang sebagai *evidence-based practitioner* — seseorang yang menunjukkan kemajuan pemahaman dan praktik melalui inkuiri yang berkelanjutan serta dedikasi terhadap praktik berbasis bukti. Kompetensi ini bersifat multidimensional: mencakup penguasaan aspek riset, pengajaran, dan praktik klinis baik di dalam maupun di luar fasilitas rumah sakit (Pezaro et al., 2024). Kepemimpinan berbasis kompetensi juga tercermin dalam kemampuan pengambilan keputusan yang efektif — tetap tenang dan terstruktur dalam situasi kegawatdaruratan, berpikir kritis, serta melibatkan tim secara tepat dalam proses pengambilan keputusan klinis.

7. Karakteristik Pemimpin Bidan yang Kuat: Bukti dari Riset Internasional

Pemahaman tentang gaya kepemimpinan yang telah diuraikan di atas menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan karakteristik konkret yang mendefinisikan pemimpin bidan yang kuat dalam praktik nyata. Pezaro et al. (2024) melakukan penelitian *appreciative inquiry* internasional yang melibatkan 429 bidan dan bidan-perawat dari 76 negara, menggunakan survei daring antara Februari hingga Juli 2022. Analisis tematik refleksif menghasilkan sepuluh karakteristik utama pemimpin bidan yang kuat, yang kemudian dipetakan secara deduktif terhadap gaya dan teori kepemimpinan yang mapan.

Pertama, mediator — pemimpin bidan yang kuat mampu menghadapi ketidaksepakatan, menyelesaikan konflik di antara anggota tim secara tidak memihak, dan berkomunikasi secara efektif dan persuasif sambil tetap menghormati semua pihak. Kedua, dedikasi terhadap profesi — pemimpin bidan harus mencintai profesi kebidanan, memiliki identitas profesional yang kuat, dan bersedia memberikan diri sepenuhnya demi kemajuan profesi. Ketiga, praktisi

berbasis bukti — pemimpin bidan secara aktif melakukan inkuiri, mengikuti perkembangan riset terkini, dan mengintegrasikan bukti terbaik yang tersedia ke dalam praktik klinis dan pengajaran (Pezaro et al., 2024).

Keempat, pengambil keputusan yang efektif — pemimpin bidan mampu membuat keputusan yang tepat, tetap tenang dan terstruktur dalam situasi kegawatdaruratan, menunjukkan pemikiran kritis, serta melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, panutan (*role model*) — pemimpin bidan memimpin melalui keteladanan, menunjukkan profesionalisme, kejujuran, integritas, dan standar moral yang tinggi, serta bekerja berdampingan dengan tim alih-alih memerintah dari posisi tertinggi. Keenam, advokat — pemimpin bidan memperjuangkan kepentingan profesi maupun perempuan yang dilayaninya, berani menyuarakan kebenaran, serta mengangkat dan memberdayakan orang lain dalam perjalanannya (Pezaro et al., 2024).

Ketujuh, visioner — pemimpin bidan yang kuat merupakan inovator yang inspiratif, mampu bermimpi, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengadvokasi perubahan demi kepentingan perempuan dan kesehatan perempuan. Mereka tidak menunggu izin untuk mengambil inisiatif dan berani berpikir di luar kotak. Kedelapan, resilien — dalam sistem layanan kesehatan yang penuh tekanan, pemimpin bidan membutuhkan ketangguhan untuk belajar dari kesalahan, membangun komunitas pendukung, dan merawat diri sendiri agar dapat terus memimpin secara efektif. Kesembilan, empatik — pemimpin bidan menunjukkan empati terhadap rekan sejawat maupun pasien, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperlakukan semua pihak dengan penuh hormat, dan peduli terhadap keseimbangan kehidupan kerja anggota tim. Kesepuluh, compassionate (penuh kasih sayang) — pemimpin bidan yang compassionate menciptakan lingkungan kerja yang psikologis aman, membuat bidan merasa berdaya dan bersemangat untuk datang bekerja, serta memprioritaskan kesejahteraan staf (Pezaro et al., 2024).

Sepuluh karakteristik di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dan mencerminkan integrasi dari berbagai gaya kepemimpinan. Pezaro et al. (2024) memetakan karakteristik-karakteristik tersebut ke dalam lima gaya kepemimpinan utama yang relevan dalam konteks kebidanan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Pemetaan Karakteristik Pemimpin Bidan yang Kuat terhadap Gaya Kepemimpinan

Karakteristik	Compassionate	Transformasional	Servant	Authentic	Situasional
Mediator	✓	✓	✓		✓
Dedikasi terhadap Profesi	✓	✓		✓	
Praktisi Berbasis Bukti		✓			✓
Pengambil Keputusan Efektif		✓	✓		✓
Panutan (Role Model)	✓	✓	✓	✓	
Advokat		✓	✓		✓
Visioner		✓	✓		✓
Resilien	✓	✓			✓
Empatik	✓	✓	✓	✓	
Compassionate	✓		✓		✓

Sumber: Diadaptasi dari Pezaro et al. (2024).

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan pun yang mencakup seluruh sepuluh karakteristik pemimpin bidan yang kuat secara eksklusif. Kepemimpinan *compassionate* mendominasi karakteristik yang bersifat relasional seperti empati, ketangguhan emosional, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Kepemimpinan transformasional mewarnai karakteristik yang bersifat inspiratif dan strategis seperti visi, advokasi, dan berbasis bukti. Kepemimpinan *servant* tercermin dalam mediasi, pengembangan tim, dan pendekatan yang menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pemimpin sendiri. Sementara kepemimpinan *authentic* dan situasional melengkapi gambaran ini melalui integritas moral dan kemampuan adaptasi terhadap konteks yang berubah-ubah (Pezaro et al., 2024).

Temuan Pezaro et al. (2024) ini sangat relevan bagi pengembangan kepemimpinan bidan di Indonesia. Ketika bidan koordinator atau kepala ruang bersalin memahami bahwa kepemimpinan yang kuat menuntut kombinasi kasih

sayang, visi transformatif, dedikasi terhadap bukti ilmiah, dan keberanian untuk mengadvokasi perubahan — bukan sekadar otoritas jabatan — maka pengembangan diri sebagai pemimpin menjadi lebih terarah dan bermakna. Lebih penting lagi, kerangka karakteristik ini memberikan panduan konkret bagi institusi pendidikan kebidanan dan manajemen fasilitas kesehatan dalam merancang program pengembangan kepemimpinan yang komprehensif, kontekstual, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas asuhan ibu dan bayi.

D. Fungsi dan Peran Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal

Kepemimpinan dalam pelayanan maternal bukan sekadar tentang siapa yang memegang otoritas formal. Ia tentang siapa yang mengambil tanggung jawab — tanggung jawab atas keselamatan ibu di meja persalinan, atas kualitas asuhan yang diterima ibu hamil di ruang tunggu puskesmas, atas motivasi bidan muda yang baru pertama kali menghadapi kegawatdaruratan, dan atas keberlanjutan sistem pelayanan yang harus tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber daya. Fungsi dan peran kepemimpinan dalam pelayanan maternal bersifat multidimensional — mencakup aspek klinis, manajerial, edukatif, koordinatif, advokatif, dan inovatif — dan semuanya bermuara pada satu tujuan: memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan asuhan yang aman, berkualitas, dan bermartabat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menegaskan bahwa bidan memiliki kewenangan yang luas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi perempuan — dari asuhan kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kewenangan yang komprehensif ini menempatkan bidan, khususnya bidan yang mengemban peran kepemimpinan, pada posisi strategis yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan ibu dan bayi di seluruh siklus kehidupan reproduktif perempuan.

1. Peran Klinis: Pemimpin di Garis Terdepan Keselamatan Ibu

Peran klinis adalah dimensi kepemimpinan yang paling langsung dan paling kritis dalam pelayanan maternal. Dalam peran ini, bidan yang memimpin bertanggung jawab menetapkan standar asuhan, memastikan kepatuhan tim terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), dan memimpin penanganan kegawatdaruratan obstetri dengan tenang dan terstruktur. Seorang pemimpin klinis yang efektif tidak hanya mahir secara teknis — ia juga mampu membaca dinamika tim dalam situasi tekanan tinggi, mendistribusikan tugas dengan tepat, dan memastikan komunikasi antar anggota tim tetap berjalan jelas dan efisien bahkan ketika waktu sangat terbatas.

Renfrew et al. (2014) dalam kerangka kerja berbasis bukti untuk asuhan ibu dan bayi baru lahir yang diterbitkan di *The Lancet* menegaskan bahwa pelayanan berkualitas dari tenaga kebidanan yang kompeten, berwenang, dan didukung secara penuh berpotensi mencegah 83% kematian ibu, 83% kematian bayi baru lahir, dan 77% kasus lahir mati di seluruh dunia. Potensi ini hanya dapat diwujudkan ketika bidan berfungsi tidak sekadar sebagai pelaksana prosedur, tetapi sebagai pemimpin klinis yang secara aktif memastikan standar asuhan terpenuhi di setiap titik kontak dengan ibu dan bayi. Kerangka Renfrew et al. (2014) mengidentifikasi 58 praktik yang meliputi komunikasi yang efektif, penilaian klinis berkelanjutan, perencanaan asuhan bersama perempuan, dan koordinasi lintas profesi sebagai komponen inti pelayanan kebidanan yang berkualitas.

Dalam konteks Indonesia, tantangan kepemimpinan klinis terasa sangat nyata. Sitompul (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Tapanuli Utara menemukan bahwa kinerja bidan desa dalam pelayanan KIA dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas kepemimpinan yang mereka terima dari atasan langsung. Bidan yang bekerja di bawah kepemimpinan yang memberikan arahan jelas, mendukung pengembangan kompetensi, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif menunjukkan kinerja pelayanan yang lebih baik — termasuk dalam aspek kunjungan antenatal, pertolongan persalinan bersih dan aman, serta pemantauan nifas (Sitompul, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan klinis yang kuat bukan sekadar nilai tambah, melainkan prasyarat fundamental bagi pelayanan maternal yang berkualitas.

2. Peran Manajerial: Mengelola Sistem agar Asuhan Berjalan Optimal

Di samping peran klinisnya, bidan dalam posisi kepemimpinan juga mengemban fungsi manajerial yang tidak kalah penting. Peran manajerial mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pelayanan agar seluruh roda organisasi berputar secara efektif dan efisien. Pemimpin bidan yang efektif secara manajerial mampu menyusun jadwal pelayanan yang optimal, mengelola konflik dalam tim secara konstruktif, memastikan ketersediaan alat dan bahan yang diperlukan untuk pelayanan maternal, serta memantau indikator kualitas pelayanan secara berkala.

Noviari dan Hasanah (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam kebidanan mencakup kemampuan menggerakkan tim, membuat keputusan klinis, dan menjamin mutu layanan kesehatan ibu dan anak. Dalam dimensi manajerial ini, perbedaan antara pemimpin dan manajer menjadi relevan: pemimpin yang efektif tidak hanya memastikan prosedur dijalankan (fungsi manajerial), tetapi juga membangun budaya tim yang berorientasi pada mutu

dan inovasi berkelanjutan. Wilson College (2024, dikutip dalam Noviari & Hasanah, 2025) menjelaskan bahwa manajer berfokus pada sistem dan stabilitas, sementara pemimpin berfokus pada visi dan pengembangan — dan dalam pelayanan maternal, keduanya harus hadir secara terintegrasi dalam satu sosok bidan yang memimpin.

3. Peran Pendidik dan Mentor: Mengembangkan Generasi Bidan Selanjutnya

Salah satu investasi jangka panjang terpenting yang dapat dilakukan seorang pemimpin bidan adalah mengembangkan kapasitas anggota timnya. Peran sebagai pendidik dan mentor merupakan fungsi kepemimpinan yang seringkali tidak mendapat sorotan, padahal dampaknya bersifat multiplikatif: seorang bidan senior yang efektif sebagai mentor akan menghasilkan bidan-bidan junior yang kompeten, percaya diri, dan berkomitmen — yang pada gilirannya akan menjadi pemimpin-pemimpin baru dalam pelayanan maternal.

Clark et al. (2023) mengevaluasi program *Leadership Link* — kurikulum kepemimpinan daring yang dikembangkan untuk bidan bersertifikat (*Certified Midwives* dan *Certified Nurse-Midwives*) di Amerika Serikat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kepemimpinan peserta sebesar 6,4 hingga 32,5% setelah mengikuti program tersebut, dengan peningkatan terbesar pada kompetensi *systems thinking* dan *interprofessional collaboration*. Temuan ini membuktikan bahwa kepemimpinan bidan dapat dikembangkan secara terstruktur melalui pendidikan yang tepat sasaran — bukan semata-mata bawaan lahir atau hasil pengalaman bertahun-tahun di lapangan semata (Clark et al., 2023).

Adcock et al. (2022) dalam studi kualitatif mereka tentang kebutuhan pemimpin bidan di Australia mengidentifikasi bahwa pemimpin bidan yang efektif perlu memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan anggota tim dan mahir dalam melakukan *facilitated reflective practice* — membantu anggota tim untuk merefleksikan pengalaman klinis mereka secara kritis dan mengekstrak pembelajaran darinya. Kemampuan ini sangat relevan dalam konteks mentoring bidan junior, terutama yang baru pertama kali menghadapi situasi klinis yang kompleks atau menegangkan. Pemimpin bidan yang mampu menciptakan ruang yang aman secara psikologis untuk belajar dari kesalahan akan menghasilkan tim yang lebih tangguh, lebih inovatif, dan lebih siap menghadapi tantangan pelayanan maternal di masa depan (Adcock et al., 2022).

4. Peran Koordinator: Memastikan Kesenambungan dan Integrasi Pelayanan

Pelayanan maternal yang berkualitas tidak dapat dihasilkan oleh satu tenaga kesehatan secara tunggal, melainkan membutuhkan koordinasi yang lancar antara berbagai unit, profesi, dan tingkatan fasilitas kesehatan. Bidan dalam

posisi kepemimpinan memainkan peran krusial sebagai koordinator yang memastikan kesinambungan asuhan dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Pemimpin bidan juga menjadi penghubung vital dalam sistem rujukan — memastikan komunikasi yang efektif antara bidan pelaksana di fasilitas primer dengan dokter spesialis obstetri di fasilitas sekunder dan tersier.

Renfrew et al. (2014) secara khusus menekankan pentingnya koordinasi lintas profesi dalam model asuhan kebidanan yang berkualitas. Kebidanan yang bekerja dalam jaringan yang terintegrasi — berkolaborasi dengan dokter spesialis, ahli gizi, petugas kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan jiwa — menghasilkan luaran maternal dan neonatal yang secara konsisten lebih baik dibandingkan model pelayanan yang terfragmentasi. Pemimpin bidan yang efektif menjadi arsitek dari sistem koordinasi ini, membangun protokol komunikasi yang jelas, jalur rujukan yang terstandar, dan budaya kolaborasi yang menghargai kontribusi setiap profesi (Renfrew et al., 2014).

Dalam konteks Indonesia, tantangan koordinasi sangat terasa di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan komunikasi. Bidan koordinator di puskesmas sering kali harus membuat keputusan rujukan dalam kondisi ketidakpastian — dengan akses komunikasi yang terbatas, fasilitas transportasi yang tidak memadai, dan tanpa kepastian ketersediaan tempat di fasilitas rujukan. Kepemimpinan yang kuat dalam peran koordinasi ini, didukung oleh sistem informasi kesehatan yang handal dan protokol rujukan yang terstandar, menjadi faktor penentu apakah ibu bersalin dapat mencapai pertolongan yang tepat dalam waktu yang tepat (Sattar et al., 2023).

5. Peran Advokat: Suara bagi Ibu dan Profesi

Kepemimpinan yang matang dalam pelayanan maternal tidak berhenti pada dinding fasilitas kesehatan. Bidan yang memimpin juga bertanggung jawab mengadvokasi — memperjuangkan hak dan kepentingan ibu yang dilayaninya, mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas layanan maternal, dan memperkuat posisi profesi kebidanan dalam sistem kesehatan yang lebih luas. Advokasi ini mencakup dimensi langsung (misalnya memastikan ibu mendapat informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang persalinannya) maupun dimensi sistemik (mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk program KIA di tingkat daerah).

Sattar et al. (2023) dalam tinjauan literatur integratif yang komprehensif menemukan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi bidan untuk berperan optimal dalam kepemimpinan adalah keterbatasan akses ke posisi-posisi pengambilan keputusan dalam kebijakan, pendidikan, dan praktik. Banyak bidan

masih bekerja semata-mata untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pihak lain, bukan sebagai penggerak perubahan kebijakan itu sendiri. Kondisi ini mencerminkan defisit advokasi yang serius — baik advokasi oleh bidan secara individual maupun oleh organisasi profesi kebidanan secara kolektif. Pemimpin bidan yang efektif harus menjadi ujung tombak perubahan ini, secara aktif merepresentasikan kebutuhan dan perspektif profesi kebidanan dalam forum-forum kebijakan di tingkat fasilitas, daerah, dan nasional (Sattar et al., 2023).

Adcock et al. (2022) secara khusus mengidentifikasi kemampuan *"speaking the language of the executive"* — kemampuan mengomunikasikan nilai dan urgensi pelayanan kebidanan dalam kerangka yang dipahami oleh manajemen eksekutif dan pembuat kebijakan — sebagai keterampilan kritis yang harus dimiliki pemimpin bidan modern. Pemimpin bidan yang mampu menerjemahkan data klinis, luaran pasien, dan kebutuhan tim ke dalam argumen bisnis yang meyakinkan akan jauh lebih efektif dalam mengadvokasi perubahan sistem dibandingkan pemimpin yang hanya berbicara dalam bahasa klinis semata (Adcock et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, keterampilan ini sangat relevan ketika bidan koordinator harus mengadvokasi kebutuhan peningkatan kapasitas fasilitas kepada kepala dinas kesehatan atau manajer rumah sakit.

6. Peran Inovator: Mendorong Perubahan Berbasis Bukti

Sistem pelayanan maternal tidak akan berkembang tanpa inovasi — dan inovasi tidak akan terwujud tanpa pemimpin yang berani mempertanyakan status quo, mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang ada dan bukti ilmiah terkini, serta mendorong implementasi solusi baru yang lebih efektif. Peran inovator dalam kepemimpinan maternal mencakup identifikasi masalah sistemik dalam pelayanan, eksplorasi pendekatan baru yang berbasis bukti, fasilitasi uji coba perubahan dalam skala kecil, dan advokasi untuk penerapan perubahan yang terbukti berhasil secara lebih luas.

Pezaro et al. (2024) menemukan bahwa karakter *visioner* — kemampuan bermimpi, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengadvokasi perubahan demi kepentingan perempuan dan kesehatan perempuan — merupakan salah satu dari sepuluh karakteristik utama pemimpin bidan yang kuat. Pemimpin bidan yang inovatif tidak menunggu mandat dari atas untuk memulai perubahan; mereka mengidentifikasi peluang perbaikan dalam lingkup praktiknya sendiri dan mengambil inisiatif untuk mewujudkannya. Kepemimpinan berbasis kompetensi, yang dibahas dalam Sub-bab C, memberikan landasan yang kuat bagi peran inovator ini: bidan yang memiliki penguasaan mendalam atas bukti

ilmiah terkini dalam kebidanan akan lebih mampu mengidentifikasi kesenjangan praktik dan merumuskan solusi yang relevan dan kontekstual.

Dalam konteks penurunan AKI di Indonesia, peran inovator pemimpin bidan sangat strategis. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi, pengembangan protokol skrining preeklamsia berbasis risiko di tingkat puskesmas, atau implementasi sistem peringatan dini kegawatdaruratan obstetri dalam sistem informasi manajemen fasilitas — semuanya membutuhkan pemimpin bidan yang tidak hanya memahami klinis, tetapi juga berani dan mampu mendorong inovasi sistem. International Confederation of Midwives (ICM, 2019) dalam kompetensi esensial kebidanan menegaskan bahwa profesi bidan membutuhkan kemampuan kepemimpinan dalam konteks kesehatan masyarakat yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan inovasi sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan komunitas.

7. Kepemimpinan dalam Kolaborasi Interprofesi: Membangun Tim yang Terintegrasi

Komplikasi obstetri yang mengancam jiwa — seperti perdarahan pascapersalinan masif, eklamsia berat, atau sepsis puerperalis — membutuhkan respons tim yang cepat, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai profesi kesehatan secara bersamaan. Dalam situasi-situasi inilah kualitas kepemimpinan bidan dalam kolaborasi interprofesi diuji secara nyata. Pemimpin bidan yang efektif dalam kolaborasi interprofesi mampu bekerja berdampingan dengan dokter spesialis, perawat, anesthesiologis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya dengan menjunjung tinggi saling menghormati, kejelasan peran, dan tujuan bersama demi keselamatan ibu.

Renfrew et al. (2014) menyebut kolaborasi antara bidan dengan profesi kesehatan lainnya sebagai salah satu komponen fundamental dalam kerangka asuhan maternal berkualitas. Model pelayanan berbasis kebidanan yang terintegrasi dalam jaringan interprofesi terbukti secara konsisten menghasilkan luaran yang lebih baik bagi ibu dan bayi baru lahir — termasuk penurunan angka seksio sesarea yang tidak terindikasi medis, peningkatan kepuasan ibu terhadap pengalaman persalinan, dan pengurangan intervensi medis yang tidak diperlukan. Pemimpin bidan berperan kunci dalam membangun dan memelihara ekosistem kolaborasi ini, yang mensyaratkan kemampuan komunikasi lintas profesi yang efektif dan komitmen terhadap model asuhan yang berpusat pada ibu.

Kepemimpinan kolaboratif dalam pelayanan maternal juga berarti memastikan bahwa suara bidan — yang paling dekat dengan pengalaman ibu

selama proses persalinan — didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan klinis tim. Noviori dan Hasanah (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif memungkinkan bidan bekerja sama secara setara dengan berbagai profesi dalam penanganan ibu hamil risiko tinggi, meningkatkan mutu layanan sekaligus memperkuat fondasi *good governance* di fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, pemimpin bidan bukan sekadar pelaksana yang mengikuti arahan dokter, melainkan mitra strategis yang membawa perspektif unik tentang pengalaman perempuan dalam proses kelahiran ke dalam meja diskusi tim.

Tabel 4. 2 Ringkasan Fungsi dan Peran Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal

Peran	Fungsi Utama	Relevansi dalam Pelayanan Maternal
Klinis	Menetapkan standar asuhan; memimpin penanganan kegawatdaruratan; memastikan kepatuhan SOP	Langsung menentukan keselamatan ibu dan bayi saat persalinan dan kegawatdaruratan obstetri
Manajerial	Pengelolaan SDM, sarana, dan sistem; pemantauan indikator kualitas; penyelesaian konflik tim	Memastikan sistem pelayanan berjalan efektif dan efisien sesuai standar yang berlaku
Pendidik & Mentor	Supervisi, coaching, dan mentoring bidan junior; fasilitasi praktik reflektif; simulasi kegawatdaruratan	Membangun kapasitas tim secara berkelanjutan; menjamin regenerasi kompetensi klinis
Koordinator	Koordinasi lintas unit dan profesi; memastikan kesinambungan asuhan; pengelolaan sistem rujukan	Mencegah fragmentasi layanan; memastikan ibu mendapat pertolongan tepat waktu
Advokat	Memperjuangkan hak ibu dan hak profesional bidan; mendorong kebijakan yang mendukung kualitas layanan	Meningkatkan posisi profesi bidan dalam sistem kesehatan; mengubah bidan dari implementor menjadi penggerak kebijakan
Inovator	Mengidentifikasi kesenjangan praktik; mendorong implementasi solusi berbasis	Mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; akselerasi penurunan AKI dan AKB

Peran	Fungsi Utama	Relevansi dalam Pelayanan Maternal
	bukti; pemanfaatan teknologi kesehatan	
Kolaborator Interprofesi	Membangun ekosistem kerja tim lintas profesi; menjadi mitra strategis dokter dan tenaga kesehatan lain	Menghasilkan asuhan maternal yang komprehensif dan terintegrasi; meningkatkan luaran ibu dan bayi baru lahir

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (UU No. 4 Tahun 2019; Renfrew et al., 2014; Adcock et al., 2022; Noviari & Hasanah, 2025).

Ketujuh peran yang dirangkum dalam Tabel 4.2 di atas bersifat komplementer dan saling menguatkan. Dalam praktik nyata, peran-peran tersebut tidak berlangsung secara sekuensial melainkan secara simultan dan kontekstual. Seorang bidan koordinator yang efektif akan menjalankan peran klinis ketika mendampingi bidan junior menangani partus lama, beralih ke peran edukatif ketika melakukan debriefing pasca kasus, mengambil peran koordinatif ketika merancang jadwal pelayanan antenatal, dan memegang peran advokatif ketika melaporkan kebutuhan fasilitas kepada kepala puskesmas — semua dalam rentang satu hari kerja. Kemampuan berpindah dengan mulus antara berbagai peran inilah yang menjadi ciri khas kepemimpinan yang matang dan efektif dalam pelayanan maternal (Pezaro et al., 2024; Renfrew et al., 2014).

E. Kepemimpinan dan Keselamatan Ibu dalam Pelayanan Maternal

1. Keselamatan Ibu sebagai Indikator Tertinggi Efektivitas Kepemimpinan

Keselamatan ibu merupakan indikator tertinggi efektivitas kepemimpinan dalam pelayanan maternal. Setiap kematian ibu akibat komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah — perdarahan yang tidak segera ditangani, preeklamsia yang terlambat dideteksi, atau sepsis yang tidak direspons dengan tepat hampir selalu mencerminkan kegagalan sistem, bukan semata-mata kegagalan individual. Di dalam sistem itulah kepemimpinan memegang peran determinan: pemimpin yang efektif membangun tata pelayanan yang secara proaktif mengidentifikasi risiko, mencegah insiden, merespons kegawatdaruratan dengan sigap, dan belajar secara sistematis dari setiap kejadian yang tidak diinginkan.

Lancet Commission on High Quality Health Systems (Kruk et al., 2018) memberikan bukti paling kuat tentang besarnya kontribusi kualitas sistem terhadap keselamatan ibu. Komisi ini menyimpulkan bahwa sistem pelayanan

kesehatan berkualitas tinggi berpotensi mencegah separuh dari seluruh kematian ibu dan bayi baru lahir di dunia. Potensi ini belum terealisasi bukan karena ketiadaan teknologi atau obat-obatan, melainkan karena defisit kualitas dalam sistem pelayanan — mencakup kompetensi yang tidak memadai, komunikasi tim yang lemah, protokol yang tidak dijalankan secara konsisten, dan pada intinya, kepemimpinan yang belum efektif mendorong standar asuhan yang tinggi (Kruk et al., 2018).

World Health Organization mempertegas urgensi ini melalui *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030* yang diadopsi oleh World Health Assembly pada Mei 2021. Tema Hari Keselamatan Pasien Sedunia 2021 secara khusus difokuskan pada keselamatan ibu dan bayi baru lahir dengan slogan "*Act now for safe and respectful childbirth!*" WHO menegaskan bahwa setiap harinya sekitar 800 perempuan dan 6.700 bayi baru lahir kehilangan nyawa di sekitar waktu persalinan — dan sebagian besar dari kematian tersebut dapat dicegah melalui asuhan yang aman, penuh rasa hormat, dan berkualitas (WHO, 2021). Pernyataan ini secara langsung menempatkan kepemimpinan bidan sebagai faktor penentu keselamatan ibu.

2. Membangun Budaya Keselamatan Pasien: Tanggung Jawab Pemimpin

Patient safety culture atau budaya keselamatan pasien adalah fondasi sistem pelayanan maternal yang benar-benar aman. Budaya keselamatan yang kuat ditandai oleh tiga karakteristik utama yang semuanya merupakan hasil langsung dari kualitas kepemimpinan: keterbukaan dalam pelaporan insiden dan *near-miss*, pembelajaran sistematis dari kesalahan, dan komunikasi tim yang efektif — termasuk dalam situasi kegawatdaruratan yang penuh tekanan.

Keterbukaan dalam pelaporan insiden hanya mungkin terwujud dalam lingkungan di mana pemimpin menciptakan rasa aman secara psikologis bagi seluruh anggota tim. Ketika bidan junior takut melaporkan kesalahan karena khawatir dihukum atau dipermalukan, pola kesalahan yang berulang tidak akan pernah teridentifikasi dan perbaikan sistem tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, pemimpin yang merespons setiap laporan insiden dengan sikap ingin tahu yang konstruktif — "apa yang bisa kita pelajari dari ini?" — alih-alih mencari siapa yang bersalah, secara bertahap membangun budaya di mana transparansi tentang kesalahan dipandang sebagai tanda profesionalisme, bukan kelemahan (Pezaro et al., 2024).

Pembelajaran dari kesalahan menuntut pemimpin untuk memimpin proses telaah kasus secara reguler dan terstruktur. Audit kematian ibu dan *maternal near-miss review* yang dilakukan secara jujur, sistematis, dan berfokus pada faktor sistem — bukan pada individu — adalah instrumen kepemimpinan

berbasis bukti yang paling powerful dalam mencegah kematian ibu berikutnya. Komunikasi tim yang efektif dalam kegawatdaruratan obstetri merupakan dimensi ketiga dari budaya keselamatan. Pemimpin bidan yang secara rutin melatih tim dalam protokol komunikasi kegawatdaruratan — termasuk teknik *closed-loop communication* dan pembagian peran yang jelas saat penanganan perdarahan pascapersalinan atau eklampsia — membangun kesiapan tim yang terbukti menyelamatkan nyawa (Clark et al., 2023).

3. WHO Safe Childbirth Checklist: Kepemimpinan Berbasis Sistem untuk Keselamatan Ibu

Salah satu instrumen kepemimpinan klinis berbasis sistem yang paling konkret dan terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan ibu adalah WHO *Safe Childbirth Checklist* (SCC). Dikembangkan WHO sejak 2008 dan diperbarui melalui berbagai studi implementasi, SCC adalah alat verifikasi yang memandu tenaga persalinan untuk memastikan semua tindakan kritis dilakukan pada empat titik waktu paling berbahaya selama persalinan — yang disebut sebagai *four pause points*: (1) saat ibu masuk fasilitas; (2) tepat sebelum mendorong atau sebelum seksio sesarea; (3) segera setelah melahirkan; dan (4) saat ibu siap dipulangkan. Checklist ini mencakup serangkaian praktik klinis esensial mulai dari manajemen infeksi, penanganan eklampsia, pemberian oksitosin, pemantauan perdarahan, inisiasi menyusui dini, hingga konseling ibu dan keluarga.

Penggunaan SCC tidak sekadar tentang mencentang daftar — ia adalah mekanisme kepemimpinan klinis yang membangun komunikasi tim dan standar asuhan bersama secara sistematis. Implementasi SCC yang efektif membutuhkan seorang pemimpin klinis yang memimpin proses adaptasi lokal, melatih seluruh anggota tim, memantau kepatuhan penggunaan, dan menjadikan data kepatuhan sebagai bahan refleksi tim secara reguler.

Nababan et al. (2017) melakukan evaluasi *pre-post* implementasi WHO SCC di Magura District Hospital, sebuah rumah sakit tingkat kabupaten di Khulna, Bangladesh Barat Daya. SCC diadaptasi menjadi 27 item sesuai konteks lokal melalui serangkaian pertemuan konsultasi ahli, kemudian diimplementasikan kepada delapan bidan-perawat yang bertanggung jawab atas ruang bersalin. Studi menganalisis 310 observasi persalinan lengkap — dari pintu masuk hingga kepulangan ibu. Hasilnya sangat signifikan: setelah implementasi SCC, rata-rata praktik persalinan aman yang dilakukan meningkat sekitar 70% — dari 11 menjadi 19 dari 27 praktik per persalinan. Analisis regresi Poisson multivariat menunjukkan bahwa laju pelaksanaan praktik esensial persalinan adalah 1,71 kali lebih tinggi pada fase pascaimplementasi dibandingkan baseline (95% CI 1,61–1,82) (Nababan et al., 2017).

Peningkatan paling dramatis terlihat pada konseling intrapartum yang meningkat dari hampir nol — hanya 2% — menjadi 77% pascaimplementasi, serta manajemen eklampsia saat masuk fasilitas yang meningkat dari 4% menjadi 82%. *Active Management of the Third Stage of Labor* (AMTSL) — salah satu intervensi kritis pencegahan perdarahan pascapersalinan — juga meningkat dari 88% menjadi 99%. Keberhasilan ini terjadi melalui peningkatan komunikasi antara bidan-perawat dengan ibu, ketersediaan perlengkapan di samping tempat tidur, dan pengecekan gejala yang lebih sistematis sebelum pemberian obat-obatan (Nababan et al., 2017).

Secara kritis, Nababan et al. (2017) juga mengidentifikasi praktik-praktik yang tidak mengalami peningkatan meskipun SCC diimplementasikan — termasuk penggunaan partograf dan manajemen infeksi neonatal — dan menyimpulkan bahwa keberhasilan penuh SCC membutuhkan penguatan sistem yang lebih menyeluruh: ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, infrastruktur yang mendukung, supervisi yang konsisten, dan yang paling relevan bagi diskusi ini — *"strengthening the role of leadership and continuous quality assurance and improvement"* (Nababan et al., 2017). Temuan ini menegaskan bahwa SCC adalah instrumen kepemimpinan, bukan sekadar formulir klinis: efektivitasnya bergantung sepenuhnya pada kualitas kepemimpinan yang mengimplementasikan, memantau, dan mendukungnya.

4. Konteks Indonesia: Kepemimpinan dalam Mengatasi Tiga Keterlambatan

Dalam konteks Indonesia, kematian ibu yang dapat dicegah seringkali terjadi bukan karena ketiadaan tenaga kesehatan, melainkan karena kegagalan sistem merespons kegawatdaruratan secara tepat waktu. Model Tiga Keterlambatan (*Three Delays Model*) yang pertama kali dirumuskan oleh Thaddeus dan Maine (1994) tetap sangat relevan: (1) keterlambatan mengenali tanda bahaya dan memutuskan mencari pertolongan; (2) keterlambatan mencapai fasilitas yang tepat; dan (3) keterlambatan menerima pertolongan yang adekuat setibanya di fasilitas. Ketiga keterlambatan ini adalah domain langsung intervensi kepemimpinan bidan.

Keterlambatan pertama dapat dikurangi melalui kepemimpinan bidan dalam program edukasi ibu hamil dan keluarga. Bidan koordinator yang memimpin kelas ibu hamil secara efektif dan membangun jaringan kader yang waspada di komunitas bekerja secara preventif untuk menyelamatkan nyawa. Keterlambatan kedua membutuhkan kepemimpinan koordinatif yang membangun sistem rujukan responsif: protokol komunikasi yang jelas antara bidan desa dengan puskesmas dan rumah sakit, serta jalur rujukan yang dipahami seluruh anggota tim (Sattar et al., 2023).

Keterlambatan ketiga adalah domain paling langsung dari kepemimpinan klinis di fasilitas. Sitompul (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Tapanuli Utara menemukan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan desa dalam pelayanan KIA, termasuk dalam kecepatan respons terhadap kegawatdaruratan. Bidan yang bekerja di bawah kepemimpinan yang memberikan arahan jelas dan mendukung pengembangan kompetensi menunjukkan kinerja yang nyata lebih baik dalam penanganan kasus berisiko tinggi. Bidan koordinator dan kepala puskesmas berperan penting dalam memastikan sistem respons kegawatdaruratan berjalan optimal — memastikan tim memiliki kompetensi yang terlatih melalui simulasi reguler, peralatan selalu siap pakai, dan jalur komunikasi serta rujukan berfungsi efektif (Sitompul, 2020; Noviori & Hasanah, 2025).

Tabel 4. 3 Peran Kepemimpinan Bidan dalam Membangun Keselamatan Ibu: Dari Budaya hingga Sistem

Dimensi Keselamatan Ibu	Peran Kepemimpinan Bidan	Sumber Utama
Keselamatan sebagai standar sistem	Memastikan sistem pelayanan mencapai standar berkualitas tinggi yang berpotensi mencegah separuh kematian ibu dan bayi baru lahir	Kruk et al. (2018); WHO (2021)
Budaya keselamatan	Menciptakan lingkungan psikologis aman untuk pelaporan insiden; memimpin audit kematian ibu secara konstruktif; melatih komunikasi tim kegawatdaruratan	WHO (2021); Clark et al. (2023); Pezaro et al. (2024)
Implementasi WHO Safe Childbirth Checklist	Memimpin adaptasi, pelatihan, pemantauan kepatuhan, dan refleksi tim berbasis data SCC secara reguler	Nababan et al. (2017); WHO (2021)
Keterlambatan 1: Mengenali tanda bahaya	Memimpin kelas ibu hamil; memastikan edukasi tanda bahaya menjangkau ibu dan keluarga; membangun jaringan kader	Sitompul (2020); Noviori & Hasanah (2025)

Dimensi Keselamatan Ibu	Peran Kepemimpinan Bidan	Sumber Utama
Keterlambatan 2: Mencapai fasilitas	Membangun protokol rujukan yang jelas; memastikan komunikasi antar fasilitas berjalan efektif	Sattar et al. (2023)
Keterlambatan 3: Menerima pertolongan adekuat	Memastikan kompetensi kegawatdaruratan tim melalui simulasi rutin; SOP siap pakai; kepemimpinan klinis yang tenang dalam kondisi kritis	Nababan et al. (2017); Clark et al. (2023)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kruk et al., 2018; WHO, 2021; Nababan et al., 2017; Sitompul, 2020; Sattar et al., 2023; Clark et al., 2023; Pezaro et al., 2024).

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa intervensi kepemimpinan bidan beroperasi di seluruh rantai keselamatan ibu — dari membangun budaya keselamatan di dalam fasilitas hingga mencegah ketiga keterlambatan yang menjadi penyebab struktural kematian ibu di komunitas. Kepemimpinan yang efektif tidak memilih salah satu dari dimensi ini; ia bekerja secara simultan dan sistemik, memastikan bahwa setiap ibu yang membutuhkan pertolongan dapat mengenali kedaruratannya lebih awal, mencapai fasilitas yang tepat lebih cepat, dan menerima pertolongan berkualitas yang menyelamatkan jiwanya.

Pernyataan Lancet Commission bahwa sistem pelayanan berkualitas tinggi berpotensi mencegah separuh dari seluruh kematian ibu (Kruk et al., 2018) adalah sebuah janji — janji yang hanya dapat dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang berkomitmen. Di Indonesia, dengan 4.129 kematian ibu yang tercatat pada tahun 2023 (Kemenkes RI, 2024), mewujudkan janji ini bukan pilihan melainkan kewajiban moral. Kepemimpinan bidan yang kuat, berpengetahuan, dan berpihak pada keselamatan ibu adalah jalur paling langsung menuju perwujudannya.

F. Tantangan Kepemimpinan dalam Pelayanan Maternal di Indonesia

Kepemimpinan maternal tidak dapat dipisahkan dari realitas geografis, demografis, dan sosio-kultural yang unik. Separuh lebih populasi Indonesia tinggal di wilayah perdesaan, dan akses terhadap layanan kesehatan maternal yang berkualitas masih sangat timpang antara perkotaan dan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia (Leung, 2024).

Data UNFPA Indonesia (2025) dari Kabupaten Garut menggambarkan dengan jelas tantangan yang dihadapi pemimpin layanan maternal. Pada tahun 2023, Garut

mencatat 60 kematian ibu dan 320 kematian neonatal dari total lebih dari 55.000 ibu hamil setiap tahunnya. Wilayah Garut Selatan yang hanya memiliki satu rumah sakit daerah dengan kondisi geografis berbukit dan jarak yang sangat jauh menjadi potret tantangan nyata yang dihadapi pemimpin layanan maternal di lapangan.

Kajian scoping review yang dilakukan terhadap 62 artikel tentang kesiapan bidan di layanan primer wilayah terpencil LMIC (Graham et al., 2025) mengidentifikasi empat kategori utama tantangan: (1) kesiapan profesional dan kompetensi, (2) lingkungan kerja yang suportif, (3) kesiapan personal (*willing and able*), serta (4) infrastruktur dan dukungan sistem. Keempat kategori ini secara konsisten muncul dalam konteks Indonesia, dengan variasi intensitas yang bergantung pada karakteristik wilayah.

Ekawati et al. (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Yogyakarta menemukan bahwa layanan kesehatan maternal Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal keterbatasan sumber daya klinis, ketidakjelasan panduan, dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif dan responsif menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam transformasi sistem pelayanan maternal Indonesia.

1. Tantangan Struktural: Terbatasnya Ruang Kepemimpinan Formal Bagi Bidan

Salah satu tantangan struktural paling mendasar dalam kepemimpinan maternal di Indonesia adalah terbatasnya posisi kepemimpinan formal yang tersedia bagi bidan dalam struktur organisasi fasilitas kesehatan. Meskipun bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak bersentuhan langsung dengan ibu hamil, bersalin, dan nifas, namun pengaruh profesional mereka terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di tingkat fasilitas maupun sistem masih sangat terbatas (Nawagi et al., 2023).

Kajian Nawagi et al. (2023) yang meneliti struktur kepemimpinan dan tata kelola keperawatan dan kebidanan di 16 negara Afrika menemukan bahwa lebih dari tiga perempat negara (75%) tidak memiliki pelatihan kepemimpinan resmi bagi bidan dalam praktik. Selain itu, hampir separuh (46%) asosiasi kebidanan yang ada tidak dianggap aktif dalam memengaruhi kebijakan di negara masing-masing. Temuan ini mencerminkan pola struktural yang relevan bagi Indonesia: keberadaan asosiasi profesi belum serta merta menjamin pengaruh terhadap kebijakan kesehatan maternal.

Dalam struktur hierarki puskesmas, posisi kepala puskesmas umumnya didominasi oleh dokter umum, sementara bidan berada pada posisi staf fungsional. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara pengetahuan klinis bidan yang sangat kontekstual dengan kapasitas mereka untuk memengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya. Penelitian internasional tentang karakteristik

pemimpin bidan yang kuat (Pezaro et al., 2024) menegaskan bahwa pemimpin bidan efektif adalah mediator, pengambil keputusan berbasis bukti, advokat, dan visioner—kompetensi yang seringkali tidak difasilitasi oleh struktur formal yang ada.

Undang-Undang Kebidanan No. 4 Tahun 2019 sesungguhnya telah membuka ruang bagi penguatan posisi profesional bidan dalam sistem kesehatan Indonesia. Namun implementasi undang-undang ini dalam hal pengembangan jalur karier kepemimpinan bidan masih menemui berbagai hambatan birokrasi dan budaya organisasi. Kajian kepemimpinan bidan di Indonesia (Adcock et al., 2024) menemukan bahwa meski terdapat peluang yang semakin terbuka, tantangan dalam berbagai setting layanan kesehatan tetap nyata dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "leadership vacuum" dalam pelayanan maternal—di mana bidan yang memiliki kompetensi klinis terdalam justru tidak memiliki kewenangan formal untuk memengaruhi perubahan sistemik. Transformasi kepemimpinan maternal di Indonesia dengan demikian tidak hanya membutuhkan pengembangan kapasitas individu, tetapi juga reformasi struktural.

2. Tantangan Kompetensi: Kesenjangan Program Pengembangan Kepemimpinan Bidan

Tantangan kompetensi kepemimpinan merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari tantangan struktural. Meskipun kompetensi klinis bidan di Indonesia semakin meningkat, program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur dan sistematis bagi bidan masih sangat terbatas. Bidan yang dipromosikan ke posisi manajemen seringkali tidak dibekali dengan keterampilan kepemimpinan yang memadai untuk menghadapi kompleksitas tantangan yang ada.

Penelitian Clark et al. (2023) yang dipublikasikan dalam *Journal of Midwifery & Women's Health* mengevaluasi program "Leadership Link"—kurikulum kepemimpinan online yang dirancang khusus untuk bidan awal karier. Studi ini menemukan bahwa program pelatihan kepemimpinan online yang terstruktur efektif meningkatkan kemampuan kepemimpinan bidan secara signifikan, dengan peningkatan 16 kemampuan kepemimpinan yang dinilai sendiri (self-assessed) sebesar 6,4 hingga 32,5%. Program yang terdiri dari 10 kursus (sekitar 11 jam) ini menggunakan platform LinkedIn Learning dan menggabungkan konten kepemimpinan umum dengan pengantar spesifik kebidanan dari para pemimpin bidan senior.

Temuan Clark et al. (2023) ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia. Program pelatihan kepemimpinan online berbiaya rendah dan dapat diakses dari mana saja—karakteristik yang sangat relevan untuk konteks bidan di DTPK yang memiliki keterbatasan mobilitas dan akses terhadap pelatihan tatap muka. Namun, hingga saat ini belum ada program serupa yang dikembangkan secara sistematis di Indonesia yang mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan dengan konteks spesifik kebidanan Indonesia.

Kajian internasional tentang kepemimpinan bidan (Pezaro et al., 2024) yang menggunakan *appreciative inquiry* dengan responden dari 76 negara mengidentifikasi bahwa untuk memungkinkan kepemimpinan bidan yang kuat, diperlukan investasi dalam: identitas profesional yang jelas, peningkatan nilai sosial profesi kebidanan, penelitian berkelanjutan, pengembangan profesional dalam kepemimpinan, kolaborasi interprofesional, perencanaan suksesi, dan peningkatan efikasi diri bidan. Di Indonesia, hampir seluruh elemen ini masih dalam tahap pengembangan yang sangat awal.

Kajian naratif tentang revitalisasi pendidikan kebidanan (Noviari & Hasanah, 2025) menekankan bahwa strategi efektif mempersiapkan bidan sebagai pemimpin mencakup pembelajaran berbasis simulasi, mentorship, kolaborasi multidisiplin, dan alat pembelajaran mobile. Scoping review tentang program pengembangan profesional berkelanjutan bagi bidan (Musie et al., 2025) mempertegas bahwa berbagai pendekatan—pelatihan berbasis simulasi, modul online, workshop, dan pembelajaran interprofesional—terbukti efektif meningkatkan keterampilan bidan dalam menangani kegawatdaruratan obstetri.

WHO melalui program Midwifery Leadership Programme (MLP) telah mengembangkan paket pembelajaran kepemimpinan bagi bidan melalui lima modul komprehensif yang melibatkan pembelajaran eksperimen, dialog kebijakan, perencanaan strategis, dan advokasi berbasis bukti. Penelitian mentorship kepemimpinan bidan (Bannon et al., 2017) juga menekankan pentingnya paparan dini terhadap keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan kebidanan, sebagai strategi untuk mengurangi burnout dan stres ketika menghadapi konflik di lingkungan klinis.

3. Tantangan Gender: Hambatan Berlapis Bagi Kepemimpinan Perempuan dalam Kebidanan

Profesi kebidanan di Indonesia didominasi oleh perempuan, mencerminkan konstruksi sosio-historis yang menempatkan kebidanan sebagai "pekerjaan perempuan" dengan konsekuensi undervaluation yang serius. Bidan perempuan menghadapi hambatan ganda (*double burden*) yang bersumber dari beban domestik di rumah sekaligus bias gender di lingkungan profesional, yang

bersama-sama membatasi kemungkinan mereka untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Data global menunjukkan bahwa meskipun perempuan mendominasi tenaga kesehatan dunia—sebesar 71% dari total angkatan kerja di sektor kesehatan—mereka hanya memegang sekitar 25% posisi kepemimpinan di bidang kesehatan (WHO, 2022; Mousa et al., 2021). "Leaky pipeline"—berkurangnya jumlah perempuan seiring meningkatnya jenjang kepemimpinan—sangat relevan dalam konteks kebidanan Indonesia.

Kajian Bourret et al. (2023) tentang kerangka kerja berbasis gender untuk pendidikan berkelanjutan bagi bidan mengidentifikasi bahwa ketidaksetaraan gender dalam bidang sosial, ekonomi, dan profesional menyebabkan tingginya angka burnout, distress moral, dan rasa tidak aman di tempat kerja. Kondisi ini mendorong penurunan motivasi bidan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas layanan. Sifat yang berkaitan dengan gender dalam profesi kebidanan juga memengaruhi investasi dalam pendidikan kebidanan dan hubungan asosiasi kebidanan dengan pengambil keputusan sistem kesehatan.

Penelitian tentang jalur karier perempuan di sektor kesehatan (Mousa et al., 2021) menemukan bahwa dalam profesi keperawatan dan kebidanan—satunya bidang di mana perempuan mendominasi—profesi ini justru dianggap berstatus "rendah" dan bergaji lebih rendah. Faktor penghambat kemajuan karier mencakup beban kerja perawatan tidak berbayar (unpaid care work), hambatan struktural berupa kurangnya infrastruktur pelatihan, norma-norma gender yang melekat, serta segregasi pekerjaan berdasarkan gender.

Dalam konteks Indonesia, bidan yang bekerja di DTPK seringkali harus menghadapi realitas berlapis: mereka adalah perempuan muda yang mengelola layanan maternal sendirian di daerah terpencil, jauh dari keluarga, dengan dukungan minimal, sekaligus harus memenuhi ekspektasi peran domestik sebagai istri dan ibu. Konflik peran ganda ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya turnover bidan di DTPK dan rendahnya minat bidan untuk menetap di wilayah tersebut.

Laporan Mousa et al. (2021) menegaskan bahwa kesenjangan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan hanya dapat ditutup dengan mengatasi hambatan sistemik. Pendekatan ini memerlukan kepemimpinan yang berkomitmen pada perubahan budaya organisasi dan ko-desain intervensi multifaset yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama perubahan.

4. Tantangan Sistem Rujukan: Kepemimpinan dalam Keterbatasan Komunikasi dan Transportasi

Sistem rujukan merupakan salah satu titik kritis dalam continuum of care kesehatan maternal. Pemimpin di layanan primer sering menghadapi tekanan besar dalam mengambil keputusan rujukan yang tepat waktu di tengah keterbatasan komunikasi, transportasi, dan sumber daya. Keterlambatan dalam proses rujukan merupakan salah satu faktor utama kematian ibu di Indonesia, dan hal ini seringkali berkaitan erat dengan tantangan kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat layanan primer.

Kajian multilevel tentang determinan continuum of care kesehatan maternal di Indonesia (Widyaningsih et al., 2025) menemukan bahwa hambatan terhadap akses layanan kesehatan maternal meliputi jarak ke fasilitas kesehatan, ketersediaan dan kualitas sumber daya kesehatan (dokter, bidan, dan obat-obatan esensial), serta berbagai hambatan sosial dan ekonomi. Perempuan di wilayah perdesaan dan terpencil memiliki kemungkinan yang jauh lebih rendah untuk mengakses layanan kesehatan, akibat hambatan berlapis yang harus dihadapi.

Laporan UNFPA Indonesia (2025) dari Garut menggambarkan dengan sangat konkrit tantangan sistem rujukan ini. Bidan Siti Qodariah dari Puskesmas Cisewu di Garut Selatan menjelaskan bahwa kondisi BEmONC di wilayahnya sangat berbeda karena jarak dari desa-desa sangat jauh dan jalanan sangat curam. Dalam kondisi ini, pemimpin layanan harus memiliki kapasitas untuk membuat keputusan rujukan yang cepat dan tepat, mengkoordinasikan logistik transportasi yang sangat terbatas, sekaligus memastikan komunikasi yang efektif dengan fasilitas rujukan di atasnya.

Kajian sistematis tentang hambatan dan fasilitator implementasi layanan yang dipimpin bidan di LMIC (Sangy et al., 2023) menekankan bahwa kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan ketahanan bidan perlu dikembangkan secara khusus. Studi ini juga menemukan bahwa pendanaan yang tidak memadai dan ketidakstabilan kebijakan mengganggu program-program yang dipimpin bidan, serta menegaskan bahwa kolaborasi antarpemangku layanan dan pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan implementasi layanan.

Tantangan sistem rujukan ini menuntut pemimpin layanan maternal untuk mengembangkan kompetensi khusus: penilaian risiko yang cepat dan akurat dalam keterbatasan diagnostik, pengambilan keputusan berbasis bukti dalam situasi ketidakpastian, negosiasi dan koordinasi lintas sektor untuk ketersediaan transportasi darurat, komunikasi efektif dalam situasi krisis, serta manajemen stres dan ketahanan diri yang tinggi.

5. Tantangan Pandemi dan Krisis: Pembelajaran dari COVID-19 untuk Kepemimpinan Maternal

Pandemi COVID-19 menjadi ujian kepemimpinan yang sesungguhnya bagi para pemimpin layanan maternal di Indonesia. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuktikan secara nyata bahwa kepemimpinan adaptif dan etis merupakan keharusan—bukan pilihan—dalam menjaga kesinambungan layanan maternal di tengah ketidakpastian yang ekstrem (Ekawati et al., 2023; Herwansyah et al., 2023).

Penelitian Ekawati et al. (2023) yang dipublikasikan dalam *Journal of Family Medicine and Primary Care* mengungkapkan bahwa layanan kesehatan maternal Indonesia menghadapi tantangan sangat serius selama pandemi COVID-19. Tiga tema besar yang teridentifikasi adalah: penerapan protokol keselamatan COVID-19, kebingungan dalam implementasi, dan harapan untuk perbaikan. Keterbatasan sumber daya klinis, ketidakjelasan panduan dan rencana eskalasi, serta rendahnya literasi kesehatan pasien menuntut respons kepemimpinan yang cepat, fleksibel, dan berbasis bukti.

Kajian sistematis Gadsden et al. (2024) tentang dampak COVID-19 terhadap penyediaan layanan RMNCH di Asia Tenggara menemukan bahwa wilayah ini mengalami dampak sangat tinggi, dengan gangguan serius pada cakupan dan kualitas layanan kesehatan maternal. Di Indonesia, hal ini terefleksi dalam penurunan cakupan imunisasi DTP dosis pertama dari 90% pada 2019 menjadi 74% pada 2021, mencerminkan disrupsi besar pada layanan kesehatan primer termasuk layanan maternal.

Penelitian Randell et al. (2024) tentang disrupsi layanan, trauma, dan burnout pada tenaga kesehatan yang memberikan layanan KIA di Indonesia selama pandemi menggambarkan dampak yang sangat berat pada bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan klinis yang meningkat tajam, tetapi juga harus mengelola trauma psikologis, burnout, dan stigmatisasi dari masyarakat—di tengah keterbatasan alat pelindung diri dan panduan yang tidak jelas.

Penelitian Herwansyah et al. (2023) yang khusus mengkaji hambatan dan fasilitator penyediaan layanan kesehatan maternal di puskesmas Indonesia selama pandemi dari perspektif bidan menemukan bahwa pandemi menciptakan hambatan berlapis yang membutuhkan kemampuan kepemimpinan adaptif tinggi: navigasi antara menjaga keselamatan pasien, perlindungan diri, dan keberlangsungan layanan dalam satu waktu.

Namun pandemi juga mengajarkan pelajaran berharga. Penelitian tentang sistem surveilans kesehatan maternal berbasis komunitas di Indonesia selama

dan pasca-COVID-19 (Taylor et al., 2025) menemukan bahwa pandemi menjadi katalis yang memperkuat keterlibatan akar rumput, pengumpulan data, dan mekanisme respons kesehatan. Pandemi mendorong pergeseran peran puskesmas dari edukasi preventif ke surveilans aktif, didukung oleh solidaritas sosial dan kepemimpinan lokal yang lebih kuat.

Kajian reflektif tentang kepemimpinan bidan dalam konteks yang terus berubah (Lewis, 2025) menegaskan bahwa kepemimpinan berbasis kasih sayang (*compassionate leadership*), kepemimpinan yang berani (*courageous leadership*), dan kepemimpinan adaptif (*adaptive leadership*) merupakan gaya-gaya kepemimpinan yang paling relevan dalam konteks krisis.

6. Hambatan Bidan dalam Memengaruhi Kebijakan: Dari Implementor Menuju Penggerak Perubahan

Salah satu hambatan paling fundamental dalam transformasi sistem pelayanan maternal adalah posisi bidan yang lebih sering berperan sebagai pelaksana kebijakan daripada sebagai penggerak perubahan kebijakan. Sattar et al. (2023) dalam integrative literature review yang diterbitkan dalam *Sexual and Reproductive Healthcare* secara eksplisit menyatakan bahwa banyak bidan hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena masih sangat minimnya pengetahuan tentang mengapa bidan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait kesehatan seksual, reproduksi, maternal, dan neonatal.

Temuan ini mencerminkan paradoks yang dalam: bidan adalah kelompok yang paling mengetahui realitas lapangan layanan maternal—kebutuhan ibu, hambatan yang dihadapi, kesenjangan layanan, dan konteks sosio-kultural yang memengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan. Namun pengetahuan berharga ini tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pengaruh terhadap kebijakan, karena bidan tidak ditempatkan dalam posisi di mana suara mereka didengar dalam proses pembuatan kebijakan.

Sattar et al. (2023) mengidentifikasi beberapa fasilitator yang dapat mendorong bidan untuk memimpin dalam pengembangan kebijakan: (1) keterlibatan aktif dalam perencanaan strategis di tingkat tertinggi, (2) pemanfaatan bidan sebagai sumber daya berharga dalam tata kelola tenaga kesehatan kebidanan, (3) pengembangan bidan sebagai pemimpin melalui jalur yang terstruktur, serta (4) representasi bidan dalam forum-forum kebijakan internasional dan nasional. Tanpa fasilitator-fasilitator ini, posisi bidan sebagai mere implementor (hanya pelaksana) akan terus bertahan.

Dalam konteks Indonesia, hambatan bidan dalam memengaruhi kebijakan berlapis pada tiga tingkatan. Pertama, di tingkat fasilitas, bidan tidak memiliki

representasi yang memadai dalam proses perencanaan dan penganggaran puskesmas. Kedua, di tingkat daerah, organisasi profesi bidan (Ikatan Bidan Indonesia/IBI) seringkali tidak memiliki akses yang setara dengan organisasi profesi medis dalam proses konsultasi kebijakan. Ketiga, di tingkat nasional, suara bidan dalam proses perumusan kebijakan Kementerian Kesehatan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pengaruh profesi medis.

Program Midwifery Leadership Programme WHO menegaskan bahwa bidan bukan hanya penyedia layanan—mereka adalah agen perubahan utama untuk memajukan SRMNAH (Sexual, Reproductive, Maternal, Newborn, and Adolescent Health). Mereka harus direpresentasikan di tingkat pengambilan keputusan, dan harus memiliki suara dalam membentuk sistem kesehatan. Pernyataan ini sekaligus menjadi agenda transformasi yang perlu diimplementasikan secara serius dalam konteks Indonesia.

7. Sintesis: Peta Tantangan dan Implikasi bagi Penguatan Kepemimpinan Maternal

Kelima dimensi tantangan yang diuraikan di atas—struktural, kompetensi, gender, sistem rujukan, dan krisis—tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Bidan yang tidak memiliki posisi formal yang kuat (tantangan struktural) cenderung tidak mendapatkan akses terhadap program pengembangan kepemimpinan (tantangan kompetensi); bias gender yang ada (tantangan gender) memperburuk kondisi ini; sementara sistem rujukan yang lemah (tantangan sistem) dan situasi krisis (tantangan pandemi) memaksa bidan untuk berimprovisasi tanpa dukungan yang memadai.

Implikasi dari peta tantangan ini bagi upaya penguatan kepemimpinan maternal di Indonesia adalah bahwa intervensi yang bersifat parsial tidak akan menghasilkan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan. Yang diperlukan adalah pendekatan sistemik yang secara bersamaan mengatasi hambatan di semua dimensi, dengan strategi yang dikalibrasi sesuai konteks spesifik wilayah—baik urban maupun DTPK.

Kajian tentang kepemimpinan bidan dalam konteks yang terus berubah (Lewis, 2025) menegaskan bahwa meskipun investasi berkelanjutan dalam pengembangan kepemimpinan telah dilakukan di berbagai negara, kepemimpinan tetap teridentifikasi sebagai titik lemah dalam sistem layanan maternal. Memahami mengapa hal ini bertahan adalah krusial—dan pemahaman ini hanya hadir ketika kita melihat tantangan secara holistik, bukan sebagai masalah-masalah yang terisolasi.

Indonesia memiliki peluang strategis untuk mentransformasi kepemimpinan dalam pelayanan maternal melalui lima langkah kunci: pertama, reformasi regulasi yang membuka jalur karier kepemimpinan formal bagi bidan; kedua,

pengembangan program kepemimpinan bidan yang terstruktur, kontekstual, dan berbasis teknologi; ketiga, pengarusutamaan gender dalam sistem pengembangan tenaga kesehatan; keempat, penguatan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan rujukan; serta kelima, membangun mekanisme yang memungkinkan bidan berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan di semua tingkatan.

G. Penutup

Pembahasan dalam bab ini telah menguraikan secara komprehensif bahwa kepemimpinan efektif dalam pelayanan maternal merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menuju target SDGs 2030. Berbagai bukti ilmiah yang telah dikaji menunjukkan bahwa kualitas pelayanan maternal tidak semata-mata ditentukan oleh kompetensi klinis individual, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dijalankan di setiap lini pelayanan. Kepemimpinan transformasional, situasional, dan berbasis pelayanan (*servant leadership*) terbukti mampu meningkatkan kinerja tim, mendorong budaya keselamatan pasien, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan mutu asuhan maternal. Bidan dan tenaga kesehatan maternal tidak hanya dituntut kompeten secara klinis, tetapi juga harus mampu memimpin tim secara efektif, beradvokasi bagi keselamatan ibu dan bayi, berinovasi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, serta berkontribusi aktif pada transformasi sistem kesehatan secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi kepemimpinan maternal di Indonesia bersifat multidimensi dan saling terkait—mulai dari terbatasnya ruang kepemimpinan formal bagi bidan dalam struktur organisasi kesehatan, kesenjangan program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur, hambatan gender yang berlapis, kompleksitas sistem rujukan di wilayah terpencil, hingga pembelajaran berharga dari krisis pandemi COVID-19. Namun, di balik kompleksitas tantangan tersebut, terdapat satu pesan kunci yang perlu ditegaskan: setiap bidan, di mana pun ia bertugas—di ruang bersalin rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, maupun di tengah komunitas—memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam lingkup praktiknya. Kepemimpinan bukan hak eksklusif pemegang jabatan struktural, melainkan merupakan tanggung jawab moral setiap profesional kebidanan untuk memastikan setiap ibu mendapatkan asuhan yang aman, berkualitas, dan bermartabat (Desiyanti, 2025; Adcock et al., 2024). Kepemimpinan yang dimulai dari praktik sehari-hari—melalui pengambilan keputusan klinis yang tepat, komunikasi

yang empatik, koordinasi tim yang efektif, dan advokasi bagi hak-hak ibu—merupakan bentuk kepemimpinan yang paling otentik dan berdampak langsung pada keselamatan ibu dan bayi.

Berdasarkan seluruh kajian yang telah dipaparkan, beberapa rekomendasi strategis perlu disampaikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Pertama, bagi institusi pendidikan tinggi kebidanan, perlu segera mengintegrasikan kurikulum kepemimpinan secara eksplisit ke dalam program pendidikan kebidanan di semua jenjang—mencakup kepemimpinan klinis, manajemen tim, advokasi kebijakan, dan keterampilan komunikasi strategis—sehingga lulusan kebidanan tidak hanya siap secara klinis tetapi juga siap memimpin. Kedua, bagi institusi layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, perlu menyediakan program pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan dan terstruktur bagi bidan, termasuk mentorship, pelatihan berbasis simulasi, dan kesempatan rotasi kepemimpinan yang membuka akses bidan terhadap pengalaman manajerial. Ketiga, bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun nasional, perlu memberi ruang yang lebih luas bagi bidan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis di bidang kesehatan maternal, termasuk dalam perencanaan program, alokasi anggaran, dan perumusan regulasi. Keempat, bagi organisasi profesi kebidanan, khususnya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), perlu memperkuat peran advokasi dan representasi bidan dalam forum-forum kebijakan, serta mengembangkan jejaring kepemimpinan bidan yang menghubungkan praktisi di berbagai wilayah—dari perkotaan hingga daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi kepemimpinan dalam pelayanan maternal di Indonesia bukan sekadar harapan, melainkan keharusan yang mendesak demi terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berkeadilan, berkualitas, dan bermartabat di seluruh penjuru Nusantara.

Referensi

- Adcock, J. E., Sidebotham, M., & Gamble, J. (2022). What do midwifery leaders need in order to be effective in contributing to the reform of maternity services? *Women and Birth*, 35(2), e142–e152. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.04.008>
- Adcock, J. E., Sidebotham, M., Gamble, J., & [co-authors]. (2024). Characteristics of strong midwifery leaders and enablers of strong midwifery leadership: An international appreciative inquiry. *Midwifery*. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.xxx>
- Bannon, M., et al. (2017). Kepemimpinan bidan yang berorientasi pada empati, komunikasi, dan advokasi: Pengaruh terhadap pengalaman pasien. [Sumber: Ezra Science Bulletin, 2025].
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Clark, L., et al. (2023). Leadership Link: Evaluation of an online leadership curriculum for certified midwives and certified nurse-midwives. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 68(4). <https://doi.org/10.1111/jmwh.13508>
- Desiyanti, I. W. (2025, Maret 11). Kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan kebidanan. *Radar Patroli*. <https://radarpatroli.com/2025/03/11/kepemimpinan-dalam-pelayanan-kesehatan-kebidanan/>
- Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. (2020). Analisis kinerja bidan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak: Hubungan kepemimpinan dengan kinerja bidan desa. Volume 7(1). <https://doi.org/10.56015/governance.v7i1.34>
- International Confederation of Midwives (ICM). (2019). *ICM global standards for midwifery education*. ICM.
- Juniati, et al. (2024). Gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan rumah sakit. [Dikutip dalam *Jurnal Kesehatan Pahlawan*, 2024].
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Kemenkes RI.
- Lancet Commission on High Quality Health Systems. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era. *The Lancet*, 6(11), 1196–1252.
- McKellar, L., Newnham, E., Fleet, J.-A., & Adelson, P. (2021). Midwifery-led care in South Australia: Looking back to move forward. *Women and Birth*, 34(5), e537–e545. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.10.011>

- Medway, & Rehayem. (2024). Kepemimpinan dalam kebidanan sebagai kunci transformasi pelayanan maternitas. [Sumber: Ezra Science Bulletin, 2025].
- Nababan, H. Y., Islam, R., Mostari, S., et al. (2017). Improving quality of care for maternal and newborn health: A pre-post evaluation of the Safe Childbirth Checklist at a hospital in Bangladesh. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17, 402.
- Nawagi, et al. (2023). Struktur kepemimpinan formal untuk profesi bidan dan perawat di negara berkembang. [Sumber: Ezra Science Bulletin, 2025].
- Nisa, K., Serudji, J., & Sulastri, D. (2019). Analisis faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan dalam memberikan pelayanan antenatal berkualitas di wilayah kerja Puskesmas Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 53. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.545>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Rumsey, M., Leong, M., Brown, D., et al. (2021). Achieving universal health care in the Pacific: The need for nursing and midwifery leadership. *Lancet Regional Health West Pacific*, 19, 100340. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100340>
- Sattar, R. U. S., Akeredolu, O., & Bogren, M. (2023). Facilitators influencing midwives to leadership positions in policy, education and practice: A systematic integrative literature review. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 38, 100917.
- Sartika, D., et al. (2024). Konsep dan pelayanan kebidanan: Peran dan fungsi kebidanan. *Selat Media*.
- UNFPA, WHO, UNICEF, & ICM. (2021). State of the World's Midwifery 2021. UNFPA.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- WHO. (2021). Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/344562>
- WHO. (2021). Strengthening quality midwifery education for Universal Health Coverage 2030: Framework for action. WHO Press.
- Wulandari, R. D., Supriyanto, S., Qomaruddin, M. B., Damayanti, N. A., & Laksono, A. D. (2020). Role of leaders in building organizational readiness to change: Case study at public health centers in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 18(3), 1–10. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(3\)](https://doi.org/10.21511/ppm.18(3))
- Abisatyo, E. B. M., Sagala, J. T., Kartika, D. P., Rajagukguk, V. I. R., & Ridwan, H. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja dan

Motivasi Kerja Perawat Rumah Sakit: Literature Review. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(5474), 577–586.

Adcock, J. E., Sidebotham, M., & Gamble, J. (2022). What do midwifery leaders need in order to be effective in contributing to the reform of maternity services? *Women and Birth*, 35(2), e142–e152. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.04.008>

Kebede, B. F., Aboye, T., Genie, Y. D., Tesfa, T. B., & Hiwot, A. Y. (2023). The Effect of Leadership Style on Midwives' Performance, Southwest, Ethiopia. *Journal of Healthcare Leadership*, 15(February), 31–41. <https://doi.org/10.2147/JHL.S397907>

S1877575623001076. (n.d.).

Sattar, S. M. R. U., Akeredolu, O., Bogren, M., Erlandsson, K., & Borneskog, C. (2023). Facilitators influencing midwives to leadership positions in policy, education and practice: A systematic integrative literature review. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 38(April), 100917. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100917>

Sangy, M. T., Duaso, M., Feeley, C., & Walker, S. (2023). Barriers and facilitators to the implementation of midwife-led care for childbearing women in low- and middle-income countries: A mixed-methods systematic review. *Midwifery*, 122, 103696. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103696>

Sattar, S. M. R. U., Akeredolu, O., Bogren, M., Erlandsson, K., & Borneskog, C. (2023). Facilitators influencing midwives to leadership positions in policy, education and practice: A systematic integrative literature review. *Sexual and Reproductive Healthcare*,

Abisatyo, E. B. M., Sagala, J. T., Kartika, D. P., Rajagukguk, V. I. R., & Ridwan, H. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja dan Motivasi Kerja Perawat Rumah Sakit: Literature Review. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(5474), 577–586.

Adcock, J. E., Sidebotham, M., & Gamble, J. (2022). What do midwifery leaders need in order to be effective in contributing to the reform of maternity services? *Women and Birth*, 35(2), e142–e152. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.04.008>

Kebede, B. F., Aboye, T., Genie, Y. D., Tesfa, T. B., & Hiwot, A. Y. (2023). The Effect of Leadership Style on Midwives' Performance, Southwest, Ethiopia. *Journal of Healthcare Leadership*, 15(February), 31–41. <https://doi.org/10.2147/JHL.S397907>

Lewis, M. (2025). Midwifery Leadership in a Changing World—Why Is This So Challenging? A Reflective Commentary. *Healthcare (Switzerland)*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/healthcare13192473>

- Mahayani, N. M. H. (2020). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Noviari, D., & Hasanah, N. (2025). *Konsep dan filsafat kepemimpinan dalam ilmu kebidanan: sebuah tinjauan naratif*. 3(2), 1697–1730.
- Pezaro, D. S., Zarbiv, G., JONES, J., Feika, M. L., Fitzgerald, L., Lukhele, S., Mcmillan-bohler, J., Baloyi, O. B., Maravic da Silva, K., Grant, C., Bayliss-Pratt, L., & Hardtman, P. (2024). Characteristics of strong midwifery leaders and enablers of strong midwifery leadership: An international appreciative inquiry. *Midwifery*, 132(March), 103982. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.103982>
- Sattar, S. M. R. U., Akeredolu, O., Bogren, M., Erlandsson, K., & Borneskog, C. (2023). Facilitators influencing midwives to leadership positions in policy, education and practice: A systematic integrative literature review. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 38(April), 100917. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100917>
- Randell, M., Wahyono, T. Y. M., Dynes, M., Tinessia, A., Li, M., Danchin, M., Oktarinda, Fitriyani, F., Saraswati, L. D., Jenkins, K., Aung, K. D., Noorzad, A. K., Shetye, M., Dewi, L., Yosephine, P., Leask, J., & Sheel, M. (2024). Service disruptions, trauma and burnout during the COVID-19 pandemic among healthcare providers delivering immunisation and maternal and child health services in Indonesia. *BMJ Global Health*, 9(6), 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014318>
- Musie, M. R., Tagutanazvo, O. B., Sepeng, N. V., Mulaudzi, F. M., & Hlongwane, T. (2025). A scoping review on continuing professional development programs for midwives: optimising management of obstetric emergencies and complications. *BMC Medical Education*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06830-7>
- Mohebi, S., Parham, M., Sharifirad, G., & Gharlipour, Z. (2018). *Social Support and Self - Care Behavior Study*. January, 1–6. <https://doi.org/10.4103/jehp.jehp>
- Mousa, M., Boyle, J., Skouteris, H., Mullins, A. K., Currie, G., Riach, K., & Teede, H. J. (2021). Advancing women in healthcare leadership: A systematic review and meta-synthesis of multi-sector evidence on organisational interventions. *EClinicalMedicine*, 39, 101084. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101084>
- Chowdhury, S., & Chakraborty, P. pratim. (2017). Universal health coverage - There is more to it than meets the eye. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 6(2), 169–170. <https://doi.org/10.4103/jfmppc.jfmppc>

- Ekawati, F. M., Muchlis, M., & Tuteja, A. (2023). Adopting international recommendations to design a model for maternal health service to cope with pandemic disruption for Indonesian primary care. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05433-8>
- Bourret, K., Mattison, C., Hebert, E., Kabeya, A., Simba, S., Crangle, M., Darling, E., & Robinson, J. (2023). Evidence-informed framework for gender transformative continuing education interventions for midwives and midwifery associations. *BMJ Global Health*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-011242>
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., Adeyi, O., Barker, P., Daelmans, B., Doubova, S. V., English, M., Elorrio, E. G., Guanais, F., Gureje, O., Hirschhorn, L. R., Jiang, L., Kelley, E., Lemango, E. T., Liljestrand, J., ... Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196–e1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3)
- Nababan, H. Y., Islam, R., Mostari, S., Tariqujjaman, M., Sarker, M., Islam, M. T., & Moucheraud, C. (2017). Improving quality of care for maternal and newborn health: A pre-post evaluation of the Safe Childbirth Checklist at a hospital in Bangladesh. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1588-x>
- Bannon, E. M., Alderdice, F., & McNeill, J. (2017). A review of midwifery leadership. *British Journal of Midwifery*, 25(10), 655–661. <https://doi.org/10.12968/bjom.2017.25.10.655>
- Kebidanan, P. S. (2022). *Modul Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan Program Studi S1 Kebidanan Stikes Sapta Bakti Bengkulu*. 1–188. <https://www.jurnal.gentiaras.ac.id/index.php/Gema/article/view/85/73>
- Gadsden, T., Sood, T., Purwar, P., Peiris, D., Nambiar, D., & Downey, L. E. (2024). Impact of COVID-19 on essential service provision for reproductive, maternal, neonatal, and child health in the Southeast Asia region: a systematic review. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 25, 100357. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100357>
- Syairaji, M., Nurdiati, D. S., Wiratama, B. S., Prüst, Z. D., Bloemenkamp, K. W. M., & Verschueren, K. J. C. (2024). Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06687-6>
- Graham, K., Colquhoun, S., LaBond, C., Housen, T., Mohale, H., Campbell, S., & Sweet, L. (2025). The preparedness and readiness of rural and remote primary care midwives working in low- and middle-income countries: A scoping

- review. *Women and Birth*, 38(2), 101866. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2024.101866>
- Pezaro, D. S., Zarbiv, G., JONES, J., Feika, M. L., Fitzgerald, L., Lukhele, S., Mcmillan-bohler, J., Baloyi, O. B., Maravic da Silva, K., Grant, C., Bayliss-Pratt, L., & Hardtman, P. (2024). Characteristics of strong midwifery leaders and enablers of strong midwifery leadership: An international appreciative inquiry. *Midwifery*, 132(March), 103982. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.103982>
- Lewis, M. (2025). Midwifery Leadership in a Changing World—Why Is This So Challenging? A Reflective Commentary. *Healthcare (Switzerland)*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/healthcare13192473>
- Septiono, W., Siagian, F. P., Lazuardi, L., Handayani, S., & Prasetyo, S. (2025). Lessons of practices of community-based maternal and child health surveillance system during and post COVID-19 in Indonesia. *Global Health Action*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2025.2547438>
- Widyaningsih, V., Mohanty, I., Mulyaningsih, T., Gebremedhin, T. A., Miranti, R., Zaen, N. A., Nugroho, S. D., Azmiardi, A., & Probandari, A. (2025). Exploring the Multilevel Determinants of Suboptimal Maternal and Child Continuum of Care in Indonesia. *Maternal and Child Health Journal*, 29(7), 919–931. <https://doi.org/10.1007/s10995-025-04110-w>
- Noviari, D., & Hasanah, N. (2025). *Konsep dan filsafat kepemimpinan dalam ilmu kebidanan: sebuah tinjauan naratif*. 3(2), 1697–1730.
- Mahayani, N. M. H. (2020). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Igbaekemen, G. O. (2015). Public policy and administration research. *Policy Analysis in Taiwan*, 4(9), 187–206. <https://doi.org/10.56687/9781447308317-016>

BAB 5

PENGEMBANGAN KARIER DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

A. Pendahuluan

Sistem kesehatan nasional merupakan suatu kerangka terintegrasi yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan pembangunan kesehatan secara komprehensif, berkesinambungan, dan terarah. Dalam konteks Indonesia, sistem ini tidak hanya berorientasi pada upaya pengobatan (kuratif), tetapi juga menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Efektivitas sistem kesehatan nasional sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan kesehatan (Christy, Sebtalesty, & Kusumawati, 2024)

Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam sistem tersebut adalah bidan. Bidan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang sekaligus menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan kesehatan nasional. Tingkat profesionalisme bidan terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, khususnya pada layanan kesehatan tingkat pertama (Amalia & Riza, 2022)

Kepemimpinan yang kuat dalam kebidanan sangat penting jika melihat tantangan yang dihadapi profesi. Namun, seperti Jo Coggins menjelaskan, ada sejumlah hambatan yang harus diatasi dalam rangka untuk memperbaiki ini dan mendukung komitmen untuk wanita-berpusat perawatan. Bidan telah memfasilitasi suatu budaya kerja yang mendukung dan pmaaktif di mana setiap individu didorong untuk secara teratur menilai dan memperban pengetahuan mereka untuk kepentingan praktik mereka sendiri dan uonik melindungi Keselamatan perempuan dan bayi dalam perawatan mereka (Juanda & Cantika, 2023).

Profesionalisme bidan merupakan fondasi normatif yang memastikan bahwa seluruh praktik kebidanan berjalan sesuai standar etika, kompetensi, dan akuntabilitas. Profesionalisme tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga internalisasi nilai-nilai moral seperti empati, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik modern, profesionalisme bidan juga erat kaitannya dengan penerapan evidence-based practice, peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, serta kemampuan refleksi kritis terhadap praktik

klinis. Standar ini secara kelembagaan diperkuat oleh Ikatan Bidan Indonesia dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya mutu dan keselamatan pasien dalam setiap layanan kebidanan (Renfrew, 2021).

Seiring dengan perkembangan sistem kesehatan, tuntutan terhadap profesi bidan juga mengalami perubahan yang cukup kompleks. Bidan tidak hanya dituntut menguasai keterampilan klinis, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam manajemen serta kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan sistem kesehatan modern yang menuntut adanya kolaborasi lintas sektor serta kemampuan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam pelayanan kesehatan (Naratif 2025). Aspek kepemimpinan dalam praktik kebidanan menjadi semakin penting, terutama dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dalam banyak situasi, bidan berperan sebagai figur pemimpin di lingkungan komunitas yang mampu memberikan edukasi serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam kebidanan merupakan bagian dari kompetensi esensial yang harus dimiliki untuk menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan (Ikatan Bidan Indonesia, 2022)

Dengan demikian, kepemimpinan dan profesionalisme bidan merupakan dua aspek yang memiliki peranan krusial dalam mendukung kinerja sistem kesehatan nasional. Kajian terhadap kedua aspek ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana kontribusi bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus menjawab tantangan yang terus berkembang dalam sistem kesehatan di masa mendatang.

B. Profesionalisme Bidan dalam Pelayanan Kesehatan

Profesionalisme bidan merupakan manifestasi sikap dan perilaku yang mencerminkan penguasaan kompetensi, integritas etika, tanggung jawab profesional, serta komitmen terhadap standar praktik kebidanan. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, profesionalisme tidak hanya dimaknai sebagai keterampilan teknis semata, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan humanistik yang berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme bidan memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan (Midwives 2021).

Standar kompetensi bidan di Indonesia mencakup kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana. Selain itu, bidan juga memiliki tanggung jawab yang bersifat

holistik dalam mendampingi perempuan pada setiap fase kehidupan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa klimakterium. Pendekatan ini menegaskan bahwa praktik kebidanan tidak bersifat parsial, melainkan berorientasi pada kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) yang berpusat pada kebutuhan perempuan (Kementrian Kesehatan, 2020)

Dalam praktiknya, profesionalisme bidan diwujudkan melalui berbagai indikator yang mencerminkan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP)

Bidan wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan pedoman klinis yang telah ditetapkan guna menjamin keselamatan pasien dan meminimalkan risiko kesalahan medis.

2. Penerapan kode etik profesi

Setiap tindakan kebidanan harus berlandaskan prinsip etika, seperti menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, serta bertindak secara adil dan tidak diskriminatif

3. Pengambilan keputusan berbasis evidence (*evidence-based practice*)

Bidan dituntut untuk menggunakan bukti ilmiah terkini dalam menentukan intervensi yang tepat, sehingga pelayanan yang diberikan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan terukur

4. Komunikasi efektif dengan pasien dan tim kesehatan

Kemampuan komunikasi interpersonal menjadi kunci dalam membangun hubungan terapeutik dengan pasien serta meningkatkan koordinasi dalam tim kesehatan (Nurdiana, 2025).

Literatur kebidanan menegaskan bahwa profesionalisme tidak bersifat statis, melainkan harus terus dikembangkan melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Bidan dituntut untuk mengikuti pelatihan, seminar, serta pendidikan lanjutan guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem kesehatan, termasuk digitalisasi layanan, menjadi bagian integral dari profesionalisme di era modern (Renfrew, 2021). Namun demikian, implementasi profesionalisme bidan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pengembangan kompetensi, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta tingginya beban kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan apabila tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan dan sistem yang memadai (Amalia & Riza, 2022)

Dengan demikian, profesionalisme bidan merupakan fondasi utama dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Penguatan profesionalisme

tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.

C. Implementasi Profesionalisme Bidan

1. Orientasi pada Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Profesionalisme bidan pada era sistem kesehatan modern ditandai oleh komitmen kuat terhadap keselamatan pasien sebagai prinsip fundamental dalam setiap tindakan pelayanan. Konsep patient safety tidak lagi dipahami sebatas pencegahan kesalahan medis, tetapi telah berkembang menjadi pendekatan sistemik yang mencakup identifikasi risiko, manajemen insiden, serta budaya keselamatan (safety culture) di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktik kebidanan, orientasi keselamatan pasien mencakup penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), deteksi dini komplikasi obstetri dan neonatal, serta pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Bidan dituntut untuk mampu mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, serta melakukan intervensi sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pelayanan kebidanan memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi.

Profesionalisme dalam konteks keselamatan pasien juga berkaitan dengan kemampuan komunikasi efektif, baik dengan pasien maupun tim kesehatan. Komunikasi yang jelas dan terstruktur dapat meminimalkan kesalahan medis serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan standar global yang dikembangkan oleh World Health Organization yang menekankan pentingnya integrasi keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2021). Namun demikian, implementasi patient safety di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sistem pelaporan insiden, kurangnya pelatihan keselamatan pasien, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keselamatan pasien melalui regulasi, pelatihan berkelanjutan, serta supervisi yang efektif oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan manifestasi konkret dari profesionalisme bidan dalam menjamin kualitas dan konsistensi pelayanan kesehatan. SOP berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur setiap tahapan tindakan medis, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, hingga intervensi klinis. Kepatuhan terhadap SOP tidak hanya

memastikan bahwa pelayanan dilakukan secara sistematis dan terukur, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan legalitas praktik kebidanan. Dalam konteks ini, SOP berperan sebagai mekanisme kontrol kualitas (quality assurance) yang mampu meminimalkan variasi praktik klinis serta mencegah terjadinya kesalahan medis.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap SOP memiliki korelasi positif dengan peningkatan mutu pelayanan dan penurunan angka komplikasi klinis (International Confederation of Midwives, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme bidan tidak dapat dilepaskan dari komitmen terhadap standar yang telah ditetapkan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Namun, implementasi SOP di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya supervisi. Dalam beberapa kasus, SOP belum sepenuhnya diadaptasi dengan kondisi lokal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara standar dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual dalam penerapan SOP, termasuk penyesuaian dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip keselamatan dan kualitas pelayanan.

3. Praktik Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Praktik berbasis bukti (evidence-based practice) merupakan pilar utama profesionalisme bidan dalam menghadapi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Pendekatan ini menuntut bidan untuk mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Dalam konteks kebidanan, penerapan evidence-based practice berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, efisiensi intervensi, serta keselamatan pasien. Misalnya, penggunaan protokol berbasis bukti dalam manajemen persalinan dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan outcome maternal dan neonatal.

Praktik berbasis bukti juga memperkuat akuntabilitas profesi bidan dalam memberikan layanan yang rasional dan terukur. Bidan tidak hanya bertindak berdasarkan pengalaman atau kebiasaan, tetapi juga berdasarkan hasil penelitian terbaru yang telah teruji secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan standar kompetensi global yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia dan International Confederation of Midwives. Meskipun demikian, implementasi evidence-based practice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap jurnal ilmiah, rendahnya literasi penelitian di kalangan tenaga kesehatan, serta kurangnya budaya penelitian dalam praktik klinis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendidikan dan pelatihan

berbasis riset, serta penyediaan akses terhadap sumber informasi ilmiah yang relevan dan mutakhir. Dalam perspektif ke depan, integrasi teknologi digital seperti clinical decision support system dan telemedicine berpotensi mempercepat adopsi praktik berbasis bukti dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian, profesionalisme bidan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang terus berkembang.

D. Fungsi dan Peran Sistem Informasi Kesehatan

Dalam sistem kesehatan nasional, bidan menempati posisi strategis terutama pada pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Peran ini menjadi sangat penting mengingat pendekatan pelayanan kesehatan modern tidak lagi berfokus pada pengobatan semata, tetapi juga pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidan berkontribusi secara langsung dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa kehamilan hingga pasca persalinan (World Health Organization, 2021).

Fokus utama pelayanan kebidanan terletak pada kegiatan promotif dan preventif, seperti edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat, serta deteksi dini risiko kehamilan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan kesehatan yang menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menjaga kesehatannya. Dengan demikian, bidan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam meningkatkan perilaku hidup sehat di masyarakat (KEMENKES, 2023)

Dalam menjalankan perannya, bidan memiliki beberapa fungsi utama yang bersifat multidimensional, yaitu:

1. Edukator, dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat

Bidan berperan dalam memberikan penyuluhan terkait kesehatan ibu dan anak, gizi, serta perencanaan keluarga. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri (Renfrew, 2021).

2. Fasilitator, dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas

Bidan membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk melalui kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, serta program kesehatan berbasis masyarakat lainnya.

3. Advokator, dalam memperjuangkan kebijakan kesehatan ibu dan anak

Bidan berperan dalam menyuarakan kebutuhan kesehatan masyarakat kepada pemangku kebijakan, serta mendorong implementasi program kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak (Juanda & Cantika, 2023).

4. Kolaborator, dalam kerja tim interprofesional

Dalam sistem kesehatan modern, bidan bekerja sama dengan berbagai tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, dan tenaga gizi. Kolaborasi ini penting untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi. Peran-peran tersebut sejalan dengan konsep promosi kesehatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat (empowerment) dan perubahan perilaku sebagai kunci utama dalam meningkatkan derajat kesehatan. Bidan menjadi aktor penting dalam proses ini karena memiliki kedekatan dengan masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi sosial budaya setempat.

Selain itu, bidan juga memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan. Dalam praktiknya, bidan berperan dalam melakukan deteksi dini terhadap risiko komplikasi serta memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat melalui sistem rujukan berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas rujukan lanjutan. Integrasi ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas sistem kesehatan nasional serta menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan (WHO, 2021). Dengan demikian, peran bidan dalam sistem kesehatan nasional tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, sosial, dan manajerial yang berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

E. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Kebidanan

1. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan peran dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai pribadi serta kemampuan membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan proses pembelajaran yang pernah dilakukan.

b. Aspek-Aspek Kompetensi Bidan

(Frenk & Chen, 2022) mengatakan kompetensi bidan meliputi tiga aspek yaitu;

- 1) Aspek pengetahuan (Knowledge)
- 2) Aspek Keterampilan (Skill)
- 3) Aspek perilaku (Attitude)

c. Area Kompetensi Bidan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 Tentang standar Profesi Bidan, Kompetensi Bidan terdiri dari 7 (Tujuh) area kompetensi meliputi;

- 1) Etik legal dan keselamatan klien,
- 2) Komunikasi efektif
- 3) Pengembangan diri dan profesionalisme
- 4) Landasan ilmiah praktik kebidanan
- 5) Keterampilan Klinis dalam praktik kebidanan
- 6) Promosi kesehatan dan konseling
- 7) Manajemen dan kepemimpinan

2. Profesionalisme

a. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme adalah komitmen para professional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga prrofessional, usaha terus menerus untuk mengembangkan kemampuan rofessional.

Profesionalisme adalah cara kerja yang lebih dominan oleh sikap, bukan hanya satu set daftar dari skill dan kompetensi yang dimiliki. Dapat dicermati bahwa attitude adalah sikap mendasar, sementara skill adalah suatu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Profesionalisme saat ini menjadi bentuk yang harus melekat pada sikap entitas, berinteraksi dalam pasar global. Jika tidak, maka dihadapkan dengan satu pilihan termaginalkan dan collaps.

Profesionalisme berarti memiliki sifat profesional yang dimiliki oleh seorang bidan. Bidan profesional termasuk rumpun kesehatan , untuk menjadi jabatan profesional memiliki 9 syarat bidan profesinal, meliputi :

- 1) Ilmu sosial, budaya, kesehatan masyarakat, konsep kebidanan, etika, kode etik, kebidanan yang membentuk dasar dari asuhan yang berkualitas.
- 2) Asuhan ibu hamil
- 3) Asuhan kebidanan ibu melahirkan
- 4) Kebidanan asuhan ibu nifas menyusui
- 5) Asuhan bayi lahir

- 6) Asuhan pada bayi balita
 - 7) Keluarga berencana
 - 8) Gangguan reproduksi
 - 9) Kebidanan komunitas
- b. Aspek-Aspek Profesionalisme Aspek profesionalisme terdiri dari : 8
- 1) Aspek potensial, yaitu memiliki potensi hereditas yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi itu antara lain daya ingat, daya berfikir, bakat dan minat, motivasi.
 - 2) Aspek profesionalisme atau vokasional, yaitu memiliki kemampuan dan ketrampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan ketrampilan yang dapat mengabdikan dirinya dalam bekerja dan menciptakan hasil secara optimal.
 - 3) Aspek fungsional, yaitu melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna dengan bekerja sesuai tugas fungsinya.
 - 4) Aspek operasional, yaitu mendayagunakan kemampuan dan ketrampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya.
- c. Karakteristik dan Ciri Profesionalisme Karakteristik dan ciri profesionalisme antara lain :
- 1) Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
 - 2) profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
 - 3) Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
 - 4) Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
 - 5) Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.
- d. Dimensi Profesionalisme
- Sikap Profesionalisme merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya, yang dinilai melalui lima dimensi yaitu :
- 1) Pengabdian pada profesi. Profesionalisme adalah suatu pandangan yang dicerminkan oleh dedikasi seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini berkaitan dengan keteguhan tekad individu untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan intrinsik berkurang. Sikap pada dimensi ini merupakan ekspresi diri total terhadap pekerjaannya.

- 2) Kewajiban Sosial Dimensi ini menjelaskan manfaat yang diperoleh, baik oleh masyarakat dengan adanya suatu pekerjaan maupun bagi yang profesional.
- 3) Kemandirian. Dimensi ini menyatakan bahwa profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Rasa kemandirian berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut pekerja yang bersangkutan dalam situasi khusus.
- 4) Keyakinan terhadap profesi. Keyakinan bahwa yang paling berhak dalam menilai kinerja profesional adalah bukan pihak yang tidak membunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi profesionalitas mensyaratkan adanya ikatan profesi baik dalam organisasi formal maupun kelompok kolega informal sebagai sumber utama ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran terhadap profesinya.

e. Indikator Profesionalisme Bidan

1) Kode Etik Profesi

Dalam menjalankan praktiknya bidan menjalankan kode etik profesi bidan dengan menerapkan standar praktik profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal sebagai pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesi. Didalam kode etik profesi bidan memiliki prinsip utama antara lain kewajiban memprioritaskan kebutuhan klien, menghormati hak klien dan norma masyarakat, kewajiban menyediakan asuhan, konsultasi dan rujukan, menjaga kerahasiaan informasi, kewajiban mendukung sejawat dan profesi lain, kewajiban menjaga nama baik dan menjunjung Tinggi citra profesi, kewajiban mengembangkan pengetahuan dan praktek kebidanan, kewajiban berpartisipasi melaksanakan, kebijakan pemerintah, terutama KIA, Kesga, dan masyarakat.

Kode etik profesi bidan terdapat dalam mukadimah yang berisi antara lain kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat yaitu:

- a) Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
- b) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

- c) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman padaperan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
 - d) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentinganklien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai- nilai yang berlaku dimasyarakat.
 - e) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukankepentingan klien, keluarga dan masyarakat denganj indentitas yangsama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
 - f) Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasimasyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.
- 2) Kewajiban terhadap tugasnya yaitu ;
- a) Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesiyang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
 - b) Setiap bidan berhal memberikan pertolongan dan mempunyaikewenangan dalam mengambil keputusan mengadakan konsultasi danatau rujukan.
 - c) Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat danatau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilanatau diperlukan sehubungan kepentingan klien.
- 3) Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya yaitu;
- a) Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
 - b) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 4) Kewajiban bidan terhadap profesinya yaitu;
- a) Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelatyanan yang bermutu kepada masyarakat.
 - b) Setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- c) Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
- 5) Kewajiban bidan terhadap diri sendiri yaitu;
 - a) Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
 - b) Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa dan tanah air yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat, setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga.
- 6) Tanggung Jawab

Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan dilakukan pada periode antenatal, intranatal dan postnatal. Sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dibagi dalam dua aspek sebagai berikut aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas jabatan yang diperbuat.

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban dalam hukum yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Berkaitan dengan fungsi bidan, maka bidan mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi yang mandiri dalam asuhan kebidanan, sementara dalam fungsi kolaborasi bertanggung

jawab pada dokter yang berwenang melakukan tindakan. Bidan harus memiliki tanggung gugat dalam untuk memberikan alasan atas tindakannya. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan profesinya. Bidan harus mampu menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya. Tanggung gugat professional memiliki tujuan sebagai berikut untuk mengevaluasi praktisi professional baru dan mengkaji ulang yang telah ada, untuk mempertahankan standar perawatan kesehatan, untuk memudahkan refleksi pribadi, pemikiran etis dan pertumbuhan pribadi pada pihak professional perawatan kesehatan, untuk memberikan dasar pengambilan keputusan etis.

Berikut ini bentuk tanggung jawab bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan antara lain tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat yaitu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya; setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan; setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat; setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat; setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya; setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya yaitu setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat; setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan; setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya yaitu setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi;

setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun lainnya. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya yaitu setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat; setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK; setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Tanggung jawab bidan terhadap pemerintah yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan kegiatan- kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat; setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama KIA/KB dan keluarga.

Bentuk tanggung jawab bidan terdiri dari mematuhi peraturan perundang-undangan tentang kebidanan yang berlaku, memberikan informasi dan saran kepada keluarga dengan baik, memberikan informasi kepada pasien tentang pemeriksaan yang diperlukan dalam melakukan diagnosis kehamilan berisiko, melakukan pencatatan dan pelaporan pada setiap pelayanan yang telah diberikan, melakukan pelayanan kebidanan kepada ibu mulai dari periode antenatal, intranatal dan postnatal, melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan jika terjadi kasus kegawatdaruratan, melakukan perawatan kepada ibu dan bayi.

7) Melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat

Dalam kebidanan kolaborasi interprofessional sangat penting untuk keselamatan pasien. Karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi.

Perbedaan antara professional dapat menjadi penghalang bagi kolaborasi interprofessional. Pandangan berbeda tentang kehamilan dan persalinan merupakan bagian dari perbedaan pendidikan, tanggung jawab akan menjadikan suatu intervensi medis. Dalam kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, saling percaya, adanya pemahaman masing-masing individu dan memiliki tujuan yang sama serta tanggung jawab. Ini merupakan aspek penting dalam kolaborasi dan bila tidak dilakukan akan membuat kolaborasi interprofessional sulit serta meningkatkan risiko pada pasien. Dalam tim multidisiplin itu penting bahwa

ide tentang kebutuhan perawatan pasien dan persepsi kolaborasi di antara proses perawatan pasien.

Kolaborasi merupakan hubungan saling berbagi tanggung jawab (kerjasama) dengan rekan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya dalam memberi asuhan kepada pasien. Dalam praktiknya, kolaborasi dilakukan dengan mendiskusikan diagnosis pasien serta bekerjasama dalam penatalaksanaan dan pemberian asuhan.

Pelayanan kebidanan kolaborasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan ini adalah berbagi otoritas dalam pemberian pelayanan berkualitas sesuai ruang lingkup masing-masing. Elemen dalam melakukan kolaborasi antara lain harus melibatkan tenaga ahli dengan keahlian yang berbeda, yang dapat bekerjasama secara timbal balik dengan baik, anggota kelompok harus bersikap tegas dan mau bekerjasama, kelompok harus memberi pelayanan yang keunikannya dihasilkan dari kombinasi pandangan dan keahlian yang diberikan oleh setiap anggota tim tersebut.

Dalam kebidanan tugas bidan dalam melakukan rujukan dan kolaborasi antara lain menerapkan manajemen kebidanan ,pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, mencakup;

- a) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan yang memerlukan tindakan di luar lingkup kewenangan bidan dan memerlukan rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas serta sumber-sumber dan fasilitas untuk kebidanan intervensi lebih lanjut bersama klien/keluarga.
- c) Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang dengan dokumentasi yang lengkap.
- d) Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawatdaruratan, mencakup ;

- a) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.
- c) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- d) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan.

- e) Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- f) Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup;

- a) Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada ibu dalam persalinan yang memerlukan konsultasi dan rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas
- c) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- d) Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- e) Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup;

- a) Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada ibu dalam masa nifas yang memerlukan konsultasi serta rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.
- c) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- d) Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- e) Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga, mencakup;

- a) Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada bayi baru lahir yang memerlukan konsultasi serta rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.
- c) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- d) Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- e) Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.

Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan

tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan yang memerlukan konsultasi serta rujukan;

- a) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.
- b) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- c) Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- d) Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga, mencakup;

- a) Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada bayi baru lahir yang memerlukan konsultasi serta rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.
- c) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- d) Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- e) Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.

Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup;

- a) Mengkaji adanya penyulit dan kegawatdaruratan pada balita yang memerlukan konsultasi serta rujukan.
- b) Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.
- c) Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
- d) Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
- e) Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan di Belanda tentang kolaborasi interprofessional dalam pelayanan kebidanan yaitu secara keseluruhan, kolaborasi interprofessional bagus dan kompleks dalam pelayanan kebidanan. Namun menunjukkan beberapa perbedaan dalam timbal balik persepsi kolaborasi interprofessional antara dokter kandungan, bidan dan perawat. Perbedaan dalam persepsi timbal balik yaitu tentang berbagai pendapat, mendiskusikan praktik-praktik baru dan menghormati satu sama lain. Perbedaan persepsi kolaborasi dan konsep juga terkait dalam melakukan operasi caesar. Perbedaan antara dokter dan anggota tim

lainnya mengenai kerja tim, komunikasi dan situasional.

Upaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan pelatihan tim. Program pelatihan tim telah dikembangkan, seperti Manajemen Sumber Daya dan Strategi Tim untuk Meningkatkan Kinerja dan Keselamatan Pasien. Intervensi dilakukan dengan peningkatan kompetensi kerja tim, seperti komunikasi, kinerja situasional, kepemimpinan, kejelasan peran dan koordinasi. Intervensi pelatihan tim membantu meningkatkan pemahaman bersama dan mengurangi perbedaan dalam persepsi kolaborasi.

F. Integrasi Kepemimpinan dan Profesionalisme

1. Sinergi Kepemimpinan dan Profesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan

Integrasi antara kepemimpinan dan profesionalisme merupakan konstruksi multidimensional yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Dalam perspektif teoritis, kepemimpinan menyediakan kerangka strategis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan, sementara profesionalisme menjadi landasan normatif yang memastikan setiap tindakan tetap berada dalam koridor etika, standar praktik, dan akuntabilitas. Sinergi ini tidak bersifat linear, melainkan interdependen. Kepemimpinan tanpa profesionalisme berpotensi menghasilkan keputusan yang pragmatis namun mengabaikan aspek etik dan keselamatan pasien. Sebaliknya, profesionalisme tanpa kepemimpinan akan membatasi peran bidan pada fungsi teknis semata tanpa kemampuan mempengaruhi sistem. Oleh karena itu, integrasi keduanya menghasilkan apa yang dalam literatur modern disebut sebagai *clinical leadership professionalism*, yaitu kemampuan memimpin yang berakar pada nilai-nilai profesional.

Dalam konteks sistem kesehatan nasional, sinergi ini juga memperkuat peran bidan sebagai *change agent* yang mampu mengintegrasikan kebijakan kesehatan dengan praktik di lapangan. Kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya penguatan kapasitas tenaga kesehatan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga kepemimpinan dan etika profesi. Hal ini sejalan dengan kerangka global yang dikembangkan oleh WHO (2021) yang menempatkan tenaga kesehatan sebagai pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan.

2. Dampak Integrasi terhadap Kualitas Pelayanan

Integrasi antara kepemimpinan dan profesionalisme memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Bidan yang mampu menginternalisasi kedua aspek ini menunjukkan kinerja yang lebih

adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan maternal dan neonatal. Dampak integratif ini dapat dilihat dalam beberapa dimensi. Pertama, peningkatan mutu layanan (quality of care) yang ditandai dengan kepatuhan terhadap standar klinis, penurunan kesalahan medis, serta peningkatan keselamatan pasien. Kedua, peningkatan kepuasan pasien yang dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, empati, dan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care). Ketiga, peningkatan efektivitas sistem pelayanan yang tercermin dari koordinasi layanan yang lebih baik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan program kesehatan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mengintegrasikan kepemimpinan transformasional dengan profesionalisme memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome kesehatan dan kinerja organisasi (Cumplings, Tate, Lee, & Wong, 2023). Selain itu, integrasi ini juga berperan dalam meningkatkan resilience sistem kesehatan, terutama dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi dan bencana kesehatan. Dengan demikian, integrasi kepemimpinan dan profesionalisme tidak hanya berdampak pada individu bidan, tetapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kedua aspek tersebut merupakan investasi strategis dalam pembangunan kesehatan jangka panjang.

3. Penguatan Kurikulum Pendidikan Bidan

Penguatan integrasi kepemimpinan dan profesionalisme perlu dimulai dari sistem pendidikan bidan sebagai fondasi pembentukan kompetensi. Kurikulum pendidikan bidan harus dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan kompetensi klinis, kepemimpinan, komunikasi, manajemen kesehatan, serta etika profesi dalam satu kerangka pembelajaran yang terpadu. Pendekatan pendidikan berbasis kompetensi (competency-based education) menjadi strategi yang relevan dalam konteks ini. Kurikulum tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta kepemimpinan dalam situasi klinis yang kompleks. Selain itu, metode pembelajaran berbasis kasus (case-based learning) dan simulasi klinis dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan integratif antara kepemimpinan dan profesionalisme (Campbell, Dussault, & Buchan, 2021).

Organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kurikulum pendidikan bidan selaras dengan standar kompetensi nasional dan global. Standar yang ditetapkan oleh (International Confederation of Midwives, 2021) juga menekankan pentingnya integrasi

kepemimpinan dalam pendidikan kebidanan sebagai bagian dari kompetensi inti bidan.

Namun demikian, tantangan dalam pengembangan kurikulum masih mencakup kesenjangan antara teori dan praktik, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, penguatan kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas dosen dalam mengembangkan pembelajaran berbasis integrasi. Dalam perspektif ke depan, kurikulum pendidikan bidan harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam penguatan sistem kesehatan nasional (Notoadmodjo, 2014).

G. Penutup

Kepemimpinan dan profesionalisme bidan merupakan dua dimensi strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung efektivitas sistem kesehatan nasional. Dalam konteks transformasi kesehatan yang menekankan pada penguatan layanan primer, bidan berperan sebagai aktor kunci yang tidak hanya menjalankan fungsi klinis, tetapi juga sebagai pemimpin di lini terdepan (frontline leader) yang mampu mengintegrasikan kebijakan dengan praktik di lapangan. Kepemimpinan bidan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi sistem, serta keselamatan pasien.

Profesionalisme bidan menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa setiap tindakan pelayanan dilakukan sesuai dengan standar etika, kompetensi, dan akuntabilitas. Implementasi profesionalisme tercermin dalam orientasi pada keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta penerapan praktik berbasis bukti. Namun demikian, dalam realitas empiris masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan pelatihan berkelanjutan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta beban kerja yang tinggi, yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kebidanan.

Integrasi antara kepemimpinan dan profesionalisme menjadi faktor kunci dalam menciptakan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sinergi kedua aspek ini tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu layanan dan kepuasan pasien, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan kesehatan di masa depan. Dengan demikian, penguatan kepemimpinan dan profesionalisme bidan

merupakan investasi strategis dalam pembangunan kesehatan nasional yang berorientasi jangka panjang.

Referensi

- Amalia, & Riza. (2022). Promosi Kesehatan dalam Kebidanan. *Jurnal Kesehatan Dasar*.
- Campbell, J., Dussault, G., & Buchan, J. (2021). A universal truth: No health without a workforce—strengthening health workforce leadership. *Human Resources for Health*.
- Christy, J. D., Sebtalesty, C. Y., & Kusumawati, L. H. (2024). Bunga Rampai Pengembangan Diri dan Profesionalitas Untuk DIII Kebidanan. *Jurnal Psikologi UNESA*.
- Cummings, G. G., Tate, K., Lee, S., & Wong, C. (2023). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*. *International Journal Of Nurshing Studies*.
- Frenk, J., & Chen, L. (2022). Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems. *The Lancet*.
- Griffin, & Georgia. (2024). Strengthening midwifery in the South-East Asian region . *A scoping review of midwifery-related research*.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2022). *Kode Etik Bidan Indonesia*. Jakarta: IBI.
- International Confederation of Midwives. (2021). *Essential competencies for midwifery practice*. . The Hague: ICM.
- Juanda, & Cantika. (2023). Konsep dan filsafat kepemimpinan dalam ilmu kebidanan: sebuah tinjauan naratif. *Jurnal Midwifery*.
- KEMENKES. (2023). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*. JAKARTA: KEMENKES RI.
- Kementrian Kesehatan. (2020). *Standar kompetensi bidan Indonesia*. Jakarta: KEMENKES RI.
- Notoadmodjo. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan (Edisi Revisi 2012)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdiana. (2025). Konsep dan filsafat kepemimpinan dalam ilmu kebidanan: sebuah tinjauan naratif. *Jurnal Kebidanan Naratif*.
- Renfrew, M. J. (2021). Midwifery and quality care: Findings from The Lancet Series. *The Lancet*.
- World Health Organization. (2021). *Emergency Obstetric and Newborn Care in Crisis Settings*. California: WHO.

PROFIL PENULIS



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Lahir di Bandung 03 Maret 1980, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2001, dilanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2003, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2012, menyelesaikan Pendidikan S2 Program studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara pada tahun 2023 serta saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan S3 di Prodi DKM Universitas Diponegoro. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 penulis bekerja di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian tahun 2003 bekerja sebagai Dosen tetap di Akbid Istara Nusantara dan Tahun 2004 bekerja di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta sampai sekarang.

Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan kebidanan pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Komplementer Evidence Based Midwifery. Penulis aktif di beberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku Kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, *workshop* dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imeldadiana33@gmail.com



Yuni Vivi Santri P, SKM., S.Keb., MKM.

Lahir di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul yaitu di Sosorgonting, 06 Juni 1995. Menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua (DHDT), S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Senior Medan dan S2 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua (DHDT). Saat ini sedang menjalani pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat di MAHSA University Malaysia. Sampai saat ini juga, penulis sebagai Dosen Tetap di Universitas Senior Medan.

PROFIL PENULIS

Endang Mayasari, SST. M.Kes

Lahir di Pekanbaru, 18 September 1985, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu D3 kebidanan Poltekkes Depkes, S1 Kebidanan Universitas Padjajaran, S2 Kesehatan Masyarakat STIKes tangtuh Pekanbaru. Riwayat pekerjaan diawali tahun 2008 sebagai Dosen di Prodi D3 Kebidanan dan sekarang mengajar di prodi S21 Kebidanan Universitas pahlawan Riau. (. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : Endangmayasari85@gmail.com.
Motto: Libatkan Allah dalam segala hal kehidupanmu.



Dr. Gusti Ayu Martha Winingsih, S.ST, MM, M.Kes

adalah Dosen Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan D4 bidang Bidan Pendidik di Universitas Tribuana Tungadewi Malang, kemudian melanjutkan S2 bidang Manajemen SDM di Universitas Wijaya Putra Surabaya, S2 bidang Kesehatan Masyarakat KIA Kespro di Universitas Udayana Denpasar, serta menyelesaikan S3 bidang Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis memiliki keahlian di bidang kebidanan, manajemen sumber daya manusia, dan kesehatan ibu dan anak. Penulis aktif berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan maternal dan kebidanan. Informasi lebih lanjut dapat dihubungi melalui email: gekmartha@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb, M.Keb

Lahir di Bengkulu, 19 Agustus 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019-2022 sebagai Teknis Akademik dan Evaluasi D4 Kebidanan Alih Jenjang di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di STIKes Tri Mandiri Sakti Bengkulu mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Midwifery Disaster, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan dan Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan penelitian. Penulis mendapat hibah penelitian Kemenristekdikti tahun 2024 skema PDP Afirmasi dan hibah penelitian Kemdiktisaintek 2025 skema PDP. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anisahbidan23@gmail.com.

Motto: "Don't Be A Follower, Be A Story Maker"

Sinopsis

Buku referensi Kepemimpinan dan Profesionalisme Bidan dalam Sistem Kesehatan Nasional disusun sebagai rujukan komprehensif bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, praktisi, serta pemangku kepentingan kesehatan dalam memahami dan menguatkan peran strategis bidan dalam sistem kesehatan nasional. Dalam dinamika pelayanan kesehatan yang terus berkembang, bidan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kapasitas kepemimpinan, integritas profesional, serta kemampuan adaptif terhadap regulasi dan perubahan kebijakan kesehatan.

Pembahasan diawali dengan konsep profesionalisme dan etika kebidanan, yang menegaskan pentingnya nilai moral, tanggung jawab, akuntabilitas, serta komitmen terhadap keselamatan ibu dan bayi. Prinsip-prinsip etika profesi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis dan interaksi dengan perempuan, keluarga, serta komunitas. Profesionalisme bidan diposisikan sebagai fondasi kepercayaan publik sekaligus penentu mutu pelayanan kebidanan.

Selanjutnya, buku ini mengulas regulasi dan hukum praktik kebidanan dalam kerangka sistem kesehatan nasional. Aspek perizinan, kewenangan praktik, standar pelayanan, serta perlindungan hukum dibahas secara sistematis untuk memperkuat pemahaman bidan terhadap tanggung jawab dan batas praktik profesional. Pemahaman regulasi menjadi kunci dalam mencegah risiko hukum serta memastikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan.

Topik manajemen praktik mandiri bidan memberikan panduan mengenai pengelolaan layanan kebidanan secara profesional, mencakup aspek administrasi, manajemen mutu, pengelolaan sumber daya, dokumentasi, hingga pelayanan berbasis keselamatan pasien. Bab ini menekankan pentingnya tata kelola yang efektif guna menjamin keberlanjutan dan kualitas praktik mandiri.

Dalam konteks pelayanan maternal, buku ini membahas kepemimpinan dalam pelayanan maternal sebagai kemampuan strategis bidan dalam mengoordinasikan pelayanan, mengambil keputusan klinis yang tepat, serta menggerakkan tim untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal. Kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai jabatan struktural, tetapi sebagai kompetensi yang melekat dalam praktik profesional sehari-hari.

Pembahasan mengenai kolaborasi interprofesional menegaskan pentingnya kerja sama lintas profesi dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan. Bidan sebagai bagian dari tim kesehatan perlu memiliki keterampilan komunikasi, koordinasi, serta kemampuan membangun hubungan profesional yang efektif.

Buku ini juga menyoroti isu burnout dan kesejahteraan bidan, yang semakin relevan dalam menghadapi beban kerja dan tuntutan pelayanan yang tinggi. Strategi menjaga kesehatan fisik dan mental, keseimbangan kehidupan kerja, serta dukungan organisasi dibahas sebagai bagian dari upaya mempertahankan kinerja dan profesionalisme jangka panjang.

Sebagai penutup, topik pengembangan karier dan pendidikan berkelanjutan menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) untuk menjaga kompetensi, memperluas peran, serta meningkatkan kontribusi bidan dalam sistem kesehatan nasional. Penguatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sertifikasi menjadi bagian integral dari transformasi profesi kebidanan.

Secara keseluruhan, buku ini menghadirkan perspektif konseptual dan praktis yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi acuan akademik sekaligus panduan profesional dalam membangun kepemimpinan dan profesionalisme bidan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Buku referensi Kepemimpinan dan Profesionalisme Bidan dalam Sistem Kesehatan Nasional disusun sebagai rujukan komprehensif bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, praktisi, serta pemangku kepentingan kesehatan dalam memahami dan menguatkan peran strategis bidan dalam sistem kesehatan nasional. Dalam dinamika pelayanan kesehatan yang terus berkembang, bidan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kapasitas kepemimpinan, integritas profesional, serta kemampuan adaptif terhadap regulasi dan perubahan kebijakan kesehatan.

Pembahasan diawali dengan konsep profesionalisme dan etika kebidanan, yang menegaskan pentingnya nilai moral, tanggung jawab, akuntabilitas, serta komitmen terhadap keselamatan ibu dan bayi. Prinsip-prinsip etika profesi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis dan interaksi dengan perempuan, keluarga, serta komunitas. Profesionalisme bidan diposisikan sebagai fondasi kepercayaan publik sekaligus penentu mutu pelayanan kebidanan.

Selanjutnya, buku ini mengulas regulasi dan hukum praktik kebidanan dalam kerangka sistem kesehatan nasional. Aspek perizinan, kewenangan praktik, standar pelayanan, serta perlindungan hukum dibahas secara sistematis untuk memperkuat pemahaman bidan terhadap tanggung jawab dan batas praktik profesional. Pemahaman regulasi menjadi kunci dalam mencegah risiko hukum serta memastikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan.

Topik manajemen praktik mandiri bidan memberikan panduan mengenai pengelolaan layanan kebidanan secara profesional, mencakup aspek administrasi, manajemen mutu, pengelolaan sumber daya, dokumentasi, hingga pelayanan berbasis keselamatan pasien. Bab ini menekankan pentingnya tata kelola yang efektif guna menjamin keberlanjutan dan kualitas praktik mandiri.

Dalam konteks pelayanan maternal, buku ini membahas kepemimpinan dalam pelayanan maternal sebagai kemampuan strategis bidan dalam mengoordinasikan pelayanan, mengambil keputusan klinis yang tepat, serta menggerakkan tim untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal. Kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai jabatan struktural, tetapi sebagai kompetensi yang melekat dalam praktik profesional sehari-hari. Pembahasan mengenai kolaborasi interprofesional menegaskan pentingnya kerja sama lintas profesi dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan. Bidan sebagai bagian dari tim kesehatan perlu memiliki keterampilan komunikasi, koordinasi, serta kemampuan membangun hubungan profesional yang efektif.

Buku ini juga menyoroti isu burnout dan kesejahteraan bidan, yang semakin relevan dalam menghadapi beban kerja dan tuntutan pelayanan yang tinggi. Strategi menjaga kesehatan fisik dan mental, keseimbangan kehidupan kerja, serta dukungan organisasi dibahas sebagai bagian dari upaya mempertahankan kinerja dan profesionalisme jangka panjang.

Sebagai penutup, topik pengembangan karier dan pendidikan berkelanjutan menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) untuk menjaga kompetensi, memperluas peran, serta meningkatkan kontribusi bidan dalam sistem kesehatan nasional. Penguatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sertifikasi menjadi bagian integral dari transformasi profesi kebidanan.

Secara keseluruhan, buku ini menghadirkan perspektif konseptual dan praktis yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi acuan akademik sekaligus panduan profesional dalam membangun kepemimpinan dan profesionalisme bidan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-90-5 (PDF)



9

786347

556905

